

SO LONG COVID

Folge 1: Unheilbar krank

Lesefassung der deutschen Untertitel

Im Frühling 2020, also vor genau sechs Jahren, erleben wir etwas, das wir alle so noch nie erlebt haben. Das ist ein Appell des Bundesrates an die ganze Bevölkerung. Nehmt diese Massnahmen ernst. Lockdown, Abstandsregeln. Bleiben Sie, wenn immer möglich, zu Hause. Heute scheint da alles weit weg. Die Pandemie ist vorbei. Aber nicht für alle. Es gibt Menschen, für die hat Corona nie aufgehört. Eine davon ist Jasna Cotting. Ich bin Jasna.

Ich bin aus Fribourg, wie man vielleicht auch dann ein bisschen hören wird. Ich bin 32 Jahre alt und Assistenzärztin. Also in der Ausbildung zu einer "richtigen" Ärztin. Ihre erste Stelle als Assistenzärztin, in einem Schweizer Spital, hatte Jasna im Herbst 2020. Ich glaube, dann war ja auch gerade der zweite Lockdown ... Es war alles so ein bisschen... ..ich habe in einer Pandemie angefangen zu arbeiten. Und man weiss das. Das hat mein Hausarzt immer gesagt: In den ersten Jahren, wenn du als Arzt oder Ärztin arbeitest, bist du halt immer krank. Weil: du bist diesen Viren die ganze Zeit ausgesetzt.

Ergibt Sinn. Und es ergibt auch Sinn, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Jasna sich auch mit Covid ansteckt. Bei den meisten klingt die Infektion nach rund zwei Wochen wieder ab. Jasna aber wird einfach nicht mehr richtig gesund. Über Wochen und dann Monate. Und das ist jetzt definitiv nicht mehr normal. Ich habe mich keinen einzigen Tag gesund gefühlt. Und es war schrecklich. Sie hat starke Kopfschmerzen, Halsschmerzen, fühlt sich ausgelaugt.

So, als hätte sie konstant eine Grippe. Früher ist Jasna viel joggen gegangen, als Ausgleich zur Arbeit. Das geht jetzt nicht mehr. Also wenn ich wollte, dann hätte ich schon 10 Kilometer joggen können. Aber es ist mir dann auch so schlecht gegangen. halt diese typischen Crashes, von denen sie immer erzählen bei dieser Erkrankung. So, dass ich schliesslich im Winter 2023/2024 fast nicht mehr Treppen hochlaufen konnte. Die sportliche, lebensfreudige Jasna kann nicht mehr Treppen hochlaufen.

Dazu die vielen anderen Symptome. Besonders Sorgen macht ihr auch der Brain Fog. Was ist das für ein Zustand? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich war gaga. Gaga, das ist einfach alles nur noch so in einem Nebel. Und ich war gefühlt in meinem Kopf immer recht schnell und vif. Und das hat natürlich massiv eingeschränkt. Und ich hatte sehr Angst, dass ich nie mehr die Kognition zurückbekomme. Das war wirklich ganz, ganz schlimm für mich.

Manchmal hat Jasna Phasen, in denen es ihr ein bisschen besser geht. Aber nur kurz. Auch rund eineinhalb Jahre nach ihrer Infektion mit Corona, wacht sie zum x-ten Mal am Morgen auf und hat einen Crash. Sie fühlt sich wie überfahren. Dann habe ich wirklich gedacht: Scheisse. Entschuldigung... Dann ist mir auch ein bisschen aufgegangen, woran ich leide. es war natürlich immer schon... Meine Hausärztin, und ich ja auch, hatten immer schon so ein bisschen Long Covid im Kopf.

Ich habe das aber nicht wirklich abgeklärt, weil ich das wirklich von mir weggestossen habe. Und dann habe ich wirklich realisiert: Ja verdammt, ich bin eine chronische Schmerzpatientin. Ich habe chronische Fatigue. Ich habe das. Jasna hat Long Covid. Und dann bin ich in die Long-Covid-Sprechstunde gegangen. Und die haben gesagt, wenn es nichts anderes ist, dann ist es das. Voilà. Ich bin eigentlich immer jemand, der sich wieder aufrappeln kann.

Ja, ist gut, okay. Und jetzt, was machen wir? Und dann ist halt die Antwort, und das habe ich ja eigentlich schon gewusst, darum habe ich es auch so lange vor mir hergeschoben, ich wollte nicht dorthin, ich wollte nicht, dass diese Diagnose in meiner Akte steht, ja, dann haben sie mir gesagt: ja, man kann eigentlich nichts machen. Am Schluss habe ich gefragt: ja, wie ist denn die Aussicht oder Ihre Erfahrung? Ja, ein paar Patient:innen geht es schon besser nach einem Jahr.

Man muss einfach ein bisschen warten. Und ja, dann bin ich in Panik geraten, weil ich nicht wusste, was zu tun. In der Schweiz gibt es schätzungsweise 300'000 Menschen mit Long Covid. Darunter auch Kinder und

Jugendliche. Es ist eine undurchschaubare, diffuse Krankheit. Es gibt nur Hypothesen zu den Ursachen. Und bis heute keine anerkannte Behandlung, keine Medikamente, keine heilende Therapie. Darum gilt Long Covid aktuell als chronisch und unheilbar.

Mein Name ist Zita Bauer. Ich bin Journalistin und Sozialanthropologin. Und ich habe mich gefragt, ist die Situation für Betroffene von Long Covid wirklich so aussichtslos, wie sie häufig dargestellt wird? Weil es gibt Menschen, die genesen. Und das nicht spontan oder zufällig, sondern mit einem neuen Krankheitsverständnis und daraus abgeleiteten Behandlungsmethoden. Und Achtung Spoiler, unter ihnen ist auch Jasna. Und vielleicht kennst du auch die Geschichte der Radfahrerin Marlen Reusser.

Die nach einer schweren Long Covid-Erkrankung Weltmeisterin geworden ist. Und ich kann mittlerweile wieder ganz normal und freudig leben. Und bin sogar sehr erfolgreich unterwegs im Radsport, seit ich genesen bin. Ich habe jeden Tag mehr gemerkt, dass es greift und dass es der richtige Weg ist für mich. Und es ist dann auch wirklich schnell gegangen. Also das war dann erstaunlich. Es war dann fast ein wenig schwierig zu glauben und auch zu erzählen.

Aber es ist tatsächlich innerhalb von Wochen unendlich viel besser geworden. Vor allem habe ich auch realisiert, dass ich eigentlich schon seit Jahren an Krankheiten und chronischen Schmerzen leide, die eigentlich nicht da sein müssten, also die man eigentlich heilen kann. Marlen, Patricia, Jann und Jasna haben etwas gemeinsam: Sie alle haben entgegen allen Erwartungen Long Covid überwunden. Und sie sind keine Einzelfälle. Da geht es nicht um entweder oder, um die eine Wahrheit, sondern es geht um neurobiologische Erkenntnisse, deren Nutzung vielen Menschen eine Genesung ermöglicht hat.

Es geht um neue Methoden aus der modernen Schmerztherapie. Vielversprechend für Long Covid. Aber nicht nur. Auch für chronische Rückenschmerzen, Reizdarm, Migräne und für viele weitere Erkrankungen und Beschwerden, bei denen es bis jetzt heisst: medizinisch unerklärt. Wir finden keine Ursache. Es tut uns leid. Da kann man leider nichts machen. Es ist ein wirklicher Wechsel der Perspektive. Und es bietet unfassbar viel Potenzial.

Das ist «So Long Covid». Eine unabhängige Podcast-Serie von mir, Zita Bauer und Jann Zosso. Wir möchten mit diesem Podcast den aktuellen Diskurs rund um Long Covid ergänzen. Mit Genesungsgeschichten, fundiertem Wissen und realistischer Hoffnung. Folge 1: «Unheilbar krank» Ich habe mich nicht einfach so für Long Covid angefangen zu interessieren. Ich bin unfreiwillig mit dieser schweren Erkrankung in Berührung gekommen. Denn Jann, den wir vorher gehört haben, er ist mein Partner.

Also fangen wir ganz von vorne an. Wie hat alles angefangen? Also, Long Covid, hat mit Covid angefangen, Bevor es "long" geworden ist, quasi... Das war im Winter 2023. Und Covid hattest du nicht mega stark, einen sogenannten milden Verlauf, oder? Ja, ich war schon ziemlich krank. Aber dann bin ich... Also das Fieber ist weg. Das Halsweh ist weg. Aber nicht der Druck auf der Brust, der ist geblieben? Der ist länger geblieben, ja.

Ein Druck auf der Brust und im Rücken. So eine Enge, wie ein sehr ungutes Gefühl im Oberkörper. Das hätte ja normal sein können. Aber mit der Zeit hat es schon ein wenig Angst gemacht. Dass so etwas am Herzen sein könnte. Man hört ja so Geschichten von Herzmuskelentzündungen, die entstehen können. Ich erinnere mich, am Anfang machte ich mir noch nicht so Sorgen. Weil ich dachte, manchmal braucht man ja etwas länger, um sich zu erholen, wenn man krank war.

Und auch irgendwie... man hat doch immer irgendwie etwas, weisst du, immer tut doch etwas weh, oder... Ja, aber meistens sind es halt Sachen, die du schon kennst. Und wenn es etwas Neues ist, kann es dich ein wenig beunruhigen. Das stimmt. Und nachher, als es dann auch länger angehalten hat, habe ich mir dann schon auch Sorgen gemacht. Einfach um Jann von damals ein bisschen besser zu verstehen. Er ist Anfang 30, im Endspurt von seinem Doktorat an der ETH Zürich in theoretischer Physik.

Und er ist einer der sportlichsten Menschen, die ich kenne. Er spielt Eishockey, Badminton, macht Yoga. Geht im Sommer Biken und im Winter Langlaufen. Und wir sind ja dann relativ kurz nach deiner Covid-Infektion ins Engadin langlaufen gegangen. Und dort hast du schon ein wenig gemerkt, dass du nicht so fit warst. Genau, ja. Ich war müde, müder also sonst, auch am Tag. Und immer dieser Druck, der immer wieder verschwand, aber dann wieder da war.

Man hat nicht so ganz verstanden, wie es jetzt funktioniert. Und dann wollten wir den Engadiner machen, den Engadiner Skimarathon. Und dafür wollte man natürlich schon fit sein, eigentlich. Und dann war es aber ein wenig mein Glück, dass du nicht so fit warst. Weil dann sind wir zusammen gefahren. Genau. Dann bist du mir nicht davongefahren. Genau Jann hat sich nicht so fit gefühlt und darum entschieden, nicht Vollgas zu geben.

Sondern ein wenig langsamer zu fahren. Das war auch noch schön. Ja, für einen Tag. Ja. Aber eigentlich, hat es grundsätzlich schon Sorgen gemacht. Ja, dann bin ich noch auf Skitouren, die ich dann auch abbrechen musste. Und dann mit der Zeit, ja, war es wirklich sehr beunruhigend. Dann ist es losgegangen. Ja, das kann man so sagen. Jann ist immer wieder krank und hat diffuse, beängstigende Beschwerden. Schwindel, der plötzlich auftritt, und Brain Fog.

Also vor allem auch Sachen beim Gehirn, die schon Angst gemacht haben. Und auch nicht so ideal, um ein Doktorarbeit zu schreiben. Auch nicht so ideal, ja. Definitiv nicht. Jann ist nicht der Erste mit so undurchschaubaren Symptomen. Ein paar Monate nach dem Ausbruch der Pandemie hat man das erste Mal davon gelesen, dass sich Menschen nach einer Covid-Infektion nicht mehr erholen. Einer der Ersten, der davon berichtet hat, ist der britische Infektiologe Paul Garner, im Mai 2020.

Er ist selbst betroffen und schreibt im British Medical Journal von Kopfweh, Muskelschmerzen, von einer totalen Erschöpfung. Er sei wie eine Achterbahn, die einfach nicht aufhört. Er wüsste nie, was als nächstes kommt. Symptome kommen und gehen. Er sei völlig ausgeliefert. Und was genau die Ursache ist, das kann ihm niemand sagen. Erklären konnten wir es uns, ehrlich gesagt, nicht. Sondern man hat einfach gesehen, also rein aus der Beobachtung, dass es den Patienten schlecht ging.

sagt Iris Katharina Penner. Sie ist Professorin für kognitive Neurologie und Neuropsychologie am Inselspital Bern. Die kognitiven Veränderungen, die waren zum Teil so ausgeprägt, dass man sich das wirklich nicht erklären konnte. Die extreme Belastungsintoleranz der Patienten sicherlich auch nicht. Dann so dieses Nebel im Kopf, was die Patienten immer beschrieben haben. Dieses Konglomerat an Symptomen, das war schon etwas, was aussergewöhnlich war.

Dann kam erst dieser Begriff irgendwie Long Covid. Long, also länger Covid. Und dann irgendwann dann doch diese Definition der WHO, das als Post Covid zu bezeichnen. Das heisst, mindestens drei Monate müssen diese Symptome persistieren, dass ich diesen Begriff überhaupt einführen darf. Bevor Jann, mein Partner, krank geworden ist, war für mich Long Covid weit weg. Irgendwie unheimlich. Und vor allem extrem schwer fassbar. So geht es vielen.

Darum wollen wir in dieser Folge aufzeigen, was es bedeuten kann, die Diagnose Long Covid. Und das wird ziemlich heftig. Iris Katharina Penner leitet eine Sprechstunde im Inselspital und betreut dort Betroffene mit Fatigue. Ein sehr typisches Symptom für Long Covid. Und eines, das man auch kennt von anderen Krankheiten. Zum Beispiel Krebs oder Multiple Sklerose. Es ist komplett anders als normale Müdigkeit. Also wenn wir alle am Abend nach Hause gehen, sind wir müde.

Wir sind vielleicht auch ein bisschen erschöpft. Aber Fatigue ist etwas komplett anderes. Das ist wirklich so ein... Ja, sich so ausgelaugt fühlen und ausgezehrt fühlen von der Energie, dass man eigentlich den Tag nicht mehr bewältigen kann. Einkaufen gehen, kochen, Freund:innen treffen, was vorher selbstverständlich war, wird zur Herausforderung. Viele Betroffene können nur noch Teilzeit oder gar nicht mehr arbeiten. Long Covid in der schlimmsten Form ist vergleichbar mit der Krankheit ME/CFS.

Die Abkürzung für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. ME/CFS ist eine der grossen ungelösten Fragen in der Medizin. Ein Skandal, schreibt die Selbsthilfeorganisation ME/CFS Schweiz auf ihrer Webseite. Es ist eine Krankheit, die es schon lange vor Corona gab. Mit den vielen Long-Covid-Fällen verbunden ist die Hoffnung, dass jetzt endlich etwas geht. Mehr Forschung. Und irgendwann vielleicht sogar ein wirksames Medikament.

Charakteristisch bei ME/CFS und Long Covid sind die Crashes, die immer wieder auftreten. Crashes sind perfid. Du machst etwas, was dir Freude macht, aber vielleicht, vielleicht wird es dir schaden. Eine kurze Runde Joggen oder ein Nachtessen mit Freund:innen. Alles kann zu viel sein. Ja, du merkst, wie es sich anbahnt, und zeitversetzt, kommt ein riesiger Crash, der dich umhaut und wo du dann einen Tag lang im Bett liegst und leidest.

Crashes kommen meistens zeitversetzt. Die Rechnung kommt quasi erst am nächsten Tag. So eine Folter von unangenehmen Schmerzen und unangenehmen Gefühlen. Eine Folter, weil du nicht weisst, wann das wieder aufhört. Und wenn das immer wieder passiert. Jedes Mal, wenn es dir etwas besser geht oder wenn du Lust hast, wieder etwas zu machen, dann macht dich das wirklich fertig. Und jetzt wird es noch perfider. Es heisst, die Crashes führen zu irreparablen Schäden, die die Krankheit chronifizieren.

Je länger man krank ist und je mehr Crashes man hat, desto schwieriger sei es, jemals wieder gesund zu werden. Mit der Zeit war es wirklich so schlimm, dass es sehr ernsthaft mein Leben eingeschränkt hat und gar nicht mehr okay war. Janns gesundheitlicher Zustand aktuell ist folgender: Hmmm... er kann eigentlich nur im Bett liegen und wenn es gut geht, Hörbücher hören. Am Freitag zum Beispiel ging er dann irgendwann noch etwas raus spazieren.

Und auf dem Heimweg, der ungefähr 500 Meter lang ist, musste er dreimal anhalten und Pause machen. Und danach war er total kaputt. Das ist der Zustand. Im Winter 2024, knapp ein Jahr nach der Infektion, wird bei Jann die Diagnose gestellt: Post Covid. Später dann noch mit dem Zusatz ME/CFS. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es so lange dauert. Wegen den unspezifischen Symptomen, den vielen Abklärungen und langen Wartezeiten. Die Diagnose ist eine Ausschlussdiagnose.

Wenn man keine anderen Krankheiten findet, die die Symptome erklären, dann ist es Long Covid. Oder eben offiziell Post Covid. Eine Diagnose ist für viele Betroffene zuerst einmal eine Erleichterung. So auch bei Jann. Endlich hat er einen Namen für seine rätselhaften Symptome. Und es gibt andere, die das gleiche haben. Aber schon ganz schnell drängt sich die Frage auf: Und jetzt? Dann wäre ja die Frage Behandlung. Und Behandlung ist schwierig.

Weil es gibt derzeit keine medikamentöse Behandlung für die Patienten. Was viele auch dann enttäuscht. Weil man denkt natürlich immer, jetzt bekomme ich eine besondere Pille oder irgendwie etwas, was mir helfen kann. Aber das gibt es ja nicht. Das heisst, wir operieren letztlich an den Symptomen, aber nicht an der Ursache. Die Ursache hinter den Symptomen, ist noch nicht geklärt. Es gibt nur Hypothesen wie überaktive Immunzellen oder reaktivierte Viren.

Ob diese Hypothesen schlussendlich zu einer wirksamen Therapie führen, ist nicht sicher. Die Behandlung von Long Covid zielt aktuell einfach auf die Linderung der Symptome ab, sagt Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern. Wir machen zum Beispiel Energiemanagement, was wir über die Ergotherapie verschreiben. Dann Pacing, Pausenmanagement. Das sind so diese Klassiker. Aber das war es dann fast auch schon. Es wird dringlich empfohlen, die Belastungsgrenzen ernst zu nehmen und so möglichst Crashes zu vermeiden.

Das sei das Wichtigste. Eine Methode dafür ist eben das Pacing. Also, dass man genau auf die Signale des Körpers achtet und danach handelt. Jann kauft sich eine Pulsuhr als Hilfsmittel. Er misst genau, welche Bewegungen und Aktivitäten wie viel Belastung für den Körper bedeuten. Er versucht ein Gespür dafür zu bekommen, wo seine Grenzen sind und was zu viel ist. Und dann habe ich mir vorgenommen, wie so das beste Pacing zu machen.

Weltmeister im Pacen wollte ich sein. Und wenn es das jetzt halt braucht, dass ich – ich weiss nicht wie lange – sehr wenig mache, und ja nicht über meine Grenzen gehe, dann mache ich das. Dann bin ich voll motiviert. Ich habe Jann damals bewundert dafür, wie er da angegangen ist. Er hat die Situation analysiert, erkennt, was es braucht und hat es genau, gewissenhaft und zielstrebig ausgeführt. So wie er es schon immer gemacht hat.

Aber ja, der Plan, dass es graduell besser geht, sich zu erholen, der ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich durchforschte das Internet nach irgendetwas, das noch helfen könnte. Einmal bin ich in die Apotheke und habe quasi alle Mittel gekauft, die helfen könnten – weiss doch auch nicht mehr – Aminosäuren, Vitamin D, Zink, alles mögliche. Mit einem ganzen Sack voll bin ich nach Hause gekommen. Also man hat alles versucht, was möglich ist, aber nichts hat wirklich funktioniert.

Es hat auch ständig gewechselt, und es sind immer wieder neue Symptome dazugekommen. Zur grossen Fatigue, Brain Fog und Muskelschmerzen kommen jetzt auch noch Magenbeschwerden, ein Tinnitus und eine starke Licht- und Lärmunverträglichkeit. Und die Belastungsintoleranz wird immer schlimmer. Bis ich dann keine

100 Meter mehr laufen konnte und kaum aus dem Haus gehen konnte. Oder wenn ich gegangen wäre, wäre ich am nächsten Tag flachgelegen.

Ja. Ich habe gegenüber Jann immer versucht zuversichtlich, zu bleiben und ihm Mut zuzusprechen. Aber je länger es geht, desto schwieriger fällt es auch mir, positiv zu bleiben. Man hat schon gemerkt, dass die Medizin und die Wissenschaft im Dunkeln tappen. Man war sehr hilfebedürftig. Man konnte selber nicht mehr sehr viel machen. Es gab keinen Ort oder keinen Plan, wie es weitergehen soll längerfristig, und wo man sein kann. Man kann nicht im Notfall sein, weil es kein Notfall ist.

Weil es eben längerfristig chronisch ist. Aber bei Rehakliniken hat man die Kriterien nicht erfüllt, um dort aufgenommen zu kommen. Das war wirklich eine krasse Erfahrung von Hilflosigkeit. Ihn jeden Tag so zu sehen, das macht mich fertig. Und dann kickt immer wieder die Angst, wie lange das jetzt so sein wird und ob es jemals besser wird. Aber ja, da muss ich einfach fest auch... Es ist ja schon okay, wenn es ab und zu kommt und dann auch annehmen und traurig sein und Angst haben, aber dann auch wieder gehen lassen.

Es bringt nichts. Ich muss einfach jetzt nehmen, Schritt für Schritt. Gar nicht mal so easy alles. Für einige Betroffene funktioniert das Pacing und Energiemanagement, sodass es ihnen über die Zeit ein bisschen besser geht. Wenn es aber nicht funktioniert, ist die Verzweiflung und die Frustration gross. Wie auch bei Jasna. Ich habe mir aufgeschrieben, was mich wie viel anstrengt. Ich meine, da fällst du in ein Loch, oder? Wenn da steht: Ich kann ein Stockwerk hochlaufen, aber vielleicht nicht zwei.

Und man ist 30 Jahre alt. Da fällst du in ein Loch, oder? Jasna ist jemand voller Energie. Sie ist aufgestellt, schlagfertig und jemand, der viel gestikuliert. Und wenn sie das macht, sieht man ihre muskulösen Arme, von all ihren sportlichen Abenteur. Es fällt mir schwer zu glauben, dass sie vor gut einem Jahr, im Winter 2024, fast nicht mehr Treppen hochlaufen konnte. Krank mit Long Covid wird ihr geraten, zu einer Psychologin zu gehen.

Ich bin absolut für Psychotherapie. Und es hat mir sicher auch etwas gebracht. Und ich liebe meine Psychotherapeutin. Aber es ist nicht das Problem, wirklich am Kern anzupacken. Viele Betroffene erzählen davon, dass sie sich nicht ernst genommen fühlen. Ich habe das sehr stark gespürt, sofort in die Schublade von diesem Post- oder Long Covid gesteckt zu werden. Und dass eigentlich oben etwas nicht korrekt sei. Und dass man nicht so tun soll, nicht so hysterisch, dass man einfach mal machen sollen.

Tu doch nicht so. Mach doch einfach mal. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aussagen auch ein Ausdruck einer eigenen Hilflosigkeit sind. Als ich sagte, ich kann nicht Treppen hochlaufen. Und man mir sagt, nimm halt den Lift. Das ist für mich keine Antwort. Das ist dir passiert? Das ist mir passiert, ja. Und ich dachte so, verdammt, also ich bin 32. Da kann man doch nicht so eine Antwort geben. Und es hat mir niemand helfen können.

Ja, dann war ich ein bisschen verzweifelt. Jasna ist zu diesem Zeitpunkt seit eineinhalb Jahren krank. Sie geht zwar noch arbeiten, zeitweise reduziert, aber sonst macht sie nicht mehr viel anders. Sie geht nicht mehr joggen und auch nicht mehr auf Skitouren. Ein Hobby, das sie vor ein paar Jahren begonnen hat und zu einer Leidenschaft geworden ist. Ein grosser Wunsch von mir war es, einen Skihochtouren-Kurs zu machen. Im Winter 2024 wollte sie sich diesen Traum erfüllen.

Schon ein Jahr vorher hatte sie sich angemeldet. Und ich wusste lange nicht, ob ich überhaupt die Erlaubnis vom Spital bekommen werde, dass ich dort gehen kann, ob ich Ferien bekomme. Und dann hat es geheissen, doch, es ist gut, wir haben noch etwas geschoben, du kannst gehen. Und ich habe mich extrem gefreut. Jasna hat gehofft, dass es ihr dann besser geht. Dass sie den Kurs machen kann. Dann habe ich aber gemerkt, in diesem Winter ist es mir so schlecht gegangen, dass ich das absagen musste.

Klar, Berge laufen nicht davon. So einen Kurs wird es wieder geben. Aber zu diesem Zeitpunkt weiss Jasna nicht, wann und ob überhaupt, sie jemals wieder auf eine Skitour gehen können wird. Ich war so enttäuscht. Ich war so: Das hat mir alles genommen, die Krankheit hat mir alles genommen jetzt kann ich nicht mal auf diese Tour. Diese Skitour steht für all das, was Jasna wegen der Krankheit nicht mehr kann. Nicht mehr kochen, nicht mehr mit Freund:innen essen, nicht mehr Treppen laufen, nicht mehr joggen und schon gar nicht auf eine Skitour.

Und man kann auch ehrlich gesagt sagen, dass ich dann zum Teil wirklich gedacht habe, so möchte ich nicht mehr weiterleben. Also wenn das nicht weggeht, dann möchte ich nicht mehr leben. Ich konnte noch einkaufen,

ich konnte noch irgendwie funktionieren aber ich hätte nicht mehr so leben wollen. Und das ist wirklich so, wo ich wirklich gedacht habe, scheisse, wenn das so weitergeht, dann ist es fertig für mich. Ich kann nichts mehr machen, was ich gerne mache.

Das klingt drastisch. Jasna ist aber nicht die Einzige mit solchen Gedanken. Es gibt leider auch Fälle des Suizids, weil Patienten das wirklich nicht mehr aushalten. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also, dass in unserer Gesellschaft Leute so verzweifelt sind, und sie sich so unaufgefangen fühlen, dass sie keinen anderen Ausweg mehr sehen. Das versuche ich immer zu vermitteln, dass da trotzdem Menschen sind, die auffangen.

Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern. Für Long Covid-Betroffene und ihr Umfeld ist es nicht immer einfach, daran zu glauben, dass man aufgefangen wird vom medizinischen System. Zum Beispiel, wenn man ein Aufgebot für einen Termin bei der Post Covid-Sprechstunde bekommt. Und der Termin erst in fünf Monaten ist. Ich weiss noch, wie ich dachte: Das kann doch nicht sein. Jann braucht jetzt Unterstützung. Absolut berechtigt. Wenn ich betroffen wäre, würde ich das genauso sehen.

Und ich sehe es auch als Behandlerin genauso. Wir haben halt viel zu wenig Ressourcen, um auch den Andrang an Anmeldungen überhaupt bewältigen zu können. Das ist ja gar nicht so, dass wir das nicht machen möchten, sondern wir haben einfach keine Ressourcen. Wir haben ja nicht mehr Personal bekommen, nur weil es jetzt irgendwie Post Covid gibt. Post Covid ist einfach noch on top gekommen. Aber es gab nicht on top neue Mitarbeitende.

Und ich glaube, das ist schon ein Fehler im System. Die Versorgung von Long Covid-Patient:innen in der Schweiz ist aktuell uneinheitlich und reicht leider bei weitem nicht aus. Lange nicht alle Spitäler bieten eine spezialisierte Sprechstunde an. Und die, die eine haben, wie in Bern, haben sehr lange Wartezeiten. Es gibt Physio- und Ergotherapeut:innen mit Expertise in Pacing und Energiemanagement. Aber auch diese sind oft ausgebucht.

Gleich wie auch die Psychotherapeut:innen, die in dieser belastenden Situation unterstützen. Und dann sind da noch die Rehakliniken mit den spezialisierten Long Covid-Abteilungen. Für Jann ist so eine Rehaklinik irgendwann noch die einzige Hoffnung. Also melden wir ihn für einen Aufenthalt an. Das war etwa genau ein Jahr nach dem Engadiner Skimarathon. So viel ist passiert in diesem Jahr. Weil jemand anderes abgesagt hat, hat er überraschend schnell, drei Wochen später, einen Platz bekommen.

Zusammen mit seinen Eltern, fahren wir mit dem Auto von Bern auf Gais, im Appenzellerland. Jann sitzt auf dem Beifahrersitz, den haben wir nach hinten geklappt sodass er liegen kann. Er trägt eine Augenmaske und Noise-Cancelling-Kopfhörer, weil äussere Reize seine Symptome verschlimmern. Es schwingt Angst mit, Ungewissheit, aber auch das Gefühl von Entlastung und Zuversicht. Wenn es einen Ort gibt, wo das Personal und die Ärzt:innen wissen, was das bedeutet, dann sicher dort.

Ich habe mich am Anfang sehr aufgehoben gefühlt, und es hat natürlich auch Hoffnung gemacht. Sein erster Tag in der Rehaklinik ist genau vor zwei Jahren. Am 15. März 2024. Am internationalen Long Covid- Awareness-Day. Wie passend. Das grosse Ziel von Jann ist, dass er nach diesen fünf Wochen Aufenthalt ein wenig mehr als ein paar Schritte laufen kann. Er ist motiviert und hoffnungsvoll. Auch am zweiten und dritten Tag in der Klinik.

Aber es gab auch Druck, weil es gibt eine Bedingung dafür, dass er in der Klinik sein kann: Er muss an den Therapien teilnehmen. Physio, Autogenes Training, Ernährungsberatung und so weiter. Das erste Wochenende ist überstanden. Mit jedem Tag wächst meine Hoffnung, dass es gut kommt. Aber ja, schon am vierten Tag bekomme ich eine Nachricht. Jann hat einen grossen Crash und er muss seine Therapien absagen. Nach einer Woche in der Klinik wird ihm gesagt: So geht es nicht weiter.

Du musst wieder nach Hause gehen. Also der einzige Ort, wo ich sein konnte und wo ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist der Ort, der gemacht ist für Long Covid-Patienten, war anscheinend nicht der Ort für mich. Also aus ihrer Sicht. Er schafft es aber mit letzter Kraft, die Oberärztin zu überzeugen, dass er es trotzdem noch einmal eine Woche probieren darf. Um nochmal zu probieren, weil ich das wirklich wollte und weil meine Angehörigen sich eigentlich gerade erst davon erholt hatten, sich monatelang um mich zu kümmern.

Was, wenn er nach Hause gehen muss? Was machen wir dann? Wohin? Ich habe keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, das war einer der tiefsten Punkte für mich und auch für Jann.

Es kam mir vor wie in einem schlechten Film. Einfach schon krass, dass ich nicht eine Treppe hoch laufen konnte und dass ich in meinem Zimmer war und nicht einfach rausgehen konnte, wann ich wollte. Ich habe mir dann jeweils wirklich vorgestellt, wie ich dann mal, wenn ich wieder gesund bin, einen Film machen würde über diese Zeit und diese krasse Situation, in der sie mich aus der Klinik werfen wollten, weil es mir zu schlecht ging.

Aber ja, in diesem Film hätte ich es dann gerade noch irgendwie geschafft, dort zu bleiben und alles wäre gut gekommen. Aber ja, es war dann halt schon traurig, zu merken, das Leben ist halt kein Film. Aber einen Titel für diesen Film hattest du dir schon ausgedacht? Ja, ich hatte Freude am doppeldeutigen Titel «So long Covid». Es ist schlussendlich keinen Film geworden, aber ein Podcast. Das ist die erste von sechs Folgen «Unheilbar krank».

Und in der nächsten hörst du, wie es dann trotzdem noch so kam wie im Film. Und er ist nicht der Einzige, der eine Kehrtwende in seiner Geschichte erlebt, wo plötzlich ein Happy End wieder eine Möglichkeit wird. Und das nicht zufällig, sondern mit einem neuen Krankheitsverständnis und Methoden aus der modernen Schmerztherapie und Neurobiologie. Ich habe dann recht radikal entschieden, ich setze auf das. Und dort hat sich das Gefühl eingestellt, ich war zwar noch wahnsinnig weit davon entfernt, aber ich habe gemerkt, okay, irgendwie bekomme ich wieder Boden unter die Füße.

Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich habe meine Lebensfreude wirklich zurück. Also die ist zurück. Und das konnte man eine Zeit lang wirklich nicht sagen. Und die ist zurück. Auch wenn ich jetzt nicht gut schlafe. Auch wenn ich jetzt ab und zu noch Kopfweg habe. Dann schlafe ich halt jetzt nicht so gut. Ich sitze jetzt trotzdem mit dir da. Das ist «So Long Covid» von Jann Zosso und mir, Zita Bauer. Uns ist es wichtig, auf die Lebensrealitäten von Betroffenen aufmerksam zu machen und die Lücken in der Versorgung aufzuzeigen.

Wir wissen aber auch aus Forschung und aus eigener Erfahrung, dass so ein Fokus auf das Negative, wie wir es in dieser ersten Folge hatten, die Genesung erschweren kann. In der nächsten Folge gehen wir einen Schritt weiter: Was können wir lernen von denen, die wieder gesund geworden sind? Und plötzlich veränderte sich meine Welt. Es gab einen Ausweg. Und allein diese Erklärung und die Hoffnung, setzten den Heilungsprozess in Gang, ziemlich schnell.

"So Long Covid" ist eine unabhängige Podcast-Serie. Wir freuen uns, wenn du sie weiterempfehlst. Und lass uns doch eine Bewertung da. Das hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Originalmusik: Janos Mijnsen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign: Christina Baron. Dramaturgische Beratung: Franziska Engelhardt. Redaktionelle Mitarbeit: Stella Bollinger. Sprechregie: Irene Müller. Aufnahmestudio: Radio RaBe.

Host und Schnitt: Zita Bauer. Produktion, Konzept und Redaktion: Jann Zosso und Zita Bauer. Und einen riesengrossen Dank allen, die mit uns gesprochen haben. Besonders Jasna, Marlen und Patricia für ihre Offenheit und ihr Vertrauen. Der Podcast wird unterstützt von der Stadt Bern, der Burgergemeinde Bern, Ernst-Göhner-Stiftung, Community-Plattform Ting, Gesellschaft Ober-Gerwern, von Marlen Reusser und von all denen, die über das Crowdfunding gespendet haben.

Danke vielmals. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch. Und übrigens: Die nächste Folge ist jetzt schon draussen.

SO LONG COVID

Folge 2: Aha-Moment

Lesefassung der deutschen Untertitel

Du hörst die zweite von sechs Folgen vom Podcast SO LONG COVID. Die sechs Folgen bauen aufeinander auf. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Guten Morgen, ich hoffe, du hast gut geschlafen. Ich habe gut geschlafen. Ich habe gedacht, vielleicht ist es ja keine so schlechte Idee, Sprachnachrichten zu schicken. Die kannst du vielleicht etwas angenehmer anhören als schriftliche Nachrichten. Jann, mein Partner, ist in einer Reha-Klinik für Long Covid-Betroffene.

Das ist im Frühling 2024. Wie war dein Abend? Bist du gut angekommen? Er hat eine starke Belastungsintoleranz, kann nur wenige Schritte pro Tag laufen und ist licht- und lärmempfindlich. Am Bildschirm etwas zu lesen, ist nicht wirklich möglich. Darum kommunizieren wir über Sprachnachrichten, so gut es geht. Hallo Zita. Ich habe gedacht, ich mache jetzt auch mal eine Sprachnachricht. Ich glaube, die erste, die ich je mache. Es ist sehr emotional, diese Nachrichten heute, zwei Jahre später, noch einmal anzuhören.

Ich höre Jann's Stimme so fest an, wie schwach er war, und wie schlecht es im ging. So schlecht, dass er die Termine in der Klinik nicht wahrnehmen kann. Krafttraining, Ergotherapie, Autogenes Training usw. Er erhält ein Ultimatum: Noch eine Woche darf er es probieren. Entweder schafft er es, an genug Therapiestunden teilzunehmen, oder er muss wieder nach Hause. Ich hatte bis jetzt ziemlich einen guten Tag. Es ist ein Auf und Ab, und bei jeder Nachricht, die ich bekomme, werde ich zuerst einmal nervös.

Es tut mir leid, aber leider muss ich dir schon wieder keine so gute Nachricht überbringen. Ich bin halt schon wieder zu schwach, um diese Termine einzuhalten und alles, was sie wollen. Und ja, es ist wirklich wichtig, dass ich bald wieder auf die Beine komme und auch ein bisschen länger laufen kann. Und ich will das so sehr ... aber irgendwie ... ja... Jann klingt für mich ein bisschen wie ein anderer Mensch, und das alles ein bisschen wie ein anderes Leben.

Oder wie Jann in der letzten Folge gesagt hat: Wie in einem schlechten Film. Ich bin Zita Bauer, Sozialanthropologin und Journalistin und in diesem Podcast, erzähle ich Geschichten wie die von Jann Von Menschen, die an Long Covid erkrankt, und wieder genesen sind. Was können wir von ihnen lernen? Was war es, das die Wendung gebracht hat? Wie haben sie ins Leben zurückgefunden? Das ist SO LONG COVID, Folge 2: Aha-Moment. Eine dieser 10'000 Menschen in der Schweiz, die schwer an Long Covid erkrankt sind, ist Patricia Purtschert.

Es ist ein heisser Sommertag, und wir treffen uns an einem Ort, der eine besondere Bedeutung hat für sie. War in diesem Gebäude die Vorlesung? Ja genau, da drinnen. Patricia Purtschert ist Philosophin und Professorin für Geschlechterforschung an der Universität Bern. Wir stehen zusammen vor dem Gebäude, in dem sie noch im Frühling 2022 unterrichtet hat. Und was hast du für eine Vorlesung gehalten? Das war eine Zusammenarbeit der Gender Studies mit der Medizin, und ich habe hier mit meinen Kolleginnen die Eröffnungsvorlesung gehalten, in diesem Hörsaal, in diesem Haus.

Der Hörsaal, das Haus, gehört zum Inselspital, dem Universitätsspital Bern. Ein Jahr nach der Vorlesungsreihe, im Frühling 2023, ist Patricia zurück auf diesem Gelände. Diesmal aber im Bettenhaus, als Patientin. Und dann bin ich da irgendwo im oberen Teil, ich weiss nicht mehr, in einem der höheren Stockwerke gewesen. Vielleicht im 10. oder 11. Genau wie Jann kann auch Patricia zu diesem Zeitpunkt nur noch wenige Meter pro Tag laufen.

Genau, und der Bereich zwischen dem alten Bettenhaus und dem Vorlesungssaal, ich weiss auch nicht, das sind ... Wie viel ist das wohl? 150, nein, ich bin so schlecht, 200 Meter. Ja, ich würde auch sagen, es sind vielleicht 150, 200 Meter. Ich konnte das nicht ganz laufen. Aber ich habe hierhin gesehen und habe realisiert, wie nah das örtlich ist, ja, die zwei verschiedenen Leben. Ich schaue vom Bettenhaus zum Vorlesungssaal und wieder zurück.

Hin und her zwischen zwei verschiedenen Leben. Wie krass kann diese Krankheit alles auf den Kopf stellen? Kann ich heute schlafen? Kann ich heute laufen? Wenn ja, wie viele Meter? Das sind die Fragen, die sich Patricia

als Patientin stellt. Fragen, die noch ein Jahr vorher völlig selbstverständlich gewesen sind. Damals ist sie hier um die Ecke gedüst, hat schwungvoll ihr Velo abgestellt und ist in den Vorlesungssaal gerannt. Ständig habe ich nur daran gedacht, dass ich wieder in das Leben zurück will, das vielleicht symbolisch auch mit dem Vorlesungssaal verbunden ist.

Also in das Leben, in dem ich mich selbstbestimmt bewegen kann und die Sachen machen, die ich gerne mache. Von daher war es sehr präsent, aber ich habe einfach wie ... es war unendlich weit weg. Ich habe es mir nicht mehr vorstellen können, wie ich je mit so einem Körper in so ein Leben zurück kann. Die Geschichte von Patricia erinnert mich sehr an die von Jann. Beide arbeiten an der Uni, beide erkrankten schwer an Long Covid, und beide werden am Tiefpunkt ihrer Krankheit mit dem Rollstuhl in eine Klinik gefahren.

Hey und... Ja, das mit dem... Long Covid... "Fuck my life"... Das ist wirklich gerade etwas ... Eine Sprachnachricht an eine Freundin. Entschuldigung für die Wortwahl. Aber ich muss sagen, mein Ausdruck passt. Im Online-Wörterbuch Urban Dictionary steht: Fuck my life: Wenn etwas nicht so verläuft, wie erhofft. Und jetzt, in den letzten zwei Wochen, hat es sich einfach noch einmal massiv verschlechtert. Ja, und jetzt ist es wirklich...

schlimm, ja. Also... Es hat mich hart getroffen. Ich habe wirklich selten in meinem Leben so... so etwas Strenges durchgemacht. Oder mache es durch. Das irgendwie auszuhalten, dass es ihm so schlecht geht, und auszuhalten, dass niemand weiss, wie lange das noch dauern wird. Eben diese Geschichten, die man hört ... von monatelang, jahrelang ... irreparabel, unheilbar ... Dann falle ich komplett in ein Loch... Pacing wie ein Weltmeister, Energiemanagement, verschiedenste Nahrungsergänzungsmittel, histaminarme Ernährung, absolut Ruhe: Wir haben viel probiert.

Nichts hat Jann wirklich geholfen. Und auch in der Klinik ist bis jetzt die grosse Wendung ausgeblieben. Am Wochenende bin ich ihn dann besuchen gegangen. Er konnte mich nur ganz kurz treffen. Fünf Stunden Zug fahren, für eine Viertelstunde zusammen sein. Ich wusste, er kann rein gar nichts dafür. Traurig gemacht hat es mich trotzdem. Wie soll das weitergehen? Auf dem Heimweg von Gais nach Bern sitze ich im Zug und schaue gedankenverloren aus dem Fenster.

Dann nehme ich mein Handy hervor. Ich habe so viel über Long Covid gelesen, Online. In Fachzeitschriften. In Foren für Betroffene. Und auf Social Media. Es fühlt sich auch wie ein Sumpf aus negativen Berichten. über schlimme Schicksale, Versorgung, die hinten und vorne nicht reicht. und die verzweifelte Suche nach Lösungen. Ich finde es wichtig, über die Einschränkungen und die Hoffnungslosigkeit zu berichten. Aber irgendwann hat es mich einfach nur noch deprimiert.

Dazu all die pseudomedizinischen Angebote, bei denen man nicht recht weiss, machen die jetzt einfach Geld mit der Verzweiflung der Betroffenen und ihren Angehörigen. Und in diesem Sumpf bin ich plötzlich auf einen Artikel gestossen. Im Guardian, der britischen Tageszeitung. «Wenn du Long Covid hast, so wie ich es hatte, gib die Hoffnung nicht auf. Genesung ist möglich.» Ich sass im Zug, plötzlich hellwach. Diese leise Hoffnung hat mich richtig in Aufregung versetzt.

Hoi hoi. Ich weiss auch nicht, warum man es mir nicht anhört, aber ich war wirklich aufgeregt. Vielleicht wollte ich Jann nicht zu sehr aufwühlen, oder vielleicht wollte ich die Nachbarn nicht wecken. Jedenfalls ... Ich erzähle ihm von diesem Artikel im Guardian. Der Artikel ist von einem Infektiologen namens Paul Garner. Und Paul Garner berichtet von seiner eigenen Erfahrung. Er hatte selbst Long Covid und ist mittlerweile vollständig genesen.

Paul Garner hat eine Erklärung für Long Covid, die ich so bis jetzt noch nie gehört habe. Das Nervensystem sei überaktiviert und schicke darum ständig Fehlalarme in Form von verschiedensten Symptomen. Am Körper selbst sei nichts kaputt. Und er berichtet davon, was ihm geholfen hat. Er schreibt, er habe aufgehört, seine Symptome ständig zu überwachen. Er habe nicht mehr auf die Symptome fokussiert. Eine plausible Erklärung für seinen Zustand habe alles verändert für ihn. So habe er es aus dieser schlimmen Krankheit herausgeschafft.

Das hat mir Mut gemacht, das zu hören. Aber ich habe mich schon auch gefragt, ob diese Erklärung stimmt und ob das alles wirklich funktioniert. Bei Paul Garner hat es funktioniert. Er ist vollständig genesen. Ich treffe ihn für ein einstündiges Interview via Videocall. Und das wäre während seiner Erkrankung niemals möglich gewesen. Nice to see you. Good to see you. Paul Garner ist 70, Epidemiologe und Experte für öffentliche Gesundheit.

Wir hatten es in der ersten Folge schon von ihm. Er ist einer der Ersten, der von Langzeitfolgen von Corona berichtet. Er, der die Symptome erlebt hat wie eine nie endende Achterbahn. Ich konnte es wirklich nicht verstehen, aber ich habe all die Symptome, die ich hatte und die kamen und gingen, direkt auf diesen seltsamen, mysteriösen Virus zurückgeführt, der im Land solchen Wirbel verursachte. Ich meine, es war wie ein Knall, einfach "bang".

Dieses seltsame Virus sei wie eine Bombe eingeschlagen. Er konnte sich seinen komischen Zustand die Wochen nach der Infektion, einfach nicht erklären können. Also hat er gemacht, was er als Professor für Infektiologie am besten kann: Er ist sein Problem wissenschaftlich angegangen. Er hat sich akribisch in Tabellen notiert, was er macht, was er isst und wie sich das alles auf seinen Zustand auswirkt. Hastest du auch so eine Pulsuhr?

Ja, ja, total nutzlos, völlig nutzlos. Also ... ich meine, ich hatte Tabellen, in denen stand, wie es um meine „Body Battery“ stand, und manchmal wachte ich auf und meine „Body Battery“ sagte, dass ich nicht mehr am Leben bin. Ich meine, es war irgendwie so, als wäre gar nichts mehr da. Es war total durcheinander. Er hat sich so eine Pulsuhr gekauft, genauso wie Jann. Die sei aber für gar nichts gewesen. Seine Beobachtungen hätten null Sinn ergeben.

Du merkst, Paul Garner ist jemand, der Klartext redet. So auch über den Moment, der alles verändert hat: Es ist ein bisschen wie ein Schalter. Es ist ein Aha-Moment ... Es gebe sogar eine wissenschaftliche Erklärung für solche Aha-Momente. Anscheinend gibt es Gedanken in unserem Unterbewusstsein, die dort herumschwirren, die wir noch nicht ganz zu einem Ganzen zusammengefügt haben. Und gelegentlich verschmelzen diese Gedanken irgendwie, und dann schickt das Gehirn sie hinauf in den Kortex, und man denkt plötzlich: Aha!

und das ist offenbar mit grosser Freude verbunden. Ich glaube also, wir alle brauchen viel mehr Aha-Momente. Ein Aha-Moment entsteht, wenn unser Unterbewusstsein Informationen verarbeitet und neu kombiniert. Im Hintergrund, bevor wir bewusst darüber nachdenken. Wenn eine stimmige Lösung gefunden wird, gelangt sie ins Bewusstsein. Und das fühlt sich dann an, wie eine spontane Erkenntnis. Glückshormone werden ausgeschüttet. Wir empfinden Freude und Erleichterung.

Paul Garners Aha-Moment wurde ausgelöst durch eine Begegnung mit einer Psychologin aus Norwegen. Sie ist selbst von ME/CFS genesen. Diese Begegnung sei ein glücklicher Zufall gewesen. Und dann fragte mich diese Person, ob ich offen für die Vorstellung sei, dass es vielleicht etwas damit zu tun habe, dass mein Gehirn daran beteiligt sei. Und ich sagte ja! Die Person gab mir daraufhin eine Erklärung zu Nervenbahnen, die damals noch recht elementar war.

Die Person, also diese Psychologin, habe ihm erklärt: Deine Symptome sind real. Aber sie sind nicht Ausdruck von einem körperlichen Schaden, sondern vom Gehirn erlernt, über die Zeit. Und wie alles, was wir lernen, passiert das über neue neuronale Verknüpfungen. Das Unterbewusstsein bewertet Situationen als bedrohlich, aktiviert das Nervensystem und sendet körperliche Signale wie Schmerz, Fatigue, Fieber, erhöhten Puls, gerötete Haut und so weiter.

Also auch messbare Symptome. Diese Prozesse laufen automatisch und unbewusst ab. Wir haben keinen direkten Einfluss darauf. Genau gleich wie auch Aha-Momente, die ihren Ursprung im Unterbewusstsein haben und die wir darum nicht erzwingen können. Und dann sei die Psychologin zum springenden Punkt gekommen: Auch wenn diese Prozesse unbewusst ablaufen, kannst du diese Symptome längerfristig wieder verlernen. Du kannst wieder gesund werden, Und plötzlich hat sich meine Welt geändert.

Es gab einen Weg raus. Und das in sich selbst, die Erklärung und die Hoffnung, leiteten den Genesungsprozess recht schnell ein. Die Erklärung und die Hoffnung, dass es besser werden kann, waren der Start des Genesungsprozesses. Man könne die Symptome, die einem das Leben zur Hölle machen, wieder verlernen. Nicht mit Medikamenten, nicht mit dem Tracken des Energiehaushalts. Sondern mit neuen Verknüpfungen, mit bewussten Handlungen, die das Unterbewusstsein beeinflussen.

So hat es bei Paul Garner funktioniert. Und es gibt auch andere positive Beispiele. Auch in der Schweiz. Kurz nachdem ich den Artikel im Guardian entdeckt hatte, erzählt mir eine Freundin von Patricia Purtschert. Professorin am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung. Auch das erzähle ich Jann sofort in einer

Sprachnachricht. Und dass sie genau das gemacht hat, dass sie wie ihr Gehirn überlistet hat ... Oder vielleicht ist überlistet das falsche Wort, aber neu trainiert hat.

Und auch sie ist genau so da herausgekommen. Das war ja lange ein Problem, das ich mir nicht vorstellen konnte... Es wurde immer schlimmer. und ich habe mir nicht vorstellen können, wie der Körper jemals wieder die Kurve kriegen soll. Das war mir ein Rätsel. Das war im Frühling 2023. Patricia ist seit vielen Monaten krank. Sie ist ratlos. Wie soll es jemals besser werden? Nachdem es lange Zeit wie eine Abwärtsschlaufen war, das ich nicht unterbrechen konnte, obwohl ich wirklich alles gewissenhaft gemacht habe, was man mir gesagt hat, wirklich nach...

Also mit aller Disziplin und Willenskraft, die ich habe, und die ist ja nicht klein, ist es einfach immer schlechter gegangen. Und dann gab es eben diesen Turning Point. Und da hat sich das Gefühl eingestellt, ich bin zwar immer noch wahnsinnig weit davon entfernt, aber ich habe irgendwie gemerkt, okay, irgendwie bekomme ich wieder Boden unter die Füße. Als sie im Spital ist, macht auch Patricia eine Entdeckung, die alles verändert.

Während sie mir davon erzählt, beginnen irgendwo Kirchenglocken zu läuten. Wie wenn sie unterstreichen wollten, wie wichtig das ist, was passiert ist. Genau, eigentlich ist das Entscheidende tatsächlich hier passiert. Das ist ein Zufall. Weil ich da, in diesen wenigen Momenten, in denen ich pro Tag aufs Handy oder auf Social Media oder ins Internet konnte, das war ja sehr eingeschränkt, auch wegen meiner... .. die kleinste Anstrengung löst ganz schlimme Symptome aus.

Sie kann nur wenige Minuten pro Tag am Handy sein. Und in einem von diesen Momenten habe ich auf Altea - das ist das eine Netzwerk, das von Gesundheitsexpert:innen gegründet wurde, für Betroffene - habe ich einen Post gelesen von einer Person, die sehr ähnlich krank war wie ich und die relativ schnell gesund geworden ist. Und diese Person hat das beschrieben. Und das war wirklich so ein Schlüsselerlebnis, also ich habe wirklich diesen Post gelesen und gemerkt, okay, das ist jetzt einfach wie eine neue Tür die aufgeht. Und ich bin verzweifelt. Ich habe wirklich gemerkt, mit jeder Faser meines Körpers, ich will zurück ins Leben.

Das war auch gut, das so klar zu merken. Da gibt es irgendwie überhaupt keine Zweifel daran, dass ich alles daran setzen werde. Und sie hat im Post das so beschrieben, als sei das Nervensystem, das aus dem Ruder gelaufen ist. Das war ihre Formulierung. Und sie hat auch hingewiesen auf mehrere Websites, Artikel und vor allem auch auf Websites mit Genesungsgeschichten. Und das war sehr wichtig. Weil ich eben sehr viele negative Berichte immer gelesen habe.

Sehr viele Berichte, die Angst machen. Die quasi sagen: Je länger das dauert, desto schwieriger ist es, da jemals wieder herauszukommen. Und so quasi der Hinweis: Ihr müsst wirklich Genesungsgeschichten lesen, ihr müsst schauen, wie andere da herausgekommen sind. Und vor allem der Hinweis aufs Nervensystem, das hat mir total eingeleuchtet. Das hat wirklich einfach Klick gemacht. Und dann habe ich dort eigentlich angefangen, mich mit diesen Ansätzen zu beschäftigen.

Und das würde ich wirklich sagen, dort hat sich alles gedreht. In dem Post, den Patricia liest, sind mehrere Artikel verlinkt. Darunter ist einer von The Guardian. «Wenn du Long Covid hast, so wie ich es hatte, gib die Hoffnung nicht auf! Genesung ist möglich. Es war kurz nach meinem 30. Geburtstag, im März 2024, als ich von Paul Garner und Patricia Putschert erfahren habe. In dieser Woche, als Jann seine letzte Chance in der Reha-Klinik bekommen hat.

Es hat sich angefühlt, wie ein verspätetes Geburtstagsgeschenk. Ich habe dir ja dann viele Sprachnachrichten geschickt, in denen ich dir von Paul Garner erzählt habe und danach auch von Patricia. Magst du dich noch erinnern, was du über diese Ideen und Ansätze gedacht hast, von denen ich dir erzählt habe? Also erst einmal waren es sehr viele Sprachnachrichten... Viel zu viele, dass ich alle auf einmal hätte hören können. Aber es hat mich dann sehr interessiert.

Vor allem konnte ich mich sofort sehr stark identifizieren. Wir hören zusammen eine Sprachnachricht aus dieser Zeit. «Hallo, Zita...» Das war eine Woche später, weil du ja irgendwie auch Zeit gebraucht hast, um dich mit diesen Sachen vertraut zu machen. Dann gab es einen Tag, an dem du mir viele Sprachnachrichten geschickt hast. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. nicht? Nein. Ich glaube, das war der Tag, an dem du das Video von Schubiner gesehen hast.

Ahh... Es hat nochmals sehr gut getan, dieses Video zu hören. Und ich bin total überzeugt von diesem Schubiner. Howard Schubiner ist ein Arzt und Professor aus den USA, der seit 20 Jahren Patient:innen mit den gleichen Techniken behandelt, die Paul Garner und Patricia Porcher geholfen haben. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, da hat bei dir irgendwie etwas "geswicht". Also, du hast auf eine andere Art Vertrauen gefasst, dass es gut kommt oder so.

Ich glaube, da habe ich es einfach noch mehr verstanden, was es bedeutet. Und ich glaube, auch die Tragweite verstanden. Dass das überhaupt nicht Long Covid-spezifisch ist, sondern dass es eine neue Art ist, den Körper zu verstehen. Oder wie... wie der Körper funktioniert, zu verstehen. Ich glaube, das hat mich damals so fasziniert. Ich weiss noch, dass ich mich sehr gefreut habe, dass Jann Vertrauen gefasst hat in die Idee, dass es gut kommen könnte, dass Genesung möglich ist.

Aber er ist zu diesem Zeitpunkt ja immer noch in der Klinik. Schwerkrank. Und ziemlich alleine mit dieser neuen Information. Eine Nachricht von damals. Es gibt immer wieder Phasen, in denen man etwas zweifelt, weil es halt wirklich schwierig ist. Aber jetzt bin ich 100% überzeugt, dass das der Weg ist. Und ich freue mich auch, jetzt ihn gehen. Aber irgendwie hier in der Klinik tut das niemand... hat überhaupt niemand diesen Ansatz.

Sondern es wird immer wie so vorausgesetzt, dass man das gar nicht heilen kann. Long Covid als unheilbare Krankheit. Diese Darstellung hat Jann gehemmt. Er hört immer wieder, dass es in erster Linie darum geht, die Krankheit zu akzeptieren und Überbelastungen zu vermeiden. Denn sonst wird es chronisch. Das ist das dominante Narrativ. Nicht nur in der Klinik, auch in der Long-Covid-Sprechstunde, bei Betroffenenorganisationen und in vielen Medienberichten.

Es gibt Menschen, die seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten unter ME-CFS leiden. Und jetzt berichten die Betroffenen, dass sie genau diese Krankheit überwunden haben. Und nicht nur das. Berichtet wird auch von einer neuen Erklärung für diese bisher unerklärten Symptome. Und diese chronifizierten Symptome, die das Leben so stark einschränken können, könne man wieder verlernen. Man könne wieder vollständig genesen. Es gibt aber auch eine andere Sicht auf diese Sache.

Man kann auch sagen, dass sind weitere Behauptungen, die kursieren. Wie es so viele gibt. Es ist ja auch suspekt, dass zum Beispiel die spezialisierte Long Covid-Klinik anscheinend nichts von diesem Ansatz weiss. Ich habe mich schon auch gefragt, ob ich da jetzt auf einen Hokusfokus reinfalle. Wenn man verzweifelt und hoffnungslos ist, ist man nämlich besonders anfällig für dubiose Heilungsversprechen. Und das kann auch richtig teuer werden.

Dazu gibt es genug tragische Geschichten. Was steckt also hinter diesem Erklärungsmodell? Kann man dem vertrauen? Und wieso gibt es nicht mehr Fachpersonen, die damit arbeiten? Es wird uns eben nicht beigebracht. Wir Mediziner lernen das nicht im Studium. Man kann ganz wunderbar Schmerztherapie machen oder überhaupt Medizin und an den neuesten Erkenntnissen komplett vorbeischnappen. Das sagt Antje Kallweit. Ich bin ganz ursprünglich Anästhesistin und habe meine schmerztherapeutische Weiterbildung gemacht und bin in Hamburg niedergelassen mit einer eigenen Praxis.

Antje Kallweit arbeitet seit etwa zehn Jahren als Schmerztherapeutin und seit gut vier Jahren jetzt mit diesen neuen Methoden. Und das kam genau für mich auch zum richtigen Zeitpunkt, weil ich total frustriert war mit meinen Leuten und das Gefühl hatte, ich kann denen eigentlich nicht das anbieten, was ich gerne wollen würde. Vor etwa fünf Jahren stösst Antje Kallweit auf einen Podcast von einer Psychotherapeutin aus den USA. Hallo, hallo! Wie geht es euch heute?

Hier ist Nicole. Ihr seid bei meinem Podcast gelandet "Die Heilung für chronische Schmerzen", mit mir: Nicole Sachs "Die Heilung für chronische Schmerzen" Das war ein Titel, der mich als Schmerztherapeutin natürlich gecatcht hat, weil ich dachte, das kann die ja nicht behaupten. Gibt es ja gar nicht. Chronische Schmerzen heilen. Das gibt es zu diesem Zeitpunkt nicht in der Welt von der Schmerztherapeutin Antje Kallweit. Sie wird neugierig und hört gerade mehrere Folgen vom Podcast.

Ich weiss noch, im Garten irgendwie beim Unkraut zupfen. Dort im Garten, beim Unkraut Zupfen und Podcast-hören, hatte auch sie einen Aha-Moment. Wo ich dachte, verrückt, das ist ja genau das, was ich in meiner Praxis erlebe und sie präsentiert mir dazu ein Tool, eine Möglichkeit, wie man da weiter rangehen kann. Und habe

festgestellt, dass das, was sie in ihrem Podcast macht, auch nur ein Teil der ganzen Wahrheit ist. Und dass dahinter aber nochmal eine ganz andere, auch wissenschaftlich sehr fundierte, neue schmerztherapeutische Bewegung sich eigentlich verbirgt.

Die neue schmerztherapeutische Bewegung, die Antje entdeckt, ist im deutschsprachigen Raum noch wenig bekannt. Und dann habe ich es angewendet und dann habe ich gemerkt, das ist verrückt, weil es funktioniert total toll und es gibt ganz viele neue Dinge, die eben hier in Deutschland auch noch nicht angekommen sind und in der breiten Masse nicht verfügbar sind. Was sind das für neue wissenschaftliche Erkenntnisse? Und kann das wirklich sein, dass es vielversprechende Erkenntnisse gibt, die einfach noch nicht in der Breite angekommen sind?

Ich verstehe gut, wenn an dieser Stelle Skepsis aufkommt. Es muss noch nicht mal eine hundertprozentige Überzeugung sein, die hat eigentlich keiner, wenn man beginnt. Aber eine Idee von irgendwas passt hier nicht zusammen. Es startet ja oft mit einfach einer Geschichte. Mit einem anderen Menschen, der sagt, oh, schau mal, was mir passiert ist und wie das für mich funktioniert hat. Und deswegen sind diese Genesungsgeschichten so unfassbar wertvoll.

Paul Garner ist durch einen glücklichen Zufall mit dieser norwegischen Psychologin in Kontakt gekommen. Patricia Purtschert hat in einem Forum einen Post einer anderen Betroffenen gefunden. Und diese beiden Geschichten machen für Jann eine neue Tür auf. Von anderen zu hören, die diese schlimme Krankheit vollständig überwunden haben, das gibt ihm neuen Mut und Kraft. Bis es dann halt trotzdem geschieht, wie im Film. Es passiert, wie Jann es sich ausgemalt hat.

Es gibt den Plot Twist, bei dem die Geschichte in eine neue Richtung geht. Und du hast ja dann deine eigene Recovery Story, Genesungsgeschichte, aufgeschrieben. Gut ein halbes Jahr, nachdem ich auf den Ansatz gestossen bin, schreibt Jann seine eigene Genesungsgeschichte. Was war deine Motivation dafür? Es ist wie so ein Zufall gewesen, dass wir auf dieses Wissen gestossen sind. Und das war nur so, weil jemand das aufgeschrieben hat und geteilt hat.

Also das wollte ich auch weitergeben. Und ähm, auch zu Wissen, dass noch so viele Leute daran leiden. All die Leute, die ich in der Klinik getroffen und miterlebt habe. Dass hoffentlich weitere, ganz viele Leute das Gleiche erleben können. Paul, Patricia und Jann sind nicht die Einzigen mit Genesungsgeschichten. Ich bin bei der Recherche auf sehr viele gestossen, auch in der Schweiz. Vielleicht kennst du die Geschichte von der Profisportlerin Marlen Reusser, die nach ihrer Genesung von Long Covid wieder zurück an der Weltspitze ist.

Ich habe selber eben, wie du sagst, diese Erkrankung erlebt. Und auch so ein bisschen das Narrativ in der Schweiz, dass es sehr aussichtslos ist. Dass es vielen lange nicht gut geht. Und dass man nichts machen kann. Also dass man eigentlich so ein bisschen mit gebundenen Händen warten muss, ob man vom Glück erfasst wird, dass man irgendwie heilen kann, oder dass man zu den Pechvögeln gehört und das einfach für immer hat. Und das hat mich ultra traurig, ultra hoffnungslos gemacht.

Bis Marlen von mehreren Seiten auf den neuen Ansatz aufmerksam gemacht worden ist. Von ihrem Partner, ihrer besten Freundin und: Ein Weg war es, dass Jann und Esther das mir erzählt haben. Marlen hört von diesem neuen Krankheitsverständnis auch von Jann, über eine gemeinsame Kollegin. Der Impuls zur Veränderung, der Zugang zu diesem neuen Wissen, kommt oft von einer anderen betroffenen Person, die ihre Geschichte teilt, in einem Artikel, einem Post oder einem Podcast.

Ich meine, wenn ich nicht Leute gehabt hätte, die mir das nähergebracht hätten, wäre ich nie darauf gekommen. Und plötzlich stellen sich Fragen, die man sich vorher noch nie ernsthaft gestellt hat: Wer kann mir sagen, wo ist die Grenze zwischen Körper und Geist? Was steckt genau hinter diesem neuen schmerztherapeutischen Ansatz? Und hat der wirklich Hand und Fuss? Das ist Wissenschaft. Das ist einfach nur Wissenschaft. Es ist die Wissenschaft des Gehirns und wie das Gehirn funktioniert.

Und das bringt uns zur entscheidenden Frage: Und jetzt behaupten Sie, dass Long Covid - oder Post-Covid - auch eine neuroplastische Erkrankung ist? Dazu dann das nächste Mal, Es war eine krasse Woche. Es war eine wahnsinnige Woche. Und ich glaube, in dieser Woche habe ich mein ganzes Midset über die Medizin und die Welt

verändert. Das ist SO LONG COVID, eine unabhängige Produktion von Jann Zosso und mir, Zita Bauer. Wenn dir der Podcast gefällt und du das Thema wichtig findest, freuen wir uns sehr, wenn du ihn weiterempfehlst.

Und eine Bewertung in der App hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Original Musik, Janosch Mainzen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign: Christina Baron. Dramaturgische Beratung: Franziska Engelhardt. Sprachregie, Irene Müller. Aufnahmestudio: Radio RaBe. Host und Schnitt: Zita Bauer. Produktion, Konzept und Redaktion: Jann Zosso und Zita Bauer. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch.

SO LONG COVID

Folge 3: Science-Fiction

Lesefassung der deutschen Untertitel

Du hörst die dritte von sechs Folgen des Podcasts «So long, Covid». Die sechs Folgen sind aufbauend. Falls du die ersten noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Ich bin am Stadtrand von Bern und besuche Jasna, die Ärztin aus der ersten Folge. Ich frage mal Zita, ob sie kompensiert ist. Bist du kompensiert? Was heisst das? Wann ist man kompensiert? Jasna und ihr WG-Mitbewohner sind am rumalbern. Sie begrüßen mich mit einer Frage, mit der ich definitiv noch nie in meinem ganzen Leben begrüsst worden bin.

Bist du kompensiert? Wir sprechen von einer kompensierten Krankheit, wenn eine chronische Krankheit im Lot ist. Man kann z.B. sagen, wenn eine Herzinsuffizienz, das ist eine chronische Krankheit, die jemand hat, weil sein Herz nicht mehr wirklich gut funktioniert, aber man kann Medikamente geben, damit es sich wieder kompensiert. Und wenn die Krankheit dekompenziert, wenn etwas dazukommt, wenn man z.B. noch eine Grippe oder so hat und dann plötzlich dekompenziert die Krankheit und man lagert jetzt in einer Herzinsuffizienz z.B.

Wasser ein. Und dann wird man z.B. hospitalisiert. Zur Rekompensation. Und wir wenden das so ein bisschen unter uns an, um zu fragen, hast du alles im Griff? Wenn wir sagen: bist du kompensiert? Jasna und ich haben beide nicht so viel geschlafen. Darum kompensieren wir zuerst mal unseren Schlafmangel. Willst du einen Kaffee? Oh ja, sehr gerne. Und dann gehen wir hinter das Haus. Jasna möchte mir nämlich etwas zeigen. Wie du siehst, so ein alter VW-Bus, ein bisschen kitsch.

Aber in einer schönen grünen Farbe. Ja, was ist das so? Petrol... Sie nennen es Karibikgrün. Eine sehr schöne Farbe. Könnte fast meine neue Lieblingsfarbe sein. Ich habe aber als Kind gesagt, dass man seine Lieblingsfarbe nicht ändern darf. Falls das meine Schwester hört. Sie hat jeden Tag ihre Lieblingsfarbe geändert. Und ich fand, man kann nur eine Lieblingsfarbe haben. Darum musst du jetzt beim Rot bleiben. Obwohl du eigentlich beim Karibikgrün schon ein wenig schwach wirst.

Mit diesem karibikgrünen Van fährt Jasna mit der Lieblingsfarbe Rot in jeder freien Minute in die Natur. Auf Hochtouren, Wandern und Klettern. Also du bist mega sportlich? Ja, manchmal sage ich «gewesen». Sportlich gewesen. In den letzten Jahren ist ihr Bus oft hinter dem Haus geparkt geblieben. Und Jasna nicht irgendwo in der Natur, sondern zuhause im Bett. Ich bin einfach arbeiten gegangen und nach Hause ins Bett. Ich bin arbeiten gegangen und nach Hause ins Bett.

Für eine lange Zeit konnte Jasna ihre Krankheitssymptome noch irgendwie... kompensieren, um auf diesen Ausdruck zurückzukommen. Das Arbeiten ist aber das einzige, was ihr noch bleibt. Ja, aber ich wusste, wenn das jetzt wegfällt, dann bin ich nichts. Jasna hat Long Covid. Es ist etwas anderes, wenn man mit 70 vielleicht einen Herzinfarkt hat, wo man einen Stent einsetzt, also so eine Brücke, und dann ist es wieder gut. Also wenn man mit 30 gesagt bekommt: Ja, ihr habt eine chronische Fatigue, lernt damit zu leben. Das ist nicht das Gleiche.

Für mich war einfach klar, okay, man hat etwas chronisches, das bedeutet, es geht nicht mehr weg. Ja. Und ich habe wie... in meinem Kopf ist schon auch chronisch gleich nicht heilbar. Auch die behandelnden Är:innen wussten nicht wirklich, wie weiter. Sie haben Jasna wenig Zuversicht geben können. Ich könnte selbst in der Rolle der Ärztin sein, oder? Und ich könnte es nicht anders machen, als wie man es bei mir gemacht hat. Aber natürlich als Patient:in ist das zerstörend Weil unsere ganze Hoffnung ist in dieser Medizin, wenn wir selber nicht weiter wissen.

Für Long Covid gibt es bislang kein wirksames Medikament oder anerkannte Behandlung. Jasna hat seit eineinhalb Jahren Belastungsintoleranz, Fatigue, Kopfweg, Brainfog, Schwindel und noch weitere Symptome. Eigentlich mag sie nicht mehr, auch nicht mehr arbeiten. Aber Jasna wollte sich nicht vollständig krankschreiben lassen, weil sie keinen Plan hatte, wie es dann weitergeht. Und dann bin ich in einem See von: Du bist krank, chronisch krank, und wir können nichts für dich tun.

Bis zu dem einen Tag, der alles verändert hat. Das war der 3. Dezember. An diesem 3. Dezember 2024 geht Jasna ins Spital arbeiten, wie jeden Tag. Sie hält einen Vortrag für ihr Team als Weiterbildung. Eine Publikation

über Metamizol. Metamizol ist ein starkes Schmerzmittel. Sie vermittelt ihrem Team die neuesten Erkenntnisse dazu. Aber ich habe dann schon gewusst und gemerkt, okay, es ist eigentlich fertig für mich. Ich kann nicht mehr. Ich bin so müde, ich bin so kaputt.

Ich habe diesen Vortrag gehalten. Ich war in einem Brainfog. Ich habe die Fragen fast nicht verstanden, die mir mein Chef gestellt hat. Ich war wirklich so verschoben von mir selber. Nach dem Arbeiten hat sie einen Termin bei ihrer Psychotherapeutin. Ich war ein Häufchen Elend. Ich konnte nicht mehr. Ich war so kaputt. Dann hat sie mir irgendwie gesagt, ob ich die SRF-Dok mit Marlen Reusser gesehen hätte. Noch am gleichen Abend schaut sie die SRF-Dok über Marlen Reusser, die Schweizer Profi-Radsportlerin.

Was ich für mich selber als Ziel habe, oder als Arbeitsleitsatz: ich will dieses Jahr die beste Version von mir selber sein, die ich sein kann. Marlen... ich habe sehr viel von mir in ihr gesehen. Man sieht, sie ist so eine Powerfrau. Sie hat alles so angerissen. Sie sagt noch, man kann alles erreichen. Und sie ist so positiv in dieser Dok. Und dann kommt der Abschnitt, wo sie nur noch weinen muss und die Emotionen von Verzweiflung zeigt und wie sie krank ist.

Ich musste auch diese WM längst gehen lassen. Ich musste die ganze Saison gehen lassen. Ich musste gehen lassen, überhaupt zu trainieren oder etwas zu machen. Der Fokus ist jetzt vielmehr auf der Gesundheit. Und dass ich überhaupt wieder gesund werde. Und dann ist es wirklich über mir zusammengebrochen. Ich sehe genau mein Leben in dem. Klar, ich bin nicht eine Profi-Rennradfahrerin, aber ich habe auch meinen Marathon gemacht sozusagen.

Mit dem Versuch, den Facharzt-Titel zu machen, mit all diesen Stellenwechsel, während Covid zu arbeiten. Es hat sich wirklich für mich angefühlt, wie eine Tour de Suisse. Einfach nicht im Sport, sondern im Arbeitsleben. Und dann wollte ich natürlich wissen: Okay, wie gehts ihr jetzt? Es hat mich wahnsinnig interessiert, ist sie gesund? Jasna nimmt ihr Handy hervor, geht auf Instagram und sucht das Profil Marlen Reusser. Dieses Video richtet sich an alle, die Post-Covid bzw.

ME/CFS erkrankt sind oder jemanden kennen, der darunter leidet. Man sieht Marlen Reusser im Selfie-Modus. Sie spaziert am Waldrand entlang und redet über ihre Erfahrung mit Long-Covid. Ich selbst war davon betroffen und bin immer noch beeindruckt von der Macht oder Kraft dieser Krankheit. Und bin extrem glücklich, geht es mir nun besser. Und weil ich so überzeugt bin von den Schritten, die ich machen konnte, würde ich das gerne teilen.

Gut sieben Minuten lang dauert das Video. Marlen Reusser erzählt, was ihr geholfen hat, um wieder gesund zu werden. Es sei ihr wichtig, das zu teilen, weil dieses Wissen in der Schweiz wenig bekannt sei. Unterschrieben hat sie den Post mit Marlen 2.0 Bevor Marlen Reusser Profiradsportlerin geworden ist, hat sie Medizin studiert, wie Jasna. Und Jasna weiss das und wird darum hellhörig. Und plötzlich erinnert sie sich an Jann, den sie von früher kennt.

Darum haben sie auch den gleichen Dialekt. Ein Kindheitsfreund von mir, Jann, ist auch sehr stark an Post Covid erkrankt. Und ich habe das ein bisschen am Rand mitbekommen, da wir zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt hatten. Aber es ging mir trotzdem nahe, weil ich dann plötzlich auch in dieser Situation war. Ich habe mich jeweils schon gefragt, wie es ihm geht. Vor einer Weile hat sie von ihrer Mutter Neuigkeiten bekommen. Hey, Jann ist gesund.

Hier ist das was er gemacht hat. Schau mal, sagt dir das etwas? Und ich wieder so, ja, ja, meine Mutter schickt mir da wieder mal etwas. "Brain Reprogramming" und so, dass man sein Gehirn... Er habe sein Gehirn umprogrammiert und so. Sorry, Mami. Und dann – das war im September – habe ich mir noch gedacht: Nein, das ist nicht das. Ich habe ein Problem mit meinem Immunsystem. Ich war so fest davon überzeugt. Vielleicht Jann... er hatte Kopfschmerzen und Lichtempfindlichkeit oder keine Ahnung. Aber das bin ja nicht ich.

Aber jetzt, ein paar Monate später, schaut Jasna das Video von Marlen Reusser auf Instagram und hat ihren Aha-Moment. Plötzlich sieht sie Parallelen zwischen Marlen Reusser, Jann und ihr selber. Und ja, das ist Wahnsinn. Das gibt Hoffnung, Zuversicht? So viel Hoffnung, so viel Hoffnung. Und dann geht man halt ein bisschen tiefer. Man glaubt es ja nicht so fest. Hey, kann das wirklich sein? Kann man sein Hirn umprogrammieren? Es klingt ja so ein bisschen nach Science-Fiction.

Aber ja, ich habe immer mehr realisiert, dass es so ist. Dass man das kann. Das ist der Podcast «So Long Covid». Die dritte Folge «Science Fiction». Mein Name ist Zita Bauer. Jann, der Kindheitsfreund von Jasna, ist mein Partner. Er ist vor drei Jahren, im Frühling 2024, an Long Covid erkrankt. Wie wir in den letzten Folgen gehört haben. Es gab Monate, in denen er wegen seinen schlimmen Symptomen eigentlich nur noch im Bett liegen konnte.

Irgendwann habe ich mich schon gefragt, was das langfristig für ihn bedeutet. Und auch für uns. Werden wir jemals wieder zusammen Sachen unternehmen können? So wie früher? Aber ja, dann bin ich ja auf den Artikel im Guardian gestossen. Und damit auf ein neues Krankheitsverständnis. Man könne davon ausgehen, dass die chronischen Symptome von Long Covid vom Gehirn und Nervensystem erlernt sind und darum auch wieder verlernbar. Basierend auf dieser Erklärung haben Marlen Reusser, Jann, Jasna und viele andere Long Covid überwunden.

Überhaupt mal zu verstehen, was die neurowissenschaftlichen Grundlagen dieser Erklärung sind, ist der erste wichtige Schritt Richtung Genesung. Und darum ist das auch das Ziel dieser Folge. Wie kann das Gehirn eigentlich Symptome lernen? Okay, und da wird jetzt ein bisschen nerdy, aber auch super faszinierend. Das Gehirn ist eines der komplexesten Organe unseres Körpers. Ich hatte erwähnt, dass es mir schon auch so ging wie Jasna, dass ich etwas skeptisch war wegen Gehirn umprogrammieren und so.

Aber als ich so richtig ins Thema eintauchte, habe ich schnell gemerkt: Dieser Ansatz ist wissenschaftlich fundiert und kommt aus der Forschung zu chronischem Schmerz. Es ist also auch nicht ein Ansatz, der erst mit Long Covid aufgekommen ist. Es gibt Ärzt:innen und Schmerztherapeut:innen, die schon seit über 20 Jahren damit arbeiten. Einer davon ist Howard Schubiner. Wir haben schon in der zweiten Folge kurz von ihm gehört. Er ist einer der führenden Experten in diesem Gebiet.

Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, dieses Interview zu geben. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Danke. Ich glaube nicht, dass ich viele Leute in der Schweiz kenne, die diese Arbeit machen. Es sind auch nicht viele... Howard Schubiner ist Facharzt für Innere Medizin und Professor an der Michigan State University, am College of Human Medicine. Ich arbeite seit etwa 22 Jahren in diesem Mind-Body-Bereich. Sie sprechen vom "Mind-Body-Bereich"?

Lassen Sie uns die Terminologie klären, weil es etwas verwirrend sein, es gibt so viele Begriffe. Ich weiss, der Begriff «Mind-Body» bedeutet für verschiedene Menschen sehr Verschiedenes. Was ich konkret mache: Ich helfe Menschen, die Symptome oder Erkrankungen haben, die nicht durch einen körperlichen Schaden im Körper verursacht sind, sondern durch gelernte neuronale Schaltkreise in ihrem Gehirn. Diese nennen wir heute neuroplastische Symptome.

Neuroplastische Symptome. So nennt man die Symptome, die keinen körperlichen Schaden als Ursache haben, sondern vom Gehirn erlernt sind. Früher hat Howard Schubiner von Mind-Body-Syndrom gesprochen. Er sei aber davon weggekommen, weil das missverständlich sei. Es gebe so viele Angebote unter diesem Namen, die ganz Verschiedenes meinen. Durchgesetzt hat sich der Begriff «neuroplastische Symptome». Das ist abgeleitet von Neuroplastizität.

Der Begriff für die Fähigkeit des Gehirns, zu lernen, sich zu verändern und neu zu formen. Kinder lernen, wie man Fahrrad fährt, wie man spricht, wie man läuft. Das geschieht durch Neuroplastizität. Aber wir können auch Schmerz lernen. Wir können Fatigue lernen. Wir können Anxiety lernen. Laufen, Reden, Velofahren. Das alles lernen wir aufgrund dieser neuronalen Plastizität. Und nicht nur als Kinder, lernen können wir das Leben lang.

Und eben auch Schmerzen und Symptome. Die neuronalen Schaltkreise im Gehirn können sich aktivieren, sie können sich deaktivieren. Man kann Schmerz erlernen, und man kann ihn wieder verlernen. Und genau das steht im Mittelpunkt der Arbeit, die ich seit über zwei Jahrzehnten leiste. In den mehr als 20 Jahren Forschung und Praxiserfahrung in dem Bereich haben Howard Schubiner und sein Team immer und immer wieder gesehen, das Gehirn kann unbewusst Symptome lernen, aber auch verlernen.

Chronisches Rückenweh, Fatigue, Migräne, Tinnitus und so weiter, gehören meistens in diese Kategorie: Neuroplastische Symptome, die man wieder verlernen kann, die heilbar sind. Das ist schwer zu glauben. Besonders wenn man vorher eigentlich immer nur gehört hat, dass man eben nichts machen kann und dass man

damit leben lernen muss. Das klingt fast ein bisschen wie Science-Fiction, oder? Ja, die Genesungen, die wir erlebt haben, scheinen zu schön, um wahr zu sein.

Und wenn man den Leuten davon erzählt, glauben es die meisten die es zum ersten Mal hören, nicht. Sie glauben, du machst dir etwas vor oder es ist nur Hokusfokus Science fiction oder woo-woo. Aber genau das haben wir beobachtet. Kein Science Fiction also. Kein Hokus Pokus. Sondern einfach Science und jahrelange Erfahrung. Mir hat es geholfen, das alles mal noch auf Deutsch zu hören. Darum habe ich auch noch Antje Kallweit angerufen.

Hallöchen. Antje Kallweit, Ärztin und Therapeutin für chronische Schmerzen. Sie, die bei Unkraut-zupfen einen Podcast gehört hat und so vom neuroplastischen Ansatz erfahren hat und jetzt selber seit gut vier Jahren damit arbeitet. Wie machen Sie das an Familienfesten oder Cocktailpartys oder so? Wie erklären Sie es da? Ich gehe nicht mehr auf Cocktailpartys. Ich gehe auch nicht an Cocktailpartys. Keine Ahnung, aus welcher Ecke meines Gehirns diese Idee gekommen ist.

Ich möchte noch besser verstehen, wie Schmerz funktioniert. Und ich sage jetzt Schmerz, Antje Kallweit auch. Der Mechanismus lässt sich aber auf alle möglichen Symptome übertragen. Man kann nur mit diesem Satz beginnen: Jeder Schmerz entsteht im Gehirn. Auch dieser Schmerz der Gallenblase oder des kaputten Knochens entsteht nicht dort, wo sozusagen der Knochen kaputt ist. Sondern da entsteht die Nozizeption. Da entstehen die Reize.

Und die gehen Richtung Rückenmark und dann ins Gehirn. Und erst im Gehirn entsteht der eigentliche Schmerz. Und das ist bei allen Schmerzarten so. Es gibt keinen Schmerz ohne Gehirn. Das muss man erstmal verstehen. Das Gehirn spielt die entscheidende Rolle bei der Entstehung von Schmerzen. Aber nicht nur. Eigentlich bei unserer ganzen Wahrnehmung, wie Howard Schubiner ausführt. Unsere Gehirne generieren, vermitteln buchstäblich, was wir erleben.

Das ist keine esoterische Idee. Es bedeutet nicht, dass wir reich werden, wenn wir nur genug denken, dass wir reich werden. Was es bedeutet, ist, dass wir nicht mit unseren Augen sehen. Es bedeutet, dass Licht in unsere Augen kommt. Aber unser Gehirn, der visuelle Kortex, ein Teil des Gehirns, schafft die Bilder, die wir sehen. Und darum sieht dein Gehirn manchmal Dinge, die nicht da sind. Und warum dein Gehirn sehen kann, wenn wir schlafen, weil wir träumen.

Wir sehen nicht mit unseren Augen. Das klingt jetzt etwas seltsam, aber so ist es, sagt Howard Schubiner. In unsere Augen kommt Licht. Und diese Signale gehen dann weiter ins Gehirn, in den visuellen Kortex. Das fertige Bild entsteht aber nicht nur aus diesen Lichtsignalen, sondern im Zusammenspiel mit vielen weiteren neuronalen Bahnen, die Informationen aus anderen Hirnarealen in den visuellen Kortex bringen. Zum Beispiel aus einem Bereich, wo Erinnerungen und Erfahrungen gespeichert sind.

Und aus Netzwerken, wo Erwartungen, wie die Realität aussehen sollte, verarbeitet werden. Das Gehirn kombiniert das alles und kreiert daraus ein Bild. Das nennt man in der Neurowissenschaft Predictive Processing. Wir sehen also mit unserem Gehirn. Darum können wir auch Bilder sehen in unseren Träumen, obwohl die Augen zu sind. Und gleich ist es eben auch mit Körperempfindungen und mit Schmerz. Wir fühlen uns nicht mit unserem Körper.

Das ist so seltsam. Aber es ist wahr, wenn man eine heiße Herdplatte berührt, ist es nicht der Finger, der Schmerzen verursacht. Es ist das Gehirn. Und wir wissen das, weil viele, viele Menschen – das ist seit vielen Jahren belegt – eine Verletzung aber keine Schmerzen haben können. Wenn ich meinen Finger auf eine heiße Herdplatte lege, schicken die Nerven Signale an das Gehirn. Der Schmerz selbst entsteht also im Gehirn. Das Gehirn entscheidet, ob und wie stark ich Schmerzen empfinde.

Und darum macht es auch Sinn, dass Schmerzmittel oft im Gehirn ansetzen. Also Opioide, wie zum Beispiel Morphin oder Fentanyl, die wirken im Gehirn und im Rückenmark. Das ist die Grundlage, um neuroplastische Symptome zu verstehen. Dass jeder Schmerz und jedes Symptom schlussendlich im Gehirn entsteht. Und wie bei den Bildern, die wir sehen, wenn wir träumen, ist es eben auch möglich, dass Schmerz entsteht ohne Signal aus dem Körper, ohne strukturellen Schaden, wie Antje Kallweit erklärt.

Das ist das, was sozusagen die Schmerzwissenschaft immer mehr bestätigt: Es gibt Schmerz, der eben nicht entsteht aufgrund einer körperlichen Verletzung. Der nicht entsteht, weil sich da gerade ein Gallenstein durchwühlt oder dass da irgendein Nerv kaputt gegangen ist und trotzdem genauso echt ist. Also das ist sozusagen die grosse Entdeckung. Darum gibt es auch Phantomschmerzen. Schmerzen in einem Körperteil, das gar nicht mehr da ist.

Also jeglicher Schmerz und jegliches Symptom wird im Gehirn produziert, aber das heisst noch lange nicht, dass es eingebildet ist. Im Gegenteil. Das ist das Normale. Also es gibt gar nichts anderes. Jeder Schmerz entsteht im Gehirn und der ist nicht weniger echt, der ist auch nicht weniger stark. Das ist genauso echt wie jeder andere Schmerz. Es ist oft so, dass zwar am Anfang eine Infektion oder eine Verletzung ist, die dann aber abgeklungen oder verheilt und man keinen klar identifizierbaren strukturellen Schaden mehr im Körper findet.

Der Schmerz und die Symptome aber sind geblieben. Echter Schmerz, echte Symptome. Ohne körperlichen Schaden, ohne Nervenverletzung. Das müssen wir zuerst einmal sacken lassen. Es erinnert mich ein wenig an den Film «Matrix», wo der Hauptdarsteller Neo erfährt, dass die Realität ganz anders zustande kommt, als er gedacht hat. Im Film ist es durch eine Simulation, eine computergenerierte Traumwelt. Im echten Leben ist die Matrix unser Gehirn.

Etwas anderes kennen wir gar nicht. Das ist unsere Realität. Symptome wie Fatigue, Muskelschmerzen, Rückenweh, Migräne, Harndrang, Reizdarm und so weiter können vom Gehirn erlernt sein. Und all diese Dinge können beeinträchtigend und invalidisierend sein und ein Eigenleben entwickeln und dennoch nicht durch eine bestimmte Krankheit oder Gewebeverletzung oder pathologischer Prozess im Körper aufrecht erhalten werden. Und genau dort setzen Howard Schubiner, Antje Kallweit und ihre Kolleg:innen an.

Wir helfen Menschen dabei, ihr Gehirn so zu verändern, dass sie diese neuroplastischen Symptome verlernen können. Sie unterstützen die Patient:innen dabei, diese Symptome zu verlernen, indem sie ihnen helfen, das Gehirn neu zu verknüpfen. Und jetzt sagen Sie, dass Long Covid oder Post Covid ebenfalls ein neuroplastisches Syndrom ist? Ja, das haben wir ausführlich untersucht. Und ich schreibe darüber in meinem neuen Buch sehr detailliert.

Jeder Fall verdient eine sorgfältige Abklärung. Nur weil jemand sagt, er habe Fibromyalgie oder Migräne oder Long Covid, gehen wir nicht einfach ohne Abklärung davon aus, dass es neuroplastisch ist. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass jede Person mit Long Covid oder ME/CFS neuroplastische Symptome hat. Jeder Fall braucht eine saubere Abklärung. Aber Forscher:innen, Ärzt:innen und Schmerztherapeut:innen wie Howard Schubiner und Antje Kallweit kommen zum Schluss: Diese neuen Erkenntnisse über den neuroplastischen Ursprung von chronischen Symptomen gelten auch für Symptome, die Long Covid zugeschrieben werden.

Und weil das Gehirn neuroplastisch und lernfähig ist, kann man diese Symptome im Prinzip wieder verlernen. Das ist das grosse Potenzial. Ich halte überhaupt diese Art der Herangehensweise sowohl für Schmerz als auch für ME/CFS. Ich glaube, das ist ein wirklicher Wechsel der Perspektive. Und es bietet unfassbar viel Potenzial. Aber wie kannst du jetzt sicher sein, dass es bei dir so ist, dass deine Symptome wirklich neuroplastisch sind und man nicht etwas anderes übersieht?

Diese Fragen hat sich auch Jasna gestellt. Ich weiss noch ganz viele seltene Sachen, die sein könnten. Und das ist noch etwas in meinem Kopf herumgeistert. Seltene Krankheiten sind selten. Aber es gibt so viele seltene Krankheiten, dass es schon fast wieder nicht mehr selten ist, etwas Seltenes zu haben. Wie kannst du wissen, ob diese so einschränkenden, schlimmen Symptome und unausstehlichen Schmerzen nicht trotzdem ein Warnsignal für einen körperlichen Schaden sind, den man mit einem Medikament oder einer anderen Therapie behandeln muss?

Ein Keypoint für mich war, die medizinische Abklage zu machen. Weil ich für mich die Sicherheit gebraucht habe. So: Es ist wirklich nichts am Herzen. Es ist wirklich nichts an der Lunge. Es ist nichts in meinem Gehirn. Und im Bauch ist nichts. Und das habe ich gebraucht. Das ist sehr wichtig. Zuerst muss ausgeschlossen werden. Wenn man einen strukturellen Schaden findet, dann geht es darum, diesen zu behandeln. Und wenn man aber nichts findet, also kein Virus, keine Entzündung, kein kaputtes Organ, kein Gewebeschaden, keine Nervenverletzung, dann geht es zum nächsten Schritt in der Abklärung um neuroplastische Symptome.

Dieser nächste Schritt beinhaltet die Merkmale der Symptome sehr genau zu betrachten. Treten sie mal auf und mal nicht auf? Kommen und gehen sie? Werden sie besser, wenn man im Urlaub ist? Man sucht nach Hinweisen für neuroplastische Symptome. Kommen die Symptome und gehen dann wieder? Wird es besser, wenn man in den Ferien ist? Das war zum Beispiel bei Jasna so. Und dann, wenn ich wieder arbeiten musste und ich viel Stress hatte, dann ging es mir wieder schlechter.

Ein anderer Hinweis ist, wenn die Symptome im Körper von einem Ort zum anderen wandern. Es war wirklich immer ein sehr unterschiedlicher Kopfschmerz. Manchmal vom Nacken aus, manchmal von den Augen, manchmal wieder von hinten, manchmal an einem Ort, manchmal überall. Verschiedene wechselnde, wandernde, unetstige Symptome. Das sind Hinweise, die wir dann sammeln müssen. Es gibt so eine Liste, wir nennen sie so ein Schmerzatlant, wo Sie dann eintragen müssen.

Und je mehr Symptome, je mehr Schmerzorte... desto wahrscheinlicher, dass es ein neuroplastischer Mechanismus ist. Wenn man sehr sorgfältig nach diesen Mustern schaut, kann das den entscheidenden Unterschied ausmachen, denn letztendlich geht es darum, diesen Aha- oder „Klick“-Moment zu erleben. In dem Moment, in dem man erkennt: „Aha, jetzt verstehe ich, was da vor sich geht!“ Dann können wir uns auf den Weg der Genesung begeben.

Da ist er wieder, der Aha-Moment. Dann, wenn die Patient:innen verstehen, was in ihrem Körper vorgeht und wie es zu diesen neuroplastischen Symptomen kommt. Für mich war das dann so klar: die nicht strukturellen Sachen, sprich die Sachen, bei denen wir körperlich keine Ursache finden, das gibt es in der Medizin tonnenweise. Ich meine, so oft sagen wir: Wir kennen die Ursache eurer Schmerzen oder sonstigen Symptome nicht. Wir sehen im MRI, also in den Scans, oder auch in den Bauchspiegelungen oder was auch immer, wir sehen nichts.

Oder wir sehen etwas, aber es erklärt eure Schmerzen nicht, weil das normale Abnormalitäten sind, sozusagen. Und dann ist es mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen, ah, das ist das! Und dann war wirklich für mich mein Weg klar. Und ich meine, das ist Wahnsinn, wenn plötzlich jemand sagt: Es ist nicht einfach, aber du kannst es entlernen. Zu verstehen, was im Körper geschieht, ist entscheidend für den weiteren Genesungsprozess.

Es braucht dieses Grundvertrauen, dass der Körper an sich nicht kaputt ist. Und das zu erreichen, ist nicht einfach. Es ist genau das Gegenteil von dem, was man meistens hört. Du erinnerst dich. Meistens heisst es nämlich, dass jede Symptomverschlechterung irreparable Schäden zur Folge hat, was mega beängstigend ist. Und dann kommt noch dazu, dass es wirklich schwierig ist, zu glauben, dass so schmerzhaft und einschränkende Symptome vom Gehirn erlernt sein können.

Ich meine, ich wusste, dass man Kopfschmerzen chronifizieren kann. Aber dass sich Halsschmerzen chronifizieren können, dass du dich so krank fühlen kannst, dass du nicht mehr unterscheiden kannst, ob es ein Virus ist oder dein Kopf, das war für mich nicht in meinem möglichen Verständnis, bis zu diesem Punkt. Über die Evolution haben wir Menschen gelernt, körperliche Symptome als Ausdruck von körperlichen Schäden zu verstehen. Es war überlebenswichtig, sich zu schonen, wenn man Schmerzen spürt.

Dass es möglich sein soll, dass so einschränkende Symptome vom Gehirn erlernt wurden und verlernt werden können, dass das Gehirn so eine Macht hat, ist schwer zu glauben. Sogar, wenn man es selbst erlebt hat. Von dem erzählt auch Marlen Reusser. Magst du dich noch erinnern, was war deine erste Reaktion, als du davon gehört hast, oder dir davon erzählt wurde? Auch gerade mit deinem Hintergrund als Ärztin. Was hattest du dir dazu gedacht?

Ich hatte zuerst sehr viel Widerstand. Ich war wirklich stur. Ich hatte das Gefühl, ich habe etwas im klassischen Sinn, also irgendeine Infektion oder eine Krankheit, die man einfach noch nicht entdeckt hat. Ich war auch hundertmal wieder im Spital und habe gesagt: Ihr müsst einfach herausfinden, was ich habe! Ich treffe Marlen in einem Videocall. Die Profi-Radsportlerin ist gerade in Mallorca und kommt direkt vom Training. Sie erzählt von dem Moment, wo sie von dem neuen Ansatz erfahren hat.

Irgendwie hat es schon recht viel Verzweiflung gebraucht, und ich glaube, auch mein Glück war, dass es von verschiedenen Leuten, auf verschiedenen Kanälen an mich herangetragen wurde, bis ich dann irgendwann

dachte: Komm, weh tut es nicht, give it a try! Darum habe ich es eigentlich ausprobiert. Und es war das einzige, was ich je probiert habe, das mir irgendwie nicht noch mehr Energie gezogen hat. Und ich war nicht kaputt danach, sondern es hat sich eigentlich gut angefühlt.

Und dann habe ich schon gedacht: okay, das ist mal etwas ganz Neues für mich. Ein neues Erlebnis seit sehr vielen Monaten. Das selber zu erleben, hat das Medizinverständnis der gelernten Ärztin ziemlich durchgeschüttelt. Wer kann mir sagen, wo ist die Grenze zwischen Körper und Geist? Und so. Und das sind Fragen, die ich mir davor nie gestellt habe, wo ich gesagt hätte: du spinnst, das ist komplett esoterisch. Aber ich denke, das ist überhaupt nicht esoterisch, das ist komplett wissenschaftlich.

Wir begreifen es einfach nicht. Das ist viel komplizierter, als wir denken. Sie lernt selber nochmal ganz viel Neues dazu und stellt sich Fragen über das Menschsein und Gesundheit, die sie sich vorher noch nie gestellt hat. Schritt für Schritt geht es ihr besser. Bis sie irgendwann wieder anfangen kann, zu trainieren und Rennen zu fahren. Heute ist Marlen vollständig genesen. In diesem Video auf Insta erzählt sie von ihrem Weg.

Für Jasna, die auch bei uns im Podcast vorkommt, war dieses Video wirklich ein Turning Point. Heute geht es ihr sehr viel besser. Ich denke... So schön. Ja, das ist so cool. Ich hatte keine Ahnung, was das auslöst oder ob das irgendwie Anklang findet oder jemanden interessiert. Als ich diesen Post gemacht habe, habe ich vor allem Gegenwind gespürt und sehr, sehr viele Leute aus dieser Community, sage ich mal, die haben gesagt: Was sagst du da? Und das geht nicht und das stimmt nicht und du hast keine Ahnung.

Und dass dann doch super viele Leute, mir übrigens privat – also das ist noch lustig –, alle Kritik ist immer öffentlich, aber die guten Nachrichten sind auf allen Wegen privat gekommen – geschrieben haben, dass ihnen das auch geholfen hat, wegen meinem Video oder nicht. Das hat mich sehr gefreut, weil ich das Video mit der Idee gepostet habe, wenn es auch nur einer Person hilft. Für Marlen, Jasna, Jann und auch Paul und Patricia, die wir auch schon kennengelernt haben, ist dieses neue Krankheitsverständnis der Schlüssel zur Genesung von Long Covid und dem chronischen Fatigue-Syndrom gewesen.

Und sie sind keine Einzelfälle oder Ausnahmen. Das bestätigen neben Howard Schubiner aus den USA und Antje Kallweit aus Deutschland auch Silje Endresen Reme, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Oslo. Auch sie arbeitet schon seit 20 Jahren in diesem Bereich, als Forscherin und als Therapeutin. Und sie sagt: Aus der Forschung wissen wir: Es ist glücklicherweise nicht ungewöhnlich, davon auszugehen, dass eine vollständige Genesung möglich ist.

Früher haben wir den Patienten beigebracht, wie sie mit den Symptomen umgehen und lernen können, damit zu leben. Doch seit etwa fünf Jahren, dank neuer Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften, neuer Evidenz, neuer klinischer Modelle und neuer empirischer Ergebnisse sprechen wir zunehmend vom Leben ohne Symptome, also von vollständiger Genesung. Früher war das Ziel der Therapie, einen Umgang mit chronischen Schmerzen und Symptomen zu finden und damit zu lernen, zu leben.

Aber in den letzten fünf Jahren hat sich das geändert. Dank der neuen Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Immer mehr spricht man davon, symptomfrei zu leben, auch vollständig zu genesen. Das menschliche Gehirn ist immer noch eine grosse Blackbox. Wie Schmerzen und Symptome entstehen, versteht man aber immer besser. Egal, ob sie struktureller oder neuroplastischer Ursache sind, sie entstehen immer im Gehirn. Und sie sind real.

Im Film «Matrix» gibt es diese legendäre Szene, wo die Hauptfigur Neo vor die Wahl gestellt wird, die blaue oder die rote Pille zu schlucken. Mit der blauen wacht er in seiner gewohnten Realität auf. Das Leben geht weiter wie bisher. Mit der roten erfährt er, was hinter der Matrix steckt. Und alles wird anders. Jasna entscheidet sich für ihre Lieblingsfarbe. Und damit hatte ich wirklich einen Plan, weil ich wusste, was ich machen soll.

Oder was ich machen kann. Und dass ich etwas machen kann. Dass es wirklich eine Chance gibt, dass ich geheilt werde. Es gibt die Chance, dass Jasna mit ihrem karibik-grünen Büssli wieder auf Abenteuer gehen kann. Für mich ist das einfach eine Freiheit. Ich kann einfach irgendwo hinfahren. Ich kann in die Natur gehen. Ich kann dort schlafen. Diese Hoffnung ist keine Illusion, sie ist kein Wunschdenken. Sie stützt sich vielmehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse und empirische Belege.

Und wenn wir das nicht tun, riskieren wir, dass wir aufgeben, was wirklich sehr gefährlich ist. Die Hoffnung ist keine Illusion, sondern basiert auf wissenschaftlicher und empirischer Erkenntnis, sagt Silje Endresen Reme. Gefährlich sei, die Hoffnung zu verlieren. Das ist der Podcast «SO LONG COVID». Die dritte Folge «Science Fiction». Und in der nächsten Folge wird es endlich handfest. Was genau kann man machen, um das Gehirn umzuprogrammieren, um neuroplastische Symptome zu verlernen und wieder gesund zu werden?

Ich habe mich den Empfehlungen der Klinik widersetzt und genau das Gegenteil gemacht, was die Oberärztin empfahl. Ich wusste nicht, ob es stimmt. Ich wusste, es ist auch ein Wagnis, ein Risiko, aber es war auch eine Entscheidung. Ich habe mich auch entschieden, ich setze jetzt einfach mal 100 % auf das. Und dann ist es wirklich so geschehen. Als ich dann plötzlich wieder Treppen steigen konnte, war das schon mindblowing. Meine Füße sind schon am Sterben ...

Okay. Eins. Lass mein Mobiltelefon nicht ins Wasser fallen, ist gut? Eins. Zwei. Drei. Der Podcast «SO LONG COVID» ist eine unabhängige Produktion von Jann Zosso und mir, Zita Bauer. Falls dir der Podcast gefällt und das Thema wichtig findest, freuen wir uns sehr, wenn du ihn weiterempfehlst. Und eine Bewertung in der App hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Die nächste Folge kommt in einer Woche, am Sonntag, 29. März 2026.

Originalmusik: Janos Mijnsen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign: Christina Baron. Dramaturgische Beratung: Franziska Engelhardt. Sprechregie: Irene Müller. Aufnahmestudio: Radio RaBe. Host und Schnitt: Zita Bauer. Produktion, Konzept und Redaktion: Jann Zosso und Zita Bauer. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch

SO LONG COVID

Folge 4: Eins, zwei, drei

Lesefassung der deutschen Untertitel

Du hörst den Podcast «SO LONG, COVID». Das ist die vierte von sechs Folgen. Die sechs Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Ein Hinweis für alle mit Reizempfindlichkeit. Wir haben eine Podcast-Version ohne Musik. Die findest du auf unserer Website «solongcovid.ch». Einfach unter den Folgen auf den Link klicken. Und jetzt geht's los mit der vierten Folge. Es gibt Schmerz, der eben nicht entsteht aufgrund einer körperlichen Verletzung.

Und trotzdem genauso echt ist. Es ist Wahnsinn, wenn dir plötzlich jemand sagt, hey, es ist nicht einfach, aber du kannst es verlernen. Du hast selber die Macht, das zu verlernen. Der Hoffnung ist keine Illusion, es ist kein Wunschdenken. Es ist tatsächlich gegründet in dem, was wir von der Wissenschaft und empirischer Beweise wissen. Und bei mir hat es angefangen mit dem Wissen, also wirklich das Verständnis. Und dann habe ich angefangen, mich mit diesen Ansätzen zu beschäftigen.

Und das würde ich wirklich sagen, dort hat sich alles gedreht. Jann, Jasna, Marlen und Patricia haben viel ausprobiert. Pacing, Energiemanagement, Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Nichts hat angeschlagen. Im Gegenteil, es ist eher schlimmer geworden. Durch einen Zufall erfahren die vier von Menschen, die von Long-Covid oder dem chronischen Fatigue-Syndrom genesen sind. Und das nicht einfach so, sondern dank einem neuen Krankheitsverständnis.

Ich wusste nicht, ob es stimmt. Ich wusste, es ist auch ein Wagnis. Patricia Purtschert. Die Uniprofessorin. Es war auch eine Entscheidung. Ich habe mich auch entschieden, ich setze jetzt einfach mal 100% auf das. Weil ich habe auf das andere gesetzt. Auf das Pacen, auf das Energiemanagement. Das hat wirklich nicht funktioniert. Und ich habe mich dann entschieden, jetzt versuche ich das. Ich kann auch nichts verlieren. Wenn man bei den Abklärungen nichts findet, also keinen strukturellen Schaden, dann ist es gut möglich, dass Symptome von Patienten mit Long-Covid neuroplastisch sind.

Also vom Gehirn erlernt. Das haben wir in der letzten Folge von internationalen Expertinnen gehört. Es war das erste Mal eine Erklärung, die wirklich Sinn gemacht hat. Dass die Symptome so lange bleiben, dass es so viele sind, dass sie sich immer wieder verändert haben. Das sagt Jann. Er hat seine drastische Erkrankung, aber eben auch seine Genesung hautnah miterlebt. Dass seine Lichtempfindlichkeit und die kognitiven Einschränkungen, der Brain Fog, einen neuroplastischen Ursprung haben, hat Jann sofort eingeleuchtet.

Und er hat sich auch für die wissenschaftlichen Grundlagen interessiert. Fun Fact, er hätte fast sein Doktorat in Neuropsychik gemacht, hat sich aber schlussendlich für theoretische Physik entschieden. Auf jeden Fall hatte er als analytisch denkender Mensch eine Affinität für diese Erklärung. Das Gehirn bewertet Signale als bedrohlich, die eigentlich gar nicht bedrohlich sind. Bei der Lichtempfindlichkeit zum Beispiel wird Licht fälschlicherweise als Gefahr interpretiert.

Die Reaktionen sind Schmerzen, quasi mit der Message «Schütze deinen Körper dem schädlichen Licht.» Über die Zeit verfestigen sich die neuronalen Bahnen, die machen, dass die Lichtsignale Kopfweh auslösen. Licht wird zu einem Trigger. Das nennt man klassische Konditionierung. Und es ist einer der Mechanismen, die die Symptome chronifizieren. Neuroplastische Symptome sind quasi ein chronifizierter Fehlalarm, den man aber verlernen kann.

Und in der Theorie klingt das natürlich sehr super und sehr hoffnungsvoll auch, aber es ist natürlich etwas anderes, das dann auch anzuwenden, in dem Moment, wo einem der Körper mit den grössten Alarmglocken sagt: Beweg dich jetzt besser nicht! In diesem Moment sich anders zu verhalten, hat natürlich schon grosse Überwindung gebraucht. Und es ist nicht nur sein Körper, der Jann sagt, «Hey, beweg dich jetzt besser nicht.» Also ich habe mich quasi den Empfehlungen der Klinik widersetzt und genau das Gegenteil gemacht, was die Oberärztin empfohlen hat.

Auch Patricia hat gemerkt, sie muss es für sich anders machen, als ihr empfohlen wird. Das war manchmal schwierig, dass man das halt aushalten muss. Wenn z.B. die Physiotherapeutin, die ich sehr geschätzt habe, ständig Angst hatte, dass ich zu viel mache und dass ich crashe, weil sie halt in diesem anderen System gelaufen ist und aus sehr guten Gründen, wenn man von ihr her denkt, befürchtet hatte, ich übernehme mich und ich schätze mich falsch ein.

Für Jann und Patricia wird immer klarer, wir müssen einen eigenen Weg finden. Sie versuchen, sich abzugrenzen von der hoffnungslosen Prognose und den Sorgen der anderen. Sie versuchen, aus den Therapien, die sie machen, einfach das herauszupicken, was sie hilfreich finden. Und alles andere mache ich mit mir und vor allem mit dem Internet. Also glücklicherweise hatte ich diesen Zugang und glücklicherweise kann ich gut Englisch, weil sonst wäre es sehr schwierig gewesen.

Als Jann vom neuroplastischen Ansatz erfährt, ist er in der Reha-Klinik. Er ist ein mega schlechtes Weg. Er kann kaum fünf Minuten telefonieren. Er isst im Klinikzimmer und wird im Rollstuhl zu den Therapiestunden gefahren. Die Symptome bestimmen seinen ganzen Tag. Sie haben das Zepter in den Händen. Und da weiss ich noch, dieser eine Moment, in dem ich mir eigentlich vorgenommen hatte, am Nachmittag zu duschen. Aber die Symptome drücken ihn zu Boden.

Wie schon zum tausendsten Mal nach zu viel Bewegung spürt er eine grosse Schwere im ganzen Körper. Als würde er eine Gewichtsdecke mit sich herum tragen. Duschen? Eigentlich unmöglich. Wenn er jetzt trotzdem duschen geht, wird er crashen. Bis jetzt war es so, dass wenn ich trotzdem etwas gemacht habe, es nur noch schlimmer kam. Ich dachte aber, jetzt höre ich nicht mehr auf das und gehe jetzt duschen. Laut dem neuen Krankheitsverständnis muss es nicht unbedingt so sein, dass es ihm nachher schlechter geht.

Er nimmt all seinen Mut zusammen. So, jetzt probiere ich das einfach aus. Und ich weiss noch, wie ich dann... ja, wie so das warme Wasser wirklich genossen habe und wie so dieser bewusste Akt, nicht mehr diesen Symptomen einfach zuzuhören, sondern selber etwas bestimmen zu können, auch wenn es etwas ganz Kleines war. Für Jann fühlt es sich fast ein wenig an wie ein winzig kleiner Akt der Rebellion. Gegen die Symptome und gegen alle Empfehlungen.

Er geht duschen, auch wenn sein Körper ihm mit dem grössten Alarmsignal sagt, mach das nicht. Und dann ist es eben wirklich passiert, dass anstatt die Symptome schlimmer wurden, haben sie sich im Verlauf des Nachmittags ein wenig verflüchtigt. Die Symptome sind nicht schlimmer geworden. Und Jann hat einen ersten kleinen Beweis, dass das stimmen könnte mit dem neuroplastischen Ansatz. Eine erste kleine korrigierende Erfahrung, wie man in der Medizin so schön sagt.

Und das war wie ein Befreiungsschlag. Ab dann habe ich selber wieder ein bisschen das Zepter in der Hand gehabt. Ja, das ist ein sehr... einschneidender Moment gewesen, diese neue Freiheit zu spüren. Ich bin Zita Bauer und das ist der Podcast «So Long Covid». Eins, zwei, drei. Die vierte Folge. Wir haben gehört, dass es möglich ist, dass das Gehirn Symptome produziert, auch wenn strukturell nichts oder nichts mehr kaputt ist. Und dass es auch möglich ist, die chronischen Symptome wieder zu verlernen.

Wie genau das gehen soll, schauen wir uns in dieser Folge an. Wir starten mit einem kleinen Experiment, zur Veranschaulichung. Also... Es ist so kalt Das ist im Januar 2026. Jann und ich sind im tiefen Winter in Norwegen. Wir stehen auf einem Floß am Hafen. Es hat auch eine Sauna da. Es ist drei Uhr am Nachmittag und die Sonne ist schon hinter den Bergen untergegangen. Wir stehen hier in der Badehose, draussen auf Eis. Meine Füße sind schon ein bisschen am Gefrieren.

Es ist etwa wie kalt? Minus 5, Minus 10. Irgendwie so etwas. Wie kalt das Wasser ist, weiss ich nicht. Aber sicher kalt. Und ähm... Ich gehe jetzt Eisbaden. Gehe Eisbaden also. Okay. Eins. Lass mein Handy nicht ins Wasser fallen. Ist gut? Ist gut. Ich probiere es. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Das ist das einzige, was ich noch rausgebracht habe. Wenn man es sich nicht gewöhnt ist, so wie ich, dann ist es richtig unangenehm, in eiskaltes Wasser zu gehen.

Ich weiss, dass es mir als gesunde Person eigentlich nicht schadet. Im Gegenteil. Es soll gesund sein. Der Körper aber reagiert sofort mit Alarmsignal. Es nimmt mir den Atem, die Muskeln spannen sich an, das Herz rast.

Das kalte Wasser wird als Gefahr wahrgenommen. Mein Körper sagt mir: Raus. Diese Reaktion läuft automatisch ab. Unbewusst. Über die Zeit mit viel Trainieren kann ich die unbewussten Alarmsignale aber beeinflussen.

Ich kann meinem Körper beibringen, dieses eiskalte Wasser ist keine Gefahr. Du kannst entspannt weiteratmen. So wie das auch die vielen Eisbadenden hier im Norden machen. Wahrscheinlich haben sie schon als Baby trainiert. Ähnlich funktioniert es bei neuroplastischen Symptomen. Und natürlich ist es etwas anderes. Eisbaden ist eine freie Entscheidung. Krank sind sie nicht. Und trotzdem glaube ich, kann dieses Beispiel helfen, besser zu verstehen, wie man neuroplastische Symptome verlernen kann.

Das Gehirn umprogrammieren kann. Wir sprechen tatsächlich von «Brain Reprogramming». Was ein bisschen an Computer-Sprache erinnert, aber es funktioniert in der Hinsicht, was wir tatsächlich tun. Das ist Silje Endresen Reme, Schmerzpsychologin und Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Oslo. Sie ist sich das Eisbaden vielleicht eher gewöhnt. Sie spricht von «Brain Reprogramming». Es erinnert zwar ein wenig an Computersprache, passt aber gut für das, was sie machen.

Denn was wir tun, ist: Wir versuchen das Gehirn zu beeinflussen und ihm zu helfen die Symptome und die inneren Zustände des Körpers als gesund und nicht als bedrohlich, gefährlich zu interpretieren. Es geht darum, die Symptome neu zu interpretieren, als nicht bedrohlich, nicht gefährlich. Und wir machen das durch verschiedene Übungen. Aber zuallererst mit einer guten Erklärung, warum die Symptome anhalten und warum der Patient so eingeschränkt und so krank ist, wie es bei allen der Fall ist.

Wie wir in der letzten Folge schon erwähnt haben, ist der erste Schritt, die neurobiologischen Zusammenhänge der Symptome zu verstehen. In der Medizin nennt man das «Pain Neuroscience Education» oder auf Deutsch «Schmerz-Edukation». Es gibt nicht einfach ein Wundermittel, das man anwenden kann und dann wird man gesund. Es ist wie so ein ganzes Konstrukt von Techniken. Also bei mir hat es angefangen mit dem Wissen, also wirklich wie so das Verständnis, wie diese Krankheiten funktionieren und ein Vertrauen zu haben in dieses Wissen, also wie so in sich zu spüren, dass das wirklich stimmt.

Aufbauend auf dem Wissen gibt es dann verschiedene Techniken, die man anwenden kann. Das Ziel ist grob gesagt bei allen, die symptomauslösenden neuronalen Verknüpfungen durch neue, gesunde Verknüpfungen zu ersetzen. Wenn man schwer krank ist und sich fast nicht mehr bewegen kann, wie Jann und Patricia, kann man z.B. anfangen mit Visualisierungen. Im Spitzensport arbeitet man im mentalen Training schon länger damit. Und jetzt hat man das Potenzial von Visualisierungen auch in der Schmerztherapie entdeckt.

Man sitzt oder liegt hin, macht die Augen zu und erinnert sich an eine konkrete Situation, in der der Körper gesund war, in der er sich bewegt und gut angefühlt hat. Auch teilweise Visualisierungen von dem, was ich wieder will. Also ich habe mir eben immer vorgestellt, ich will wieder in der Aare schwimmen. Und das macht man dann so ganz mit Haut und Haar. Man versucht sich das vorzustellen, wie fühlt sich das an auf der Haut und überhaupt in der Bewegung.

Dort wo es möglich ist, versucht Patricia es sich nicht nur vorzustellen, sondern es tatsächlich auch wieder so zu machen, wie früher. Also z.B. beim Duschen war das so, dass ich eben nicht mehr gesessen bin beim Duschen, mich ganz langsam geduscht habe, sondern dass ich wieder diese... Bewegungsabläufe aufgenommen habe. Dass ich mich so geduscht habe wie früher. Mit der Idee, dass das ein gewisses Gedächtnis im Körper abrufen, das dann signalisiert bekommt, es ist wieder gut.

Es ist wieder... Ich kann wieder zurück in den Alltag. Das habe ich hilfreich gefunden. Was ich dann auch noch gemacht habe, ist quasi wie das Nervensystem auszutricksen und in die Bewegung hineingehen, aber in einem ganz anderen Kontext.

Z.B.

anstatt einfach weiterzulaufen, halt ein bisschen zu der Musik tanzen. Laufen hat bei Jann schlimme Symptome ausgelöst. Darum hat er versucht, auf eine andere Art in eine ähnliche Bewegung hineinzukommen. Statt das Laufen zu trainieren, beginnt er also in seinem Klinikzimmer zu tanzen. Statt Krafttraining surft er auf einer Pilatesrolle. Mit Visualisierungen von schönen Erlebnissen und einem neuen Umgang mit den Triggern kehrt wieder mehr Freude und Zuversicht in sein Leben zurück.

Jedes kleinste Ding, das Jann wieder konnte, z.B. im Stehen die Zähne zu putzen, haben wir zusammen gefeiert. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass wir hier nicht ins Detail von allen Therapiemethoden und ihren Anwendungen gehen können. Und sie wirken je nach Mensch auch unterschiedlich. Auf unserer Website haben wir eine Auswahl an Ressourcen von Fachpersonen zusammengestellt. Es gibt aber eine Technik, die sich besonders bewährt.

Laut den Experten und den Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist Somatic Tracking. Beim Somatic Tracking geht es darum, die Empfindungen, also die Schmerzen, die Symptome und auch die Emotionen, die aufkommen, nicht zu verdrängen oder kontrollieren zu wollen. Ihnen nicht mit Angst oder Vermeidung zu begegnen, sondern mit einer ergebnisoffenen und neugierigen Haltung. Man versucht, die Symptome als etwas Interessantes anzuschauen, das das Gehirn produziert hat.

Und wenn man das über längere Zeit immer wieder macht, dann kann man die neuronalen Verknüpfungen, die Symptome auslösen, verändern. Das Uminterpretieren von Symptomen war auch ein grosser Teil von Janns Genesung. Ein Symptom, das er immer wieder hatte, ist eine grosse Unruhe im Körper. Ein innerliches Flattern, Flimmern und Blubbern. Und diese Symptome habe ich mir wirklich vorgestellt, dass ich in einem Whirlpool sitze. Anstatt, dass das etwas Nerviges ist, das so weggeht, fand ich es quasi noch interessant, dem zuzuschauen.

Und wie spannend es ist, dass das Gehirn solche Dinge hervorrufen kann eigentlich. Sobald man das lösen kann von der Idee, dass das etwas Schlimmes bedeutet, dass das etwas bedeutet, dass der Körper strukturell kaputt ist. Kann man sogar Gefallen finden an diesen Empfindungen. Dass es eigentlich eine gratis Whirlpool-Session ist. Somatic Tracking ist eine Technik aus der Pain Reprocessing Therapy. Die wurde unter anderem von Howard Schubiner entwickelt.

Wir haben in der letzten Folge von ihm gehört. Ursprünglich ist Pain Reprocessing Therapy eine Methode für die Behandlung von chronischen Schmerzen. Eine randomisiert kontrollierte Studie zu chronischen Rückenschmerzen hat gezeigt, dass diese Methode im Vergleich zu Placebo und der aktuell üblichen Behandlung signifikant besser wirkt. Und besonders spannend ist, die Forschenden haben diese Therapie auch mit funktionellen MRI, also Scans des Gehirns, begleitet.

Sie konnten nachweisen, dass sich mit diesen Therapien auch die neuronale Schmerzverarbeitung verändert. Somatic Tracking kann man alleine machen, wie Jann im Whirlpool-Beispiel. Aber auch angeleitet mit einem Podcast oder YouTube-Video. Oder live in einer Therapiestunde. Bei Andreas Immel in der Länggasse in Bern zum Beispiel. Er ist ausgebildeter Masseur und Coach für Pain Reprocessing Therapy. Wir dürfen Andreas Immel während einer Übung mit einer Patientin begleiten.

Wir gehen jetzt erst nochmal ein bisschen in die Entspannung. Und um dich noch ein bisschen mehr in dieses Sicherheitsgefühl und in das Gefühl von Entspannung zu bringen, kannst du dir auch gerne jetzt mal etwas vorstellen, was du in den letzten Tagen so richtig toll fandest. Die Patientin ist einverstanden, dass man sie auch hört. Sie hat ein Chronisches Fatigue-Syndrom und ist heute vor allem wegen ihren starken Kopfschmerzen hier.

Zuerst hat Andreas Immel eine Entspannungsübung angeleitet. Und jetzt geht es ins eigentliche Somatic Tracking. Und jetzt schauen wir mal, wie in so einem Museum uns diese Gefühle da, die du in dem Kopf hast, vollkommen ergebnisoffen und neugierig an. Wir versuchen sie in keiner Weise zu verändern. Sie dürfen machen, was sie wollen. Sie dürfen stärker werden, schwächer werden, sich verändern in alle Richtungen oder auch gleich bleiben.

Und dann kannst du auch gerne mal beschreiben, wie sich das so anfühlt. Es fühlt sich irgendwie so konzentriert, dicht an. Wie so ein Druck, oder? Ja, so ein Druck, aber der irgendwie so links und rechts ein bisschen ausstrahlt und so wie ein bisschen elektrisch entlädt. Wenn das so ein Kunstobjekt wäre, wie würde das aussehen? Das wäre dann so wie eine Kugel mit so Stacheln. Andreas Immel begleitet die Patientin dabei, die Symptome neugierig und ergebnisoffen, fast schon belanglos zu betrachten.

Dann kannst du ruhig noch mal so ein bisschen drauf gucken, als wäre das gar nicht wichtig, als wäre das so einfach was Interessantes, was da, wie gesagt, wie in so einem Museum rumsteht oder in dir sich einfach bewegt. Ja es ist jetzt wie ein Punkt, mit dem man so spielen kann. Aha. Wie ist es von der Intensität so? Ist

deutlich zurückgegangen. Nach etwa 15 Minuten ist die Übung fertig. Dann kannst du wieder langsam hier im Raum ankommen.

Ja. Das war's schon. Nicht so spektakulär. Genau, kein Exorzismus oder so. Jann hat mehrmals pro Tag Somatic Tracking gemacht. Angeleitet mit einer App, quasi in Selbsttherapie. Mit der Zeit und viel Wiederholung hat er diese neugierige, interessierte und ergebnisoffene Haltung verinnerlicht, sodass sie automatisch präsent war, wenn er Symptome hatte. Die Lichtempfindlichkeit ist bei Jann mit dem Wissen von neuroplastischen Symptomen und Techniken wie Somatic Tracking nach etwa 3 Wochen verschwunden und auch nicht mehr gekommen.

Es kann schnell gehen. Bei anderen Symptomen ging es aber mehrere Monate, bis sie ganz verlernt waren. Das Uminterpretieren von Symptomen braucht Durchhaltevermögen. Da habe ich auch als Angehörige gemerkt. Ich bin selbst manchmal ungeduldig geworden. Ganz am Anfang habe ich es auch noch nicht richtig verstanden. Ich weiss noch, wie ich den Gedanken hatte, ah ok, jetzt weiss Jann ja, dass Symptome des Nervensystems erlernt sind, dass strukturell nichts kaputt ist.

Dann kann er es jetzt ja einfach umsetzen. Einfach die Angst verlieren und wieder die Treppe hochlaufen. Aber das ist falsch. Symptome werden durch neuronale Bahnen ausgelöst, die man nicht einfach so kontrollieren kann. Und wenn diese Bahnen mal gefestigt sind, dann werden diese schlimmen Schmerzen und die erdrückende Fatigue auch immer wieder ausgelöst. Man ist auch mit der Diagnose Neuroplastisches Syndrom noch ernsthaft krank.

Aber es verändert etwas, zu wissen, dass Symptome an sich nicht auf einen irreparablen Schaden hinweisen. Man kann dann anders auf sie reagieren und merken, dass sie sich auch nicht immer gleich verhalten. So war es bei Jann. Und um das zu verstehen, hat es mir geholfen, bei etwas anzuknüpfen, das ich selber kenne. Beim Eisbaden zum Beispiel. Wir kommen zurück zu meinem kleinen Experiment. Meine Füße sind schon gestorben. Ich stehe auf der obersten Stufe der Leiter, die ins eiskalte Wasser führt.

Irgendwo in der Nähe hat es eine Baustelle. Es brummt im Hintergrund. So, jetzt kann mich nichts mehr abhalten. Jetzt gehe ich rein. Und eben, was ich probiere ist, mir zu sagen, das Wasser schadet mir ja nicht. Im Gegenteil, man sagt ja, es ist gesund, das zu machen. Was ich jetzt versuche ist Somatic Tracking, also mit einer neugierigen Haltung, zu schauen, was sind das für Empfindungen? Wie fühlt sich das an? Und mich zu beruhigen und zu sagen, das schadet mir nicht, das tut mir sogar noch gut.

Und es ist sogar noch interessant. Und es ist sogar noch interessant. Das probiere ich jetzt. Also, ich probiere mir jetzt... Es ist ganz interessant. Es ist so arschkalt. Wie lange habe ich es ausgehalten? Keine halbe Minute habe ich es ausgehalten. Es ist so kalt. Obwohl ich gewusst habe, dass mir das kalte Wasser nicht schadet. Ich habe probiert, neugierig zu spüren, wie es sich anfühlt in diesem Wasser. Vielleicht habe ich es dank dem immerhin ein paar Sekunden länger geschafft.

Ähnlich ist es bei Schmerzen und Symptomen. Die neuronalen Verknüpfungen, die einen unbewusst krank machen, sind wie dicke Reifenspuren im Schlamm. Neue Spuren zu legen und Symptome zu verlernen, braucht Zeit und Wiederholung. Aber es ist möglich. So wie es auch möglich ist, dass ich durchs immer und immer wieder mache, ich länger im eiskalten Wasser bleiben kann. Wie die Leute, die hier im norwegischen Winter im eiskalten Meerwasser tiefenentspannt ihre Runden schwimmen.

Diese Technik Somatic Tracking funktioniert am besten, wenn ich wirklich vertraue, dass mir zum Beispiel das Eisbaden nicht schadet. Um neuroplastische Symptome zu verlernen, ist es wichtig, zu wissen und zu vertrauen, dass der Körper an sich nicht kaputt ist. Und auch mit einer gewissen Überzeugung. Man hat diese Überzeugung vielleicht nicht von Anfang an. Aber man kann darin hineinwachsen. Von dem erzählt Patricia. Ich muss in einen Zustand hineinkommen, oder ich will in einen Zustand hineinkommen, in dem ich einfach nicht mehr Angst habe und verzweifelt bin und wie verrückt versuche, irgendwelche Pläne einzuhalten und irgendwelche Pacing-Wecker zu stellen, damit ich genau nach 10 Minuten wieder aufhöre zu reden und mich wieder 10 Minuten ausruhen kann.

Also all das ist ja auch so ein Stresssystem. Und das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich habe mir selber verboten. Ich habe jetzt einfach keine Angst mehr und keine Verzweiflung. Und verbieten heisst natürlich nicht

einfach nur, ich bestrafe mich, wenn es nicht klappt, weil das ist genau das, was nicht geht, sondern ich muss diese Arbeit machen oder einen Weg finden. Und das war unendlich schwierig. Es war unglaublich schwierig, weil es lässt sich nicht erzwingen und es läuft nicht über eine Willenskraft, sondern es läuft wie nochmal über andere Kanäle.

Patricia beschreibt es als Gefühlszustand, in den sie hineinkommen musste. Quasi alles in mir drin, was Vertrauen hat oder irgendwie die letzten Resten von Erinnerungen an einen Körper, der gesund war, muss ich hervorholen und mobilisieren und einfach voll darauf setzen. Mein Experiment mit dem Eisbaden hat mir eine feine Ahnung gegeben, wie schwierig diese Genesungsarbeit ist, die Jann, Jasna, Marlen und Patricia gemacht haben.

Ich fand das eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Wenn man es so beschreiben will, dem Nervensystem, beizubringen du kannst wieder runterfahren, wieder zur Ruhe kommen. Das war etwas vom Schwierigsten, was ich in meinem Leben gemacht habe. Es ist überhaupt nicht so, dass es von einem Tag auf den anderen passiert und überhaupt nicht so, dass es eine einfache Sache ist. Und ich weiss auch nicht, ob das immer geht. Ich würde das auch nicht einfach verallgemeinern und sagen, das sollen jetzt alle so machen.

Aber für mich war es der Schlüssel und ich weiss es auch von vielen anderen. Darum glaube ich ist es ganz wichtig, dass man es kennt und dass man es bekannt macht, dass es für gewisse Leute tatsächlich der Weg raus ist. Die Aufgabe, neuroplastische Symptome umzuinterpretieren und zu verlernen, ist individuell und komplex. Und wie jede Therapie, hat auch sie ihre Grenzen. Das sagt auch Silje Endresen Reme, Professorin für Gesundheitspsychologie und klinische Schmerztherapeutin aus Oslo.

Was sind die Grenzen ihres Ansatzes und Programm? Ich denke, es gibt immer Grenzen. Es gibt nie eine Therapie, die allen hilft. Ich denke, es ist wichtig, das anzuerkennen, sogar Antibiotika hilft nicht allen. Keine wirkt bei ganz allen, auch nicht Antibiotika. Im Vergleich zu vielen Medikamenten hätten die Therapien vom neuroplastischen Ansatz einen entscheidenden Vorteil. Sie haben keine Nebenwirkungen und keine dokumentierten Risiken.

Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du nicht so gut darauf ansprichst. Es gibt keine dokumentierte Risiken bei diesen Ansätzen. Das Schlimmste, was passieren kann, sei, dass man nicht so gut darauf anspricht. Man könne nichts verlieren. Aus unserer eigenen Erfahrung wissen wir, man probiert so viel, man bekommt dauernd Tipps, was man alles noch könnte. Aber etwas Neues auszuprobieren, heisst immer auch, sich auf etwas einzulassen, Energie und Zeit zu investieren.

Und man riskiert Enttäuschungen. Das braucht Mut. Unsere Erfahrung zeigt aber auch, der Mut kann belohnt werden. Es kann funktionieren. Für einige passiert es ziemlich schnell. Ich habe einige solcher Fälle gesehen. In anderen Fällen kann es länger dauern, weil es andere Hindernisse und andere Dinge, die geklärt werden müssen – sozial, emotional oder anders. Jeder Weg ist einzigartig. Bei einigen gehe die Genesung ziemlich schnell.

Bei den anderen brauche es etwas länger. Nochmals zur Wiederholung: Das Wissen über neuroplastische Symptome ist die Basis. Und dann geht es darum, die Symptome mit verschiedenen Techniken umzuinterpretieren. Wie zum Beispiel Somatic Tracking. Und das geht nicht mit reiner Willenskraft, Kontrolle oder Druck. Jasna: Ich bin jemand, der immer auch etwas ungeduldig ist. Und ich möchte es gut machen. Es wird auch immer wieder erwähnt, dass viele Leute zu viel machen oder sich zu fest anstrengen oder es zu fest wollen.

Und ich bin sicher so eine Person. Dieser Prozess erfordert Geduld, Vertrauen, eine gewisse Gelassenheit und Selbstmitgefühl als Grundhaltung. Und zusätzlich zum Uminterpretieren der Symptome braucht es manchmal noch mehr. Eine Auseinandersetzung mit dem Umgang mit Emotionen. Oder eine grössere Veränderung im Leben. Dass man den Job wechselt zum Beispiel. Jeder Genesungsweg ist individuell. Kleinere und grössere Rückfälle gehören aber bei fast allen dazu.

Die Rückfälle kann ich dir wahrscheinlich nicht aufzählen. Und in diesen Momenten ist es sehr, sehr schwierig, daran zu glauben. Ich habe immer noch ab und zu Zweifel. Der Zweifel ist häufig da. Und was mir dann sehr geholfen hat, sind Recovery Stories, diese zu lesen. Und dann gibt mir das viel mehr Sicherheit. Und dann geht es mir gleich schon besser. Ganz viele Menschen denken, sie machen es falsch. Es funktioniert bei allen anderen, aber bei Ihnen nicht.

Antje Kallweit, Schmerztherapeutin aus Hamburg. Einer meiner Hauptsätze ist: Haben Sie Geduld. Es dauert seine Zeit. Ihr Gehirn hat Sie lange, lange, lange mit diesen Mechanismen beschützt. Es möchte sich eigentlich nicht so gerne verändern. Unser Gehirn verändert sich ungerne. Es hält gerne an dem fest, was es gut gelernt hat. Und es braucht seine Zeit. Und Symptome gehen zum Schluss. All das braucht an Vertrauen. Und deswegen ist es wichtig, dass einer da ist und das immer mal wieder sagt.

Es hilft, wenn man eine Fachperson an der Seite hat. Als Jann krank war, im Frühling 24, wussten wir in der Schweiz aber von niemandem, der diese Arbeit macht. Ich habe ja den Bericht gelesen von deinem Jann. Janns Genesungsgeschichte. Da habe ich ja Gänsehaut bekommen bei dem Moment, wo er gesagt hat, ich mache das jetzt einfach. Egal, ich gehe jetzt unter die Dusche. Das ist super super mutig. Und ich würde mir wünschen, dass diesen Mut jemand sozusagen unterstützt.

Er hatte ja diese Unterstützung, soweit ich das verstanden habe, nur aus den Büchern. Aus dem, was er sich angelesen hat. Und wo er gesagt hat, so what, egal. Und jetzt geht es los. Einen Support, das hätte ich ihm gewünscht. Jemand, der ihm ein Stück weit ein Geländer bietet. Und er sich nicht komplett alleine die 10 Meter ins tiefe Wasser stürzen muss. Du hast dir eigentlich alles selber beigebracht. Du hast Videos geschaut.

Du hast Podcasts gehört. Ja. Das ist das grosse Glück, dass die Forschung von chronischen Schmerzen schon recht fortgeschritten ist. Und dass es schon recht viel Material online gibt, wo man sich selber informieren und sich aneignen kann. Auch mit der Curable App, die mir dann sehr fest geholfen hat. Curable ist eine App mit mehreren Übungen, die wir in dieser Folge besprechen. Den schriftlichen Genesungsbericht von Jann, den Link zur App und zu anderen Ressourcen findest du auf unserer Website.

Und natürlich auch der Austausch mit dir war dann sehr schön. Jemanden zu haben, der mich auf das aufmerksam gemacht hat. Und dann haben wir ja quasi zusammen diese Welt entdeckt. Als Jann mit dem neuroplastischen Ansatz begonnen hat, haben wir nur die englischsprachigen Apps und Bücher gekannt. Und nur von Therapeut:innen im Ausland gewusst. Man ist ein wenig verloren. Ich war schon Monate alleine und habe zuhause meine Sachen gemacht.

Aber es tut sich etwas. Und jetzt ist es so, dass ich dir vorher etwas verschwiegen habe. Die Patientin, die der Therapeut Andreas Immel behandelt hatte, die mit dem Kopfweg, das sich so anfühlt wie eine Kugel mit Stacheln, vielleicht hast du es sowieso schon gemerkt. Das ist Jasna. Als Jasna mit dem neuroplastischen Ansatz begann zu arbeiten, sind schon mehr Fachpersonen in der Schweiz damit vertraut. Dass sie Andreas Immel kennengelernt hat, war aber einmal mehr ein riesiger Glücksfall.

Plötzlich ist man wie in einem Film und hat das Gefühl, es passiert Zufall über Zufall. Vor gut einem Jahr, Anfang 25, hat sie wegen ihrem starken Kopfweg einen Massagetermin gebucht. Als der Masseur fragt, wie es ihr geht, erzählt sie ihm von ihrer neuesten Entdeckung, dem neuroplastischen Ansatz. Sie erwähnt ein Buch, das sie gerade am lesen ist. «Wege aus dem Schmerz» von Alan Gordon, Psychotherapeut und Mitgründer der «Pain Reprocessing Therapy».

Dann habe ich ihm ein bisschen erzählt und dann meinte er: Ah, meinst du das Buch hier? Und dann schaue ich rechts von mir und sehe genau das Buch, das ich am Lesen bin. Und ich dachte mir, das kann doch nicht so ein Zufall sein! Dann sagte er: Ja er sei auch Coach dafür. Er habe eine Ausbildung gemacht. Dann haben eigentlich auch an diesem Tag das schon ein bisschen angeschnitten. Und ich habe schon dann gemerkt, das hat mir wahnsinnig gut getan.

Es ging mir wirklich viel besser danach. Alle Symptome sind wieder zurückgekommen, wie es so typisch ist im Prozess dieser Therapie. Aber es war schon so: Ich kann mich gut fühlen. Und das ist wirklich... ein Zufall... Oder wie sagt man? Zufall, Schicksal, wie auch immer. Schicksal, ja, Schicksal. Andreas Immel hat seine Therapie nicht für Long Covid angeboten. Wie wir schon gehört haben, wurde die Pain Reprocessing Therapy für chronische Schmerzpatient:innen entwickelt.

Mit der Zeit haben ihn aber immer mehr auch Long-Covid-Patient:innen kontaktiert. Weil sie gehört haben, dass diese Methode auch bei ihren Symptomen helfen kann. Und weil auch die Studienlage immer besser wird und das unterstützt, dass den Leuten geholfen werden kann, habe ich gesagt, wir können es gerne probieren.

Aber wenn ich dir nicht helfen kann, dann sage ich es dir auch. Es werde teilweise undifferenziert über Long Covid berichtet, sagt Andreas Immel.

Auch dort knüpft seine Motivation an, mit Long-Covid-Betroffenen zu arbeiten. Weil ich es leider auch ziemlich unverantwortlich finde, wie manche Ärzte im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zum Beispiel einfach erzählen, dass es unheilbar sei. Was ich sehr schlimm finde, das so zu sagen, auch wenn man es vielleicht glaubt und vielleicht auch gute Gründe hat, es zu glauben. Man kann ja sagen, nach meinem momentanen Wissensstand ist es unheilbar.

Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber wenn man nur sagt, es sei unheilbar, tue man so, als wäre das abschliessend geklärt. Es gibt einen SRF-Artikel aus dem Jahr 2023, den mehrere der Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe, erwähnt haben. Geblieben ist ihnen der Titel. Wer nach sechs Monaten noch Symptome hat, erholt sich nicht. Für Betroffene ist das ein Hammer. Nach sechs Monaten ist das eigene Schicksal besiegelt.

So ähnlich habe es auch in der Reha-Klinik geklungen, erzählt Jann. Mir wurde dort gesagt, dass es nicht darauf ankommt, ob ich jetzt noch zwei Wochen länger in der Klinik bin. Weil man in so einem schlimmen Fall eigentlich von Jahren spricht. Kleine Klammer: Die Reha-Klinik Gais hat zu diesem und allen anderen Zitaten im Podcast nicht Stellung nehmen wollen. Man dürfe sich ja nicht überbelasten. Denn das führe zu einer Verschlechterung der Symptome, zu diesen Crashes.

Und die Crashes seien langfristig schädlich, unumkehrbar. Das ist die gängige Sichtweise, die von vielen Therapeut:innen, Ärzt:innen und Betroffenenorganisationen vermittelt wird. Auch in vielen Medienberichten wird Long Covid so erklärt. Und meiner Theorie zufolge ist genau dieses Mindset das, was die Symptome noch stärker machen kann oder sogar mit am Leben halten kann. Und dann könne es eben passieren, dass die Patient:innen resignieren und die Verzweiflung noch grösser wird.

Und die Ärzte, die wissen das ja. Also hoffentlich. dass die Leute wirklich ganz schlimm leiden. Und da muss man sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen, dass es unheilbar ist. Aber auch mit Aussagen, hey, ich kann dir helfen. 100%. Es ist erforscht, dass die eigenen Erwartungen den Krankheitsverlauf beeinflussen können. Sowohl positiv als auch negativ. Du hast sicher schon vom Placebo-Effekt gehört. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass eine positive Erwartung die Wirksamkeit einer Therapie signifikant beeinflussen kann.

Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass Patient:innen mit positiven Erwartungen bessere Operationsergebnisse haben. Es gibt aber auch das negative Gegenstück zum Placebo-Effekt. Den Nocebo-Effekt. Nocebo heisst auf Lateinisch «Ich werde schaden». Und da meint der Nocebo-Effekt auch. Negative Erwartungen können den Krankheitsverlauf negativ beeinflussen. Auch das ist wissenschaftlich belegt. Jann ist überzeugt, dass die negativ geprägten Geschichten über Long Covid, die er immer wieder gehört hat, seinen Krankheitsverlauf beeinflusst hat.

Die haben mich sogar krank gemacht. Dass es so schlimm kam, war wegen dem Narrativ. Dass die Überbelastungen so schlimm seien, dass man das so fest wie möglich vermeiden soll. Und vor allem, die Voraussage, dass wenn man das zu lange hat, dass sich das chronifiziert und dass es dann nie mehr weggeht. Diese Perspektive hat viel dazu beigetragen, dass es dann wirklich so schlimm kam. Davon bin ich überzeugt. Die Annahme, dass Symptome grosse Gefahr darstellen, die Annahme, dass Crashes strukturelle Schäden im Körper hinterlassen, halten den Alarmzustand des Nervensystems aufrecht.

Entsprechend hat Jann sein Verhalten angepasst. Er hat auf jede Verschlechterung fokussiert, sich möglichst geschont und Anstrengung vermieden. Geht man vom neuroplastischen Ansatz aus, werden durch dieses Verhalten die krankmachenden neuronalen Bahnen noch mehr verstärkt. Ein Teufelskreis. Die Chronifizierung der Symptome ist in diesem Sinne ein Lernprozess des Gehirns und Nervensystems. Wie wir jetzt aber wissen, können die neuroplastischen Symptome auf dem umgekehrten Weg auch wieder verlernt werden.

So sind Patricia, Jann, Jasna und Marlen Reusser und viele andere schlussendlich genesen. Etwas ist mir an dieser Stelle wichtig. Das darf nicht missverstanden werden. Das neuroplastische Verständnis von Long-Covid-Symptomen und wie Betroffene diese verlernen konnten, hat nichts mit einem reinen Nocebo- und Placebo-Effekt zu tun. Die Genesung von neuroplastischen Symptomen ist weit weg von «einfach ein bisschen positiv denken» oder «einfach schnell das Mindset ändern».

Oder wie Patricia sagt: «Es ist eine schreckliche Krankheit und das geht überhaupt nicht darum, zu sagen, dass man sich das einbildet und wenn man dann mal merkt, man hat sich das eingebildet, dann kann man sich das wieder ausbilden und die Sache ist gelaufen. Sondern die Symptome sind real und die Schmerzen sind real und die Einschränkungen sind real und sie sind schrecklich. Es geht darum, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen.

Mit viel Wiederholung, Zeit und Zuwendung. Dies mussten Patricia, Jann, Marlen und Jasna ziemlich alleine machen. Ich meine, da bin ich auch sehr privilegiert, muss ich jetzt sagen, weil ich habe die Tipps bekommen von Jann. Ich konnte die Bücher lesen, die viel auf Englisch sind. Nicht alle haben diese Möglichkeit. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich das so machen konnte. Ich konnte meine Perspektive ändern. In der Klinik und auch in der Long-Covid-Sprechstunde, wo Jann war war von diesen neurobiologischen Erkenntnissen und darauf aufbauenden Behandlungstechniken nie die Rede.

Auch nicht von der realistischen Möglichkeit, zu genesen. Heute, zwei Jahre später, ist das anders. Wir vermitteln, wenn immer möglich, ganz, ganz früh in dem Prozess, Genesung ist möglich. Die Erforschung und die Verbreitung von neuem Wissen braucht seine Zeit. Aber mittlerweile kommt etwas in Bewegung. Auch in der Schweiz. Im Rahmen meiner Recherchen habe ich das Universitätsspital Basel angeschrieben. Sie sind Teil einer gross angelegten europäischen Studie über Long-Covid.

Anfrage für So Long Covid... Ich wollte wissen, was ihre aktuellen Studienergebnisse sind. Und welche Rolle spielt Neuroplastizität? Ich glaube, dass die Ansätze Neuroplastizität, neuroplastische Symptome, viel Potenzial haben, Innovation zu bringen und neue Wege zu öffnen, dass möglichst viele Patient:innen eine Chance haben, Genesung zu erfahren. Da dann in der nächsten Folge. Am Sonntag, 5. April 2026. «So Long Covid» ist eine unabhängige Podcast-Serie von Jann Zosso und mir, Zita Bauer.

Eins, zwei, drei. Die vierte Folge. Alle Infos und erwähnte Ressourcen findest du auf unserer Website solongcovid.ch Originalmusik: Janos Mijnsen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign: Christina Baron. Dramaturgische Beratung: Franziska Engelhardt. Redaktionelle Mitarbeit: Stella Bollinger. Sprachregie: Irene Müller. Aufnahmestudio: Radio RaBe. Host und Schnitt: Zita Bauer. Produktion, Konzept und Redaktion: Jann Zosso und Zita Bauer.

SO LONG COVID

Folge 5: So Long Cohen

Lesefassung der deutschen Untertitel

Du hörst den Podcast «So Long Covid». Die fünfte von sechs Folgen. Diese sechs Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Guten Abend geschätzte Fahrgäste, wir treffen in einigen Minuten in Basel SBB auf Gleis 11 ein. Ausstiegsseite in Fahrtrichtung links. Heute steht ein Besuch am Universitätsspital Basel an. Jetzt bin ich, glaube ich, am richtigen Ort ... Ich stehe vor einer grossen Metalltür.

Man könnte schon fast sagen ein Tor. Wie komme ich denn jetzt hier rein? Ich sehe keine Türklinke, keinen Schalter. Und dann geht sie plötzlich von selber auf. Ich treffe Katrin Bopp, Fachärztin für Innere Medizin und Kaderärztin an der medizinischen Poliklinik. Sie und ihr Team haben 2021 eine der ersten Post-Covid-Sprechstunden in der Schweiz gegründet. Sie mussten sehr lachen, als wir die Anfrage für das Interview geschickt haben.

Und zwar wegen dem Namen des Podcasts. Was ist die Geschichte dahinter? Dass wir unter diesem Titel unsere letzten Vorträge tatsächlich auch gehalten haben. Und dass ich das natürlich absolut spannend fand, dass es jetzt eine Podcast-Reihe mit dem gleichen Titel geben wird. Als Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde gibt Katrin Bopp regelmässig Vorträge für andere Fachpersonen. Unter demselben Titel: «So Long Covid». Die Geschichte bei uns dahinter ist, dass ich mich eine Zeit lang mit Leonard Cohen beschäftigt habe.

Und es gibt einen Podcast zu Leonard Cohen. Und der Titel? Da war ein Bild von Leonard Cohen und dabei stand «So Long Covid»... Zumindest habe ich das so gelesen. Und dann wurde mein Gehirn aufmerksam. Das stimmt jetzt irgendwas nicht. Warum ist da ein Bild von Leonard Cohen und Covid? Und dann wurde mir klar: Ich habe für den Bruchteil einer Sekunde das, was ich gerade die ganze Zeit mache, nämlich mich mit Long Covid zu beschäftigen, Hat mein Gehirn einfach die Buchstaben gelesen, die es kannte.

Obwohl da was ganz anderes stand. Da stand nämlich natürlich «So long, Cohen». Das Gehirn Katrin Bopp hat aus «So Long Cohen» «So Long Covid» gemacht. Das ist etwas, was uns Menschen ständig passiert. Wir haben es in der dritten Folge schon davon gehabt: «Predictive Processing» oder «Coding» nennt man diesen Mechanismus. Das ist evolutionär bedingt so. Unser Gehirn verbraucht relativ viel Energie. Und das ist ein Energiesparmodus sozusagen.

Wenn es nicht jeden Gedanken neu zu Ende bringen muss, jede Sensation immer analysieren muss, dann sparen wir schon mal durch eine Vorhersage. Und das Zweite ist, dass wir uns natürlich besser schützen können, wenn wir einer potenziellen Anstrengung oder Gefahr immer einen Schritt voraus sind. Unser Gehirn probiert ständig vorherzusagen, was wir als Nächstes sehen, hören oder eben auch spüren. Ausgehend von unseren Erfahrungen.

Und dabei passieren quasi auch Fehler. Und genau das passiert auch bei neuroplastischen Symptomen. Das Gehirn rechnet mit einer Gefahr und schickt Symptome. Obwohl die Körpersignale, die an das Gehirn gesendet werden, eigentlich ungefährlich sind. Weil das Predictive Processing in ihrer Arbeit mit Long-Covid-Patient:innen zentral ist, hat Katrin Bopp diese kleine Verwechslung Cohen – Covid als Anekdote ihre Vorträge eingebaut.

Wir haben das dann mitgenommen in unsere Vorträge, um eben zu zeigen, wo das überall passiert. Und um einfach auch die Bedeutung dieses Satzes mit hineinzubringen, weil es hat etwas von Abschied, «so long», es hat etwas von es ist unendlich lang, «soo long», Und es hat aber auch etwas von «So, Long Covid». Jetzt lass uns mal reden. Das ist «So Long Covid». Eine unabhängige Podcast-Serie. Ich bin Zita Bauer, Sozialanthropologin und Journalistin.

Du hörst die fünfte Folge «So Long, Cohen». So, Long Covid. Lass uns mal reden. Und dafür gehen wir ins Büro von Rainer Schäfert. Professor und Chefarzt für Psychosomatik am Universitätsspital Basel. Weil Long Covid so komplex ist, arbeiten sie am Unispital interdisziplinär. Und genau aus dem Grund wollten Rainer Schäfert und Katrin Bopp das Interview zusammen machen – wegen ihrer engen Zusammenarbeit über die Abteilungen hinweg.

Vor allem da eben auch bezogen auf die Sprechstunde für Long-Covid und mittlerweile auch allgemeiner für Fatigue-Patient:innen. Das ist für uns eine sehr wichtige Kooperation, in der wir auch ein Forschungsprojekt zusammen machen zum Thema Long-Covid. Das Team in Basel ist Teil eines gross angelegten europäischen Forschungsprojekt: Horizon Europe Long Covid. Das ist ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Forschungsgruppen: Virolog:innen, Forschende, die Mausmodelle machen, Expert:innen für Blutgerinnung und so weiter.

Und wir haben da als Konsortium wirklich von allen Seiten diese Post-Covid-Syndrome untersucht. Und ich habe erwartet, wir werden etwas finden. Und ich bin immer noch überrascht, dass wir biomedizinisch fast nichts gefunden haben. Also keine eindeutigen, klaren Erklärungsmöglichkeiten. Es gebe nicht die eine körperliche Ursache für Long Covid. Die wichtigste Nachricht ist, bis zum heutigen Tag gibt es nicht den einen Pathomechanismus, den man irgendwie messen könnte.

Weder in der Bildgebung noch in der Blutuntersuchung. Es gibt unzählige Antikörper, die untersucht worden sind, die aber bei Gesunden genauso vorkommen. Oder deren Beseitigung die Symptome nicht beseitigt. Und ich glaube, diese Kontextinformationen sind für Betroffene, die sich ja in einem Meer von Informationen orientieren müssen, sehr, sehr wichtig. Und das ist eigentlich ohne jemanden, der sich da in dem Thema auskennt, fast nicht möglich.

Um all diese Informationen aus Berichten und Studien einzusorten und zu beurteilen, braucht es Fachwissen und Erfahrung. Krankheitsbilder von Long-Covid sind vielfältig. Man zählt bis zu 200 Symptome zu dieser Krankheit. Betroffene haben im Durchschnitt zwölf davon. Das macht das Verorten des eigenen Zustandes noch schwieriger. Dazu kommen die unterschiedlichen Geschichten. Wir sehen in unserer Sprechstunde Betroffene, die in ihrer Geschichte, in ihrer Biografie Depression, Trauma, Angst, Autismus, ADHS, Burnout, Schlafstörung, Schmerz mitbringen.

Wir sehen aber auch welche, die haben das nicht. Bei einer Krankheit und ihrer Genesung gibt es immer mehrere Aspekte. Neben den körperlichen können auch psychische und soziale Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel Einsamkeit oder finanzielle Sorgen. Das ist bei jeder Krankheit so. Auch bei einem gebrochenen Bein kommt es für den Verlauf darauf an, wie es uns geht und ob wir vielleicht noch zusätzliche Belastungen haben. All diese Faktoren mitzubeachten, ist eine grundlegende Erkenntnis in der Medizin.

Man spricht vom biopsychosozialen Modell. Und wir haben bei denen, deren Depression im Verlauf besser geworden ist, aber gemerkt, die Symptome bleiben ganz oft. Und wir haben auch Patienten gehabt, die von diesen Faktoren, die wir Vulnerabilitätsfaktoren nennen, gar nichts hatten und trotzdem Symptome hatten. Obwohl man bei Long-Covid-Patienten strukturell nichts gefunden hat, hat es nicht gereicht, einfach die psychosozialen Faktoren zu behandeln, erklärt Katrin Bopp Irgendein Puzzleteil hat ihnen noch gefehlt.

Und du kannst dir vorstellen, was es war. Das neue Wissen aus der Neurobiologie und der modernen Schmerztherapie. Das war für uns ein ganz wichtiges Puzzleteil. Da hängt die Neuroplastizität des Gehirns mit der Theorie von Predictive Processing oder Coding ganz eng zusammen. Und dem nachzugehen, da mehr Wissen anzueignen, war für uns ein ganz, ganz relevanter Faktor, dass unser Erklärungsmodell zu dem werden konnte, was wir heute in der Sprechstunde erklären können.

Sie haben am erwähnten EU-Forschungsprojekt mitgearbeitet, haben sich mit internationalen Kolleg:innen ausgetauscht, unzählige wissenschaftliche Papers gelesen, Kongresse besucht und von Patient:innen gelernt. Und mit all dem ist das Team vom Unispital Basel zum gleichen Schluss gekommen wie die Expert:innen, die wir in den letzten Folgen gehört haben. Dass bei einem grossen Teil der Long-Covid-Betroffenen neurobiologische Mechanismen eine wichtige Rolle spielen.

Das Gehirn und das Nervensystem haben Krankheitssymptome erlernt. Und erlernt bedeutet in dem Zusammenhang auch nicht, ich habe Vokabeln gelernt, ich habe das aktiv gemacht, dass dieses Symptom kommt. Sondern es gibt Menschen, bei denen nach einem Ereignis, im Fall von Long-Covid, der Covid-Infekt, neuronale Netzwerke im Gehirn bestehen bleiben, obwohl die akute Situation vorbei ist. Das scheint besonders bei Menschen so zu sein, die gut lernen können, wo das Gehirn schnell verknüpft.

Und das suchen die sich nicht aus, sondern das passiert einfach. Ihr neuroplastisches, biopsychosoziales Erklärungsmodell zeige Wirkung. Ihr seid überzeugt davon und fahrt weiter mit dem. Ja, absolut. Wir sehen, wir hören ganz viele Rückmeldungen auch da dazu von Betroffenen, und wir sind überzeugt davon, dass das eine sehr, sehr, sehr grosse und relevante Rolle spielt. Ja. Die Patient:innen in der Post-Covid-Sprechstunde in Basel hören heute schon ganz früh: Genesung ist möglich. Gleichzeitig ist es ganz wichtig, dass kein Schuldgefühl entsteht, wenn Genesung nicht so läuft, wie der oder die Betroffene sich das vorstellt.

Nicht, ich mache es nicht gut genug, es gelingt mir nicht. Sondern, dass man diesen Grat zusammen geht und aushält. Man kann Genesung nicht erzwingen. Und grundsätzlich ist auch jeder Genesungsweg unterschiedlich, weil auch die Voraussetzungen von allen unterschiedlich sind. Es gibt Patientinnen, die aus einem sehr gesunden Zustand heraus auch Covid- und dann Post-Covid-Beschwerden entwickeln. Ein Grossteil der Patientinnen aber, die haben vorher sozusagen schon signifikante Belastungen in ihrem Leben.

Und das ist schwieriger dann. Da braucht es noch eine spezifischere Unterstützung, die wir eben versuchen, in diesem multidisziplinären, interprofessionellen Team auch aufzufangen. Und nicht jeder bekommt das Gleiche dann. Die Therapie sei individuell gestaltet. Aber bei allen geht es in einem ersten Schritt darum, die Sicherheit und das Vertrauen zu stärken. Da gehören die differenzial-diagnostischen Abklärungen mit rein. Dass man sich sicher sein kann, dass nicht etwas übersehen wurde.

Dass man Vertrauen fassen kann, dass der Körper an sich nicht kaputt ist. Auch wichtig ist eine stabile Beziehung zwischen den Fachpersonen und den Patientinnen. Und auf dieser Grundlage findet dann Therapie statt. Diese beinhaltet in Basel ziemlich die gleichen Punkte, die wir in der letzten Folge vorgestellt haben. Als Erstes auch Edukation. Also zu informieren, wie neuroplastische Symptome entstehen. Und dann geht es um das Uminterpretieren der Symptome.

Für die akuten Symptome empfiehlt auch Rainer Schäfer Somatic Tracking. Also die Symptome neugierig und ergebnisoffen zu beobachten. Und dann geht es weiter stärker ins Tun. Da gibt es häufig Vermeidungsverhalten oder Schonverhalten, das sich eingespielt hat. Eigentlich, weil ich mich schützen will. Eigentlich, weil ich gut für mich sorgen will. Aber das kann meine Beschwerden verstärken. Und wenn ich das verstanden habe, muss ich anfangen, dieses Vermeidungsverhalten, dieses Schonverhalten abzubauen.

Seit Anfang Jahr bieten sie ihren Patient:innen eine Gruppentherapie an, in der sie das alle gemeinsam machen. Es geht darum, sich Schritt für Schritt beizubringen, dass die Symptome nicht gefährlich sind. Schritt für Schritt Sachen wieder zu machen. Und dabei am Gehirn zu vermitteln, du bist in Sicherheit, du kannst vertrauen. Neue Handlungen, etwas anderes zu tun, das ist die am stärksten veränderungswirksame Information, die ich meinem Hirn geben kann.

Wenn ich wirklich etwas Neues tue, dann fängt das Hirn an umzudenken. Seit knapp zwei Jahren beschäftigen sie sich am Unispital Basel mit Neuroplastizität und Predictive Processing. Mit der Zeit wurde ihnen immer klarer, was für eine wichtige Rolle diese für Long-Covid-Symptome spielen. Und auch, wie viel Forschung es schon dazu gibt. Immer mehr sind diese Erkenntnisse in die Sprechstunden und Therapie eingeflossen. Heute verstehen und behandeln Katrin Bopp, Rainer Schäfer und ihr Team Long Covid als neuroplastischen Symptomkomplex.

Damit leistet sie Pionierarbeit in der Schweiz. Es ist bis jetzt noch eher Es ist eine kleine Gruppe von Menschen, die mit dem Ansatz unterwegs sind. Wir hören aber von unterschiedlichen Seiten, dass man darauf kommt, dass diese Erkenntnisse sich verbreiten. Neben Basel wissen wir vom Kantonsspital Luzern, dass sie die neurobiologische Erkenntnis ins Therapiekonzept integriert haben. Lara Diem, die Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde, schreibt auf Anfrage: ihr sei der neuroplastische Ansatz gut bekannt und sie beurteile die Behandlungsmethoden als wissenschaftlich plausibel.

Brain Retraining, also das Uminterpretieren von Symptomen, sei ein Baustein ihrer Therapie. Andere Spitäler haben schon davon gehört, finden es interessant und sehen darin einen möglichen Lösungsweg. Sie haben aber nicht die Ressourcen, um seriös damit zu arbeiten. So zum Beispiel habe ich es von Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern gehört. Sie ist in der ersten Folge des Podcasts vorgekommen. Wir haben einfach kein Personal, das momentan dafür abgestellt werden könnte, um das mit den Patienten zu machen.

Aber wenn ich mehr Personal hätte, würde ich das sicherlich machen. Wieder andere Spitäler wollten keine Stellung nehmen. Es ist momentan ein Zufall, ob man einen Arzt oder eine Ärztin trifft, der die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Schmerztherapie in die Behandlung integriert. Das ist auch Katrin Bopp klar, die Leiterin der Post-Covid-Sprechstunde am Unispital in Basel. Uns ist bewusst, dass es immer noch sehr unterschiedliche Ansätze gibt, was es auch für die Betroffenen sehr, sehr schwierig macht, wenn manche Ärzte immer noch von einer schweren, unheilbaren Erkrankung sprechen, und andere mit einem anderen Konzept kommen.

Und ich glaube, im Moment kann man da nur draufschaun, ohne das zu bewerten. Wir können anbieten, was wir wissen und können. Und wir können das gut fundiert erklären. Es ist aber tatsächlich so, dass die Landschaft da nicht einheitlich ist. Wie lässt sich das erklären? Wieso verbreitet sich der Ansatz, der ja bei ganz vielen zu funktionieren scheint, nur zögerlich? Wieso stösst er im Gegenteil teilweise auf starken Widerstand?

Wieso hört man denen, die genesen sind, nicht mehr zu? Diese Fragen haben mich während der gesamten Recherche beschäftigt. Und ich habe sie auch x verschiedenen Interviewpartner:innen gestellt. Okay, nun kommen wir zu der Frage: Warum diese neurowissenschaftlichen Ansätze... aus dem chronischen Schmerz noch nicht angekommen sind. Noch nicht. Warum ist das so? Wie sieht es in der Schweiz aus? Wieso ist das noch nicht Mainstream?

Es ist wie bei einer Zwiebel, man muss sie ein bisschen schälen. Diese Stimme kennst du noch nicht. Das ist Monica Greco. Sie ist Professorin für Soziologie an der University of Bath in England. Ihre Forschung bewegt sich an der Schnittstelle von Soziologie, Geschichte und Philosophie. Mit einem Schwerpunkt auf psychosomatischer Medizin. Ihre Antwort auf meine Frage: Die unmittelbarste Antwort auf diese Frage könnte lauten, dass es an der medizinischen Ausbildung in diesem Bereich mangelt.

Dass das Wissen schlicht zu wenig im Medizinstudium thematisiert wird. Wo die physikalische Medizin und die Psychiatrie sehr getrennt sind, befinden sich diese Krankheitsbilder in einem Niemandsland. Weil physische und psychische Gesundheit häufig getrennt angeschaut werden, fallen diese Erkenntnisse zwischen Stuhl und Bank. Ich frage mich schon ein bisschen, was haben wir eigentlich gelernt? Denn ich habe nie mit diesem Filter gehört, wie ich es heute tun würde.

Die Radsportlerin Marlen Reusser, die in Bern Medizin studiert hat. Es wurde immer klar unterschieden zwischen rein körperlichen Krankheiten und solchen, die eigentlich dem Geist entspringen und auf die Physis eine Auswirkung haben. Ich würde mal, vielleicht werde ich korrigiert von Leuten, ich bin sehr offen, aber ich würde das mal grundsätzlich so unterscheiden. Und diese Unterscheidung, die würde ich eigentlich heute nicht mehr unterschreiben.

Neue Ideen brauchen immer Zeit, bis sie in die Ausbildung der Ärzt:innen durchsickern. Und auch das Wissen um das neuroplastische Entstehen von Symptomen, das ist neu in der Zeitrechnung der Medizin. Silje Endresen Reme hat in der letzten Folge von fünf Jahren gesprochen, seit der Paradigmenwechsel passiert ist: Dass man nicht mehr nur von Symptomlinderung spricht, sondern immer mehr von Genesung. Auch die Schmerztherapeutin Antje Kallweit erwähnt die noch junge Entwicklung.

Erst 2017, also vor neun Jahren, hat die Internationale Vereinigung für Schmerzforschung, IASP, eine neue Schmerzkategorie eingeführt: nozioplastische Schmerzen. Also so jung ist das. Das ist in der Medizin gar nichts. Vom ersten Begriff und Auftauchen in den offiziellen Leitlinien... Es ist kein Wunder, dass das in vielen Köpfen noch 0,0 drin ist. Nozioplastisch meint praktisch das Gleiche wie neuroplastisch. Es ist ein wenig verwirrend mit all diesen Begriffen: Mind Body, neuroplastisch und nozioplastisch.

Das ist eben dem geschuldet, dass das Wissen noch nicht so etabliert ist. Und dann gibt es ja auch noch die Begriffe psychosomatisch und funktionelle Störung. Diese gibt es schon länger und beschreiben körperliche Symptome ohne strukturellen Schaden. Sie sind aber weit gefasst und werden teils missverstanden. Heute ist man einen Schritt weiter und kann es aufgrund der neurobiologischen Erkenntnisse präziser beschreiben. Mit dem Begriff neuroplastisch oder nozioplastisch.

Und das Entscheidende ist, es gibt konkrete Therapien, die auf dieses neue Wissen aufbauen. Mit der Perspektive, dass die Genesung möglich ist. Aber jetzt fertig mit diesem Begriffs-Exkurs. Eigentlich waren wir ja

bei der Frage, wieso sich dieses Wissen um neuroplastische oder eben nozioplastische Symptome nur zögerlich verbreitet. Eine Antwort ist, dass es noch nicht so viele Studien dazu gibt. Und MedizinerInnen haben aus sehr guten Gründen gerne viele Studien.

Es gibt noch nicht so viele, weil dieses Wissen eben noch relativ neu ist. Das ist ein Grund. Ein weiterer, noch fast wichtigerer, ist das komplexe Krankheitsbild von Long Covid und ME/CFS. Die Wirksamkeit einer Pille lässt sich einfacher testen, als die Wirksamkeit einer Therapie-Kombi, angepasst auf individuelle Symptome und den individuellen Lebenskontext einer Person. Das Design von medizinischen Studien ist grundsätzlich besser geeignet für klar messbare körperliche Probleme, für die es eine einzelne Intervention gibt.

Zum Beispiel ein Medikament. Und dann ist es auch noch eine Frage von der Verteilung von Forschungsgeldern. Iris Katharina Penner vom Inselspital Bern: Da muss man eben auch sagen, dass behaviorale Forschung, also wenn es jetzt nicht um Zellforschung geht, sondern um Verhalten oder eher um diese unsichtbaren Symptome, dass dafür viel, viel weniger Forschungsgelder gesprochen werden, auch vom SNF und von anderen Institutionen. Und das finde ich eigentlich nicht gerechtfertigt.

Und all das bringt uns zum allgemeinen Krankheitsverständnis, das wir als Gesellschaft haben. Das vorherrschende Paradigma, wenn man so will, die vorherrschenden Annahmen sind immer noch biomedizinisch. Wir sind wieder zurück bei den Erklärungen der Professorin Monika Greco. Das dominante Paradigma sei immer noch biomedizinisch. Das heisst, Krankheiten, die man messen und lokalisieren kann, werden kulturell höher gewertet, sind sozial anerkannter.

Ein Herzinfarkt oder ein Beinbruch zum Beispiel. Dort heisst es: aha, du hast das Bein gebrochen. Logisch, kannst du nicht arbeiten. Krankheiten, die weniger fassbar sind, die man nicht messen kann, wo man keinen Gips am Bein trägt, die werden weniger ernst genommen. Dort heisst es eher einmal: also kannst du nicht oder willst du nicht? Und diese Vorstellungen sind in all unseren Köpfen. Marlen Reusser: Schlussendlich sind die Patient:innen, wie ich, das Problem.

Hätte ihr eine Ärztin oder ein Arzt früher gesagt: Deine Symptome sind erlernt und du kannst sie wegbringen, indem du das Gehirn umprogrammierst – dann hätte ich gesagt: Ja, ich bin krank, hilf mir lieber! Dann fühlt sich niemand ernst genommen. Ich glaube, wenn wir in unsere Kultur bringen könnten, in unser Verständnis, dass das genau so echt ist und genau so da und real, egal was die Ursache ist oder wo das Huhn und das Ei ist, aber wenn man sich nicht kleiner fühlt wegen dem.

Warum braucht man immer das gebrochene Bein? Nicht alle Krankheiten werden gleich bewertet. Hat man keine messbare Ursache für seine Symptome, ist man nicht wirklich krank. Man ist irgendwie auch etwas selbst schuld. Man wird stigmatisiert. Monica Greco: Die moralische Last, das damit verbundene Stigma usw., ist fast so schlimm wie die Symptome selbst. Und wenn wir den neurobiologischen Erklärungen folgen, müssen wir annehmen, dass dieses Stigma usw.

die Prozesse verstärkt, die die Symptome verschlimmern. Und die Stigmatisierung macht die Symptome nur noch schlimmer. Bei Ärzt:innen, im Kontakt mit der IV oder auch am Arbeitgeber müssen Patient:innen häufig beweisen, dass sie wirklich krank sind. Und wirklich krank ist kulturell eher etwas körperlich Sichtbares. Es gibt wunderbare Forschungen von Nordischen Anthropolog:innen, die Interaktionen in Kliniken studiert haben. Und auch die Art und Weise studiert haben, wie Patient:innen über ihre Symptome sprechen, wenn sie ausserhalb der Klinik sind.

Studien zeigen, dass Patient:innen im medizinischen Kontext die rein körperlichen Aspekte ihrer Krankheit betonen. In der Hoffnung, man nehme sie so ernster. Weil sie denken, das ist der einzige Weg, wie sie von Ärzt:innen ernst genommen werden. Wenn sie nach Hause gehen, sprechen sie mit der restlichen Familie mit einem sehr unterschiedlichen Vokabular. Zuhause sprechen sie dann ganz anders darüber. Monica Greco zitiert eine treffende Aussage von Nortin Hadler, einem englischen Rheumatologen: Wer beweisen muss, dass er krank ist, kann nicht gesund werden.

Das liegt daran, dass all deine Energie darauf verwendet wird, deine Krankheit zu zeigen, sich der Krankheit zu ergeben und in deiner Krankheit zu verharren, anstatt in die Genesung zu investieren. Wenn du beweisen musst, dass du krank bist, kannst du nicht gesund werden. Alle Energie konzentriert sich aufs Kranksein statt aufs

Gesundwerden. Die Stigmatisierung von Symptomen, die keine strukturelle Ursache haben, ist fest in unseren Köpfen.

Ich würde mir wünschen, dass in unserer Kultur möglichst schnell eingeht, dass das nicht schlechter ist, sondern anders. Und dass, wenn der Arzt oder die Ärztin diese Therapie vorschlägt, man dann nicht denkt, der nimmt mich nicht ernst oder die nimmt mich nicht ernst und das hilft sowieso nicht. Die Vorstellungen davon, was als krank gilt und was nicht, können dazu führen, dass nur rein strukturelle Erklärungen zählen und alles andere abgewertet wird.

Besonders stark sichtbar ist das auf Social Media. Zum Beispiel auf dem Instagram-Profil von Marlen Reusser. Sie hat auf ihr Video, in das wir in der dritten Folge reingehört haben, sehr viele abwertende Kommentare erhalten. Von Leuten, die sagen: ja, ich hätte gar kein Long Covid gehabt oder ich könne es nicht wissen und es seien... einfach lauter solche Sachen und teilweise auch ein bisschen ja, wirklich nicht so toll. Die Privatnachrichten andererseits waren sehr positiv, wie sie auch schon erwähnt hatte.

Und auch jetzt noch – es ist ein Jahr vergangen – schreiben Leute, sie hätten das nachher wegen dem auch angefangen zu machen und sie seien jetzt auch geheilt und es gehe besser. Und das schreiben mir sehr viele Leute, aber das kommt immer als Privatnachricht und dann denke ich, da ist schon ein Bias da. Auch ich habe mit Menschen gesprochen, die genesen sind, die gerne ihre Erfahrungen mit anderen geteilt hätten. Um Mut zu machen und einen möglichen Weg aufzuzeigen.

Sie haben es aber nicht gemacht. Weil sie sich nicht getraut haben, etwas zu posten. Zum Beispiel in der Facebook-Gruppe des Vereins «Long-Covid Schweiz». Sie hatten die berechtigte Angst, dass ihnen die Krankheit und auch der Genesungsweg abgesprochen wird. Oder sogar, dass sie als Verräter:innen dargestellt werden. Auch mich hat der harsche Umgangston in dieser Debatte während der Produktion des Podcasts immer mal wieder beschäftigt.

Und es gab Momente, in denen ich wirklich gedacht habe: Komm, wir schmeisse es hin. Und ich habe mich dann gefragt: Was ist das Problem? Wenn dieser Ansatz auch nur einer einzigen Person zusätzlich helfen kann, dann wäre es für mich schon legitim, das zu erzählen. Und das fand ich sehr schade. Und teilweise waren die Kommentare auch unter der Gürtellinie, sehr unüberlegt. Leute, die sich öffentlich äussern, wie Marlen Reusser, werden zu einer Projektionsfläche.

Für all den Frust und Wut über die fehlende Anerkennung, die mangelnde Versorgung, uneinheitliche Informationen und die eigene Verzweiflung. Paul Garner, den wir in der zweiten Folge gehört haben, hat erzählt, er hätte sogar Morddrohungen bekommen. Und die Empörung von einem Teil der betroffenen Community wird dann wieder aufgenommen von Medien und auch der Medizin als «Stimme der Betroffenen». Marlen Reusser ist sich sicher: Das Wissen über das neuroplastische Entstehen von Symptomen wird in ein paar Jahren voll in der Praxis angekommen sein.

Es ist einfach unfassbar. Mittlerweile kann ich nur den Kopf schütteln ab uns. Es ist einfach eine Lücke. Das ist etwas, von dem man noch nicht begriffen hat, wie wichtig es ist. Was man oftmals noch komplett ignoriert. Monica Greco sieht den Wandel bereits im Gang. Der kulturelle Wandel – wir beginnen ihn bereits zu erleben. Vor 20 Jahren hätten wir dieses Gespräch nicht führen können. Vor 20 Jahren hätten wir nicht so über dieses Thema reden können.

Sie beobachtet, dass wir als Gesellschaft daran sind, ein Vokabular zu entwickeln rund um die neurobiologischen Erklärungen und das dysregulierte Nervensystem. Das Thema wird immer sichtbarer. Für mich gehört dazu auch die Gründung von Mind Body Schweiz. Ein Verein zur Behandlung von neuroplastischen Symptomen. Ihre allererste Versammlung war an einem sonnigen Freitagnachmittag Anfang März. Zwei Tage bevor wir den Podcast released haben.

Und ich war dabei. Ich begrüsse euch alle herzlich. Es ist mega cool, seid ihr hier. In der Länggasse in Bern trafen sich vier Menschen. Darunter Daniela Knap, die die Idee zur Gründung dieses Vereins hatte. Daniela studiert Gesundheitswissenschaften. Und ich bin vor zweieinhalb Jahren selber an Long Covid erkrankt. Ich bin dann irgendwie auf den Mind-Body-Ansatz gestossen, und dadurch gesund geworden. Ich habe jetzt auch meine Masterarbeit zu diesem Thema geschrieben und mich mit Leuten vernetzt.

Und dadurch ist die Idee entstanden, mit Alexandra den Verein zu gründen. Alexandra Burki ist seit 25 Jahren Craniosacral-Therapeutin und ausgebildete Pain-Reprocessing-Therapeutin. Mit dem neuroplastischen Ansatz konnte sie ihre eigenen Migräne-Beschwerden fast vollständig heilen. Ich habe im deutschsprachigen Raum nach Therapeutinnen, Ärztinnen gesucht, die mit diesem Ansatz arbeiten. Und es gibt bis jetzt noch sehr wenige. Und auf dieser Grundlage habe ich dann versucht, die, die es schon gibt, zusammenzubringen.

Zusammen mit anderen Betroffenen und Therapeutinnen haben Daniela und Alexandra den Verein ins Leben gerufen. Das Ziel des Vereins ist der Aufbau einer Website mit gesammelten Informationen auf Deutsch. Ausserdem wollen sie Therapeutinnen und Betroffene vernetzen. Und dafür haben sie auch schon eine konkrete Idee: nämlich ein Peer Support. Dass Leute vielleicht Fragen stellen können, wie das Leute, die genesen sind, gemacht haben, ob sie Tipps geben können.

Eine andere Idee ist vielleicht auch Gruppentreffen. Einmal im Monat ein Gruppenmeeting anzubieten, wo sich Betroffene austauschen können, ihre Erfahrungen teilen, dass man merkt, es geht allen gleich, alle haben Rückschläge, alle haben mal Zweifel und es ist kein linearer Prozess. Wir wissen alle, dass soziale Kontakte mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die gleiche Symptome haben, aber auch gleiches Wissen, eine grosse Chance darin liegt.

Also dass darin auch Heilung liegt und Genesung möglich ist. Auch die Hoffnung auf eine mögliche Genesung kann an sich schon zur Verbesserung der Symptome beitragen, wie sie auch selbst erlebt haben. Es gäbe nichts Schlimmeres, als keine Hoffnung mehr zu haben. Bis der Verein die erwähnte Webseite und den Peer Support aufgebaut hat, wird es noch etwas dauern. Sie machen das alles ehrenamtlich und nebenberuflich. Eine Domain und eine E-Mail-Adresse haben sie aber schon.

Die haben wir in den Shownotes verlinkt. Es sind Betroffene, ihre Angehörigen und engagierte Fachpersonen wie am Unispital Basel, die allen Widerständen zum Trotz diese Sache vorantreiben. Zu diesen Engagements gehören auch die Webseiten chronischbesser.ch von Serena und neurojackpot.com von Adrian und Samira. Schweizer Webseiten, die das Wissen für chronische Schmerzen schon seit 2021 respektive 2022 vermitteln. Und quasi mit dem Release von unserem Podcast wurde eine weitere Webseite spezifisch für Long Covid ins Leben gerufen: cfs-hilfe.ch von Cédric.

Wandel passiert. Aber er braucht Zeit. Betroffene aber brauchen jetzt eine Perspektive und Unterstützung. Darum diese Webseiten und auch der Podcast, den du am Hören bist. Es gibt bereits erste gegenkulturelle Entwicklungen in den Zwischenräumen, nicht unbedingt in den offiziellen Institutionen selbst. Hoffnung entsteht in den Zwischenräumen. In den Zwischenräumen, im gelebten Alltag, an den Orten, wo Menschen sich selbst organisieren und Dinge eigenständig in die Hand nehmen.

Genau dort liegt die Hoffnung. An den Orten, wo sich Menschen selber organisieren. Dort, wo sie die Sachen selber in die Hand nehmen. Dort ist Hoffnung. Da ist ein Riss, ein Riss in allem. So findet das Licht seinen Weg hinein. Du kannst die Einzelteile addieren, aber das Ganze wirst du so nicht erfassen. Du kannst zum Marsch aufrufen, dazu bedarf es keiner Trommel. So Long, Cohen. Die fünfte Folge vom Podcast «So long Covid».

Und die nächste Folge ist das grosse Finale dieser Podcast-Serie. Die kommt dann in zwei Wochen. Jann und ich gehen zurück nach Gais, zurück zu dem Ort, wo er vor zwei Jahren schwer krank eingeliefert worden ist. Krass, oder? Ja, schon. Als du angekommen bist, mussten wir einfach dort hochfahren und danach den Rollstuhl holen. Ja. Das kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Wir hören, wie der neuroplastische Ansatz das Leben von Jann, Jasna, Marlen und Patricia über Long Covid hinaus verbessert hat.

Seit Jahren habe ich an chronischen Nackenschmerzen gelitten. Und mit den gleichen Techniken konnte ich auch diese Symptome bekämpfen und verlernen. Zu merken, dort drinnen entstehen für mich wirklich Möglichkeiten für Genesung, und um wieder ins Leben zurückzukommen. Und das war ja dann auch so. Es war ein wahnsinniges Gefühl. In dieser Woche war ich wirklich so sehr ich selber. Ich war endlich wieder die fröhliche Person. Ja, und jetzt gehen wir wieder, ich weiss auch nicht, in die Aare schwimmen.

Und wir fragen uns, was braucht es jetzt? Was muss sich verändern? Und was bedeutet dieses neue Wissen für die Medizin? Es deutet auf eine Revolution hin, auf eine kleine, leise Revolution in der Medizin, die sich nach und nach zusammenbraut, Und ich zweifle keinen Moment daran, dass dies passieren wird. Das wird Mainstream

werden. Ob es noch zu meinen Lebzeiten passiert oder nicht, weiss ich nicht, aber es wird passieren. Die letzten Worte dieser Folge von Howard Schubiner.

«So Long Covid» ist eine unabhängige Podcast-Serie von Jann Zosso und mir, Zita Bauer. Falls dir der Podcast gefällt und du das Thema wichtig findest freuen wir uns, wenn du ihn weiterempfehlst. Die Bewertung im App hilft uns, dass wir von anderen gefunden werden. Wir haben einen Ausschnitt aus «Anthem» von Leonard Cohen gehört. Die restliche Musik ist komponiert von Janos Mijnsen und Moritz Widrig. Mastering, Mix und Sounddesign: Christina Baron. Dramaturgische Beratung: Franziska Engelhardt.

Redaktionelle Mitarbeit: Stella Bollinger. Sprechregie: Irene Müller. Aufnahmestudio: Radio RaBe. Host und Schnitt: Zita Bauer. Produktion, Konzept und Redaktion: Jann Zosso und Zita Bauer. Alle Infos über den Podcast findest du auf unserer Website: solongcovid.ch

SO LONG COVID

Folge 6: Status nach

Lesefassung der deutschen Untertitel

Du hörst die sechste Folge des Podcasts «So Long Covid». Die sechs Folgen sind aufbauend. Falls du die erste noch nicht gehört hast, fängst du am besten dort an. Hallo, Zita. Das ist eine Sprachnachricht von Jann. Aus der Zeit, als er in der Reha-Klinik war. Im Frühling 24. Schwer krank lag er die meiste Zeit im abgedunkelten Zimmer. Wegen seiner Lichtempfindlichkeit. Erst wenn die Sonne untergegangen war, konnte er die Vorhänge am Fenster öffnen: Ja, ich wollte dir nur erzählen, dass gestern wieder ein ganz klarer Abend war.

Dann hat man die Sterne gesehen. Und vor allem sieht man einen Stern gut von meinem Zimmer aus. Der ist ganz hell, den man schon als Ersten sieht. Der ist noch tief am Horizont. Und das ist anscheinend der hellste Stern des Nordhimmels. Der Stern, von dem Jann erzählt, heisst Arktur. Und weil er so hell ist und so tief am Horizont, dass man ihn schon sieht, flimmert er so. Ich habe das Gefühl, wegen der Atmosphäre zittert er in verschiedenen Farben.

Und weil ich ja abends zittere, oder auch den ganzen Tag, habe ich mich sehr verbunden gefühlt mit diesem Stern. Jetzt habe ich schon ein paarmal den Stern beobachten können. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Er ist der hellste Stern am Nordhimmel und befindet sich in der Verlängerung des grossen Bären. Man nennt ihn darum auch Bärenhüter. Was machen wir jetzt? Wir fahren nach Gais. Gees sage ich. Jann und ich fahren nach Gais.

Gees auf Senslerdeutsch. Oder: Gääs. So sagt es nämlich im Appenzell richtig. Im Sommer 25, gut ein Jahr nach seinem Klinikaufenthalt, ist Jann wieder gesund. Und wir gehen zusammen zurück an den Ort, wo die Wende passiert ist. Wir wollen den Sternenhimmel beobachten. Und vor allem: Den Stern "Arktur" sehen. Es wird schon dunkel. Muss ich jetzt da geradeaus? Das ist perfekt für die Sterne. Ja, aber es hat Wolken. Es wird nichts mit Arktur.

Es hat schon den ganzen Tag geregnet. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir heute die Sterne sehen werden. Ausser es passiert noch ein Wunder. Das würde ja noch passen. Jetzt muss ich da links. Ja. Schau, da steht Gais. Hello Guys. Jetzt also auch noch auf Englisch. Haha, du hast einfach darauf gewartet, dass du das sagen kannst. Schau, jetzt sind wir da. Krass, ist das jetzt das erste Mal, dass du ...? Ich glaube, ja. Schon krass.

Ich weiss. Jann und ich sagen dauernd «krass» in dieser Aufnahme. Aber das war es halt auch für uns. Steigen wir aus? Ja. Krass, oder? Ja, schon. Ja, und schon krass, als du angekommen bist, mussten wir einfach dort hochfahren und nachher den Rollstuhl holen. Ja. Kann man sich schon nicht mehr vorstellen. Ich bin Zita Bauer und das ist der Podcast «So Long Covid». Die sechste Folge «Status nach». Das ist der Abschluss dieser sechsteiligen Podcast-Serie.

Wir kommen zurück zu den Geschichten von Jann, Jasna, Marlen und Patricia. Was bleibt von ihrer Erfahrung, an Long Covid erkrankt und wieder genesen zu sein? Und wir schauen nach vorne. Wir beleuchten das Potenzial des neuroplastischen Ansatzes nicht nur für Menschen mit der Diagnose Long Covid, sondern auch für Menschen mit Reizdarm, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen oder anderen chronischen Symptomen. Und suchen Antworten auf die Fragen: Wie können wir als Gesellschaft die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Menschen wieder genesen können?

Und was braucht es, damit die Beschwerden vielleicht gar nicht erst so schlimm werden? Zuerst aber noch einmal zurück nach Gais. Wir sind in der Reha-Klinik und erinnern uns an Janns Aufenthalt dort. Wir stehen hinter dem Gebäude. Es hat dort einen Aussenbereich mit einer Terrasse, einem Barfussweg und einer kleinen Betontreppe. Die erste Treppe, die ich wieder hochgelaufen bin, nach Monaten ohne Treppe. Fünf Stufen. Und dann bist du da unten gestanden und dann hat es mega Überwindung gebraucht?

Ja, weil ich einfach nicht wusste, was passiert. Ist das wieder zu viel oder nicht? Jann hatte zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon ziemlich Vertrauen gefasst, dass seine Symptome einen neuroplastischen Ursprung haben. Man

hat sich freuen können, dass es jetzt geht, aber man war halt nicht sicher, Kommen diese Symptome dann halt so typisch zeitversetzt trotzdem wieder? Und so war eine gewisse Unsicherheit doch noch da. Ja, schon krass.

Jedes Mal, wenn die Symptome nicht so schlimm kommen wie erwartet, wird das Vertrauen in den eigenen Körper gestärkt. Und wenn die Symptome doch kommen, ist es wichtig zu wissen: Das ist normal. Die neuronalen Bahnen verschwinden nicht sofort. Aber dann hilft das Vertrauen, dass diese Symptome nichts Schlimmes bedeuten. Das Gehirn will einen schützen, aber es ist ein Fehlalarm. Man ist in Sicherheit. Mit der Zeit beruhigt sich das Nervensystem und es gibt immer weniger Symptome.

Und man kann Schritt für Schritt die grosse Fragilität hinter sich lassen. Jann ist schlussendlich knapp zwei Monate in der Reha-Klinik geblieben. Obwohl er nach der ersten Woche fast nach Hause geschickt worden wäre, weil es ihm zu schlecht ging. Davon haben wir in der ersten Folge erzählt. Und in dieser schlimmen ersten Zeit in der Rehaklinik ist das mit dem Guardian-Artikel passiert. Uns ist eine neue Welt aufgegangen mit diesen neurobiologischen Erkenntnissen.

Wir haben realisiert: Janns Körper ist nicht per se kaputt, sondern seine Symptome sind erlernt. Und es gibt konkrete Behandlungstechniken dafür. Und mit diesem Wissen ... waren die Therapien in der Klinik eigentlich super. Aber eben mit dem Wissen, dass ich gesund werden kann, und auch, dass sein Körper nicht irreparabel geschädigt ist, sagt Jann. Mit dem Wissen und Vertrauen, dass seine Symptome einen neuroplastischen Ursprung haben, hätten die Therapien in der Klinik auf einer anderen Ebene gewirkt.

Autogenes Training oder die körperlichen Aktivierungen zum Beispiel. Er habe dann gewusst: Mit diesen Therapien verknüpfe ich aktiv die neuronalen Bahnen neu und beruhige das Nervensystem. Ich trage aktiv zur Genesung bei. Und so hat sich sein Zustand verbessert. Aber das war erst möglich, als er sich vom gängigen Narrativ über Long Covid abgewendet hat. Also weg vom symptom-basierten Pacing, weg vom Energiemanagement und der Idee von einem unveränderbaren, tiefen Leistungsniveau und weg von der Annahme, dass Crashes den Zustand langfristig verschlechtern und Symptome unumkehrbar chronifizieren.

Erst dann konnte er wirklich von den Therapien in der Reha-Klinik profitieren. Und das hat bedeutet, dass er sich permanent abgrenzen musste von dem, was dort erzählt wurde. Vom medizinischen Personal und auch von anderen Patient:innen. Bei Jann ging es dann schnell. Eineinhalb Monate und er konnte schon wieder auch längere Strecken laufen. Und nach zweieinhalb Monaten ist er wieder auf den Berg gewandert. Das war eindrucklich.

Auch für mich zum Miterleben. Wirklich fast ein bisschen wie ein Wunder. Es ist aber jeder Weg individuell. Das muss man akzeptieren. Und das ist auch nicht einfach, weil man als Betroffene Verbesserungen kaum erwarten kann. Auch Jasna kennt das gut. Trust the process. Sich selbst gut zuzureden kann dabei helfen, neue neuronale Verknüpfungen zu schaffen. Sie hat sich fast mantraartig immer wieder gesagt «Hey, dein Körper ist gesund, dein Körper ist gesund, dein Körper ist gesund.»

Auch wenn der Körper sich noch wahnsinnig krank angefühlt hat. Um dran zu bleiben, hat sie sich ein Ziel gesetzt. Expert:innen raten ja, man sollte sich nicht ganz so fest ein Ziel setzen, weil sonst will man es zu fest. Aber mein Ziel war schon ein bisschen, dass ich auf einen Skihochtourenkurs würde gehen können. So einen Kurs, den sie damals absagen musste. Und ja, ich denke, das hat mir schon geholfen, dran zu bleiben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu fest gepusht.

Aber irgendwie schon: Hey, du schaffst das! Sich zu fest zu pushen, etwas erzwingen zu wollen, kann kontraproduktiv sein. Hilfreicher ist es, mit einer Grundhaltung von Gelassenheit daran heranzugehen. Das ist nicht ganz einfach. In eine Genesung spielen ganz viele Faktoren mit hinein, Die man auch nicht alle versteht. Was sicher ist, man ist auf Unterstützung angewiesen. Wenn eine Person an Long Covid erkrankt, wird das eine Belastungsprobe für das ganze Umfeld.

Es war eine harte Zeit, sehr hart. Es ist extrem schmerzhaft, auch für Kinder. Patricia hat zwei Kinder. Sie waren 10 und 14, als sie krank wurde. Und den Weg finden, ihnen das zu erklären. Wir hatten zum Glück auch viel Unterstützung. Andere haben sich eingeklinkt, mitgeholfen und das Familiensystem unterstützt. Das ist ja sowieso verrückt, was bei diesen Long Covid-Geschichten, was das Umfeld an Arbeit leistet, an Unterstützung.

Das ist eindrücklich und gleichzeitig etwas, was wir auch vom System her mal anschauen müssten. Was es eigentlich auch braucht an Finanzen oder an Möglichkeiten, den Leuten nochmal anders zu helfen. Patricia, Jann, Jasna und Marlen konnten von Long Covid und ME/CFS genesen. Und sie sind keine Einzelfälle. Das haben uns die vielen Gespräche mit Betroffenen und Expert:innen während unserer Recherche bestätigt. Mit der Veröffentlichung des Podcasts haben uns auch noch weitere Personen geschrieben.

Eva zum Beispiel. Es tut so gut zu hören, wenn der eigene Genesungsweg, den man alleine und mit richtig viel Widerstand vom System gegangen ist, validiert wird. Oder Mona. Ich mache sehr gute Erfahrungen mit Pain Reprocessing Therapy. Und euer Podcast gibt mir Mut und Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Oder auch Menschen, die schon in den fünf Wochen, seit der Podcast raus ist, eine Veränderung spüren. Tamara zum Beispiel hat uns vor ein paar Tagen geschrieben, dass sie zum ersten Mal wieder eine kleine Runde joggen konnte.

Hey Tamara, wir freuen uns so fest mit dir! Gleichzeitig bekommen wir auch Nachrichten, die uns bestätigen, Wie dringlich es ist, dass sich etwas verändert. Nachrichten von Betroffenen, die ihre Ersparnisse für Therapien ausgegeben haben, die schlussendlich nichts genützt haben. Von ratlosen Eltern, die nicht mehr weiter wissen. Und von verzweifelten Betroffenen, die schreiben, dass sie durch unseren Podcast zum ersten Mal seit langem wieder ein wenig Hoffnung spüren.

Die Dringlichkeit für Veränderung ist gross. Das ist unbestritten. Was braucht es also, damit sich die Situation für Betroffene verbessert? Mehr Forschung. Darin sind sich alle Expert:innen einig, mit denen ich gesprochen habe. Forschung in alle Richtungen. Ich halte es für nicht ausgeschlossen, dass man für eine Subgruppe oder vielleicht auch mehr als eine Subgruppe irgendwann noch einen Marker findet. Das ist möglich. Katrin Bopp, Leiterin der Post-Covid- Sprechstunde am Universitätsspital Basel.

Es ist wichtig, auch weiterhin nach Markern, also möglichen strukturellen Schäden, zu suchen. Gleichzeitig gibt es mit dem neuroplastischen Ansatz für viele Betroffene schon heute ein plausibles Modell, das therapeutisch relevant ist und eine Genesungsperspektive eröffnet. Da sieht sie keinen Widerspruch. Da geht es nicht um entweder oder, um die eine Wahrheit, sondern es geht um neurobiologische Erkenntnisse, deren Nutzung vielen Menschen eine Genesung ermöglicht hat.

Weil sie aktuell am vielversprechendsten sind, braucht es besonders mehr Studien zu Behandlungsmethoden, aufbauend auf diesen neurobiologischen Erkenntnissen. Ich wünsche mir, dass uns genügend Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass wir das weiterdenken und uns weiter vernetzen können und das Angebot mehr Betroffenen zur Verfügung stellen können. Es braucht ein breiteres und umfassenderes Therapieangebot, das die neurobiologischen Erkenntnisse mit einbezieht.

Die Krankheitsbilder von Long Covid sind vielfältig und komplex, wir haben es gehört. Darum sei es auch wichtig, dass zusammengearbeitet wird, über Abteilungen und Disziplinen hinaus. sagt Rainer Schäfer, Professor und Chefarzt für Psychosomatik am Universitätsspital Basel. So wie wir aufgestellt sind, erlebe ich, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ist aber auch etwas, was im Endeffekt Unterstützung braucht, auch von der Gesundheitspolitik.

Weil zum Teil die Tarifierung von Leistungen so gestrickt ist, dass wir eher in Silos reingetrieben werden immer wieder. Ganz fokussiert irgendwelche isolierten Leistungen erbringen. Und dann wird der Patient wieder weggeschickt. Und das macht nichts besser. Theoretisch ist man sich in der Medizin einig, dass Krankheiten biopsychosozial verstanden werden müssen. praktisch aber wird häufig nicht entsprechend gehandelt. Auch weil das Gesundheitssystem nicht dafür ausgelegt ist.

Es ist schlussendlich also auch eine politische Frage. Es braucht Rahmenbedingungen, die Genesung fördern. Also zum Beispiel, dass Betroffene unkompliziert finanziell abgesichert werden. Die Abklärungen mit der IV und allgemein finanzielle Sorgen sind aktuell eine grosse Zusatzbelastung für viele. Und können Symptome verschlimmern. Dass etwas gehen muss, ist auch der Schweizer Politik bewusst. Das Parlament hat im vergangenen Herbst den Bundesrat beauftragt, eine nationale Strategie auszuarbeiten.

Um die Situation der schätzungsweise 300'000 bis 450'000 Menschen mit ME-CFS und Long Covid zu verbessern. Es geht dabei um eine nationale Stossrichtung und Koordination. Und ein Ziel ist eben eine

angemessene Unterstützung durch Sozialversicherungen. Im Moment laufen die Vorarbeiten zu dieser Strategie. Man führt Gespräche mit verschiedensten Akteuren. Zudem braucht es mehr Aufklärung über dieses Wissen in der Gesellschaft. Und damit auch eine Anerkennung von neuroplastischen Symptomen.

Das würde auch präventiv wirken. Wenn ich mir überlege, wie es hätte sein können, wenn ich schon ganz am Anfang der Krankheit von diesem Ansatz erfahren hätte ... Wenn man neuroplastische Symptome früh erkennt und gezielt darauf reagiert, kann man verhindern, dass sich Muster verfestigen und Symptome chronisch werden. Man kann verhindern, dass es so lange und so schlimm wird. Darum habe ich auch keine Angst mehr vor Rückfällen.

Jetzt habe ich den neuroplastischen Mechanismus verstanden und weiss, was ich machen kann, falls ich in Zukunft wieder einmal Symptome haben sollte. Ich habe vollstes Vertrauen, dass ich nicht mehr in eine solche Abwärtsspirale gerate. Wir haben die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und der Schmerztherapie in diesem Podcast hauptsächlich im Zusammenhang mit Long Covid besprochen. Die Tragweite ist aber noch viel grösser. Dies ist uns während der Recherche immer klarer geworden.

Die westliche Medizin hat in den letzten zwei Jahrhunderten unglaubliche Fortschritte darin erzielt, dass wir an Krankheiten, die früher noch tödlich waren, nicht mehr sterben. Antibiotika, Operationen, Impfstoffe und so weiter. Dies hat unsere Lebenserwartung drastisch erhöht und ist in vielerlei Hinsicht ein Segen. Gleichzeitig gibt es immer mehr chronische Erkrankungen. In der Schweiz leben schätzungsweise eineinhalb Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen.

Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne und Muskel- und Gelenkschmerzen sind die häufigsten. Jede sechste Person ist betroffen. Dazu kommen Menschen mit Reizdarm, Tinnitus, Schlafstörungen, Schwindel, funktionellen neurologischen Störungen und noch viele mehr. Die Liste ist lang. Chronische Symptome sind allgegenwärtig und gleichzeitig irgendwie unsichtbar. Sie sind zum Teil extrem einschränkend im Alltag, aber die Betroffenen lernen damit zu leben.

Auch für diese Beschwerden gibt es eine neue Perspektive. Ich glaube, dass die Ansätze, neuroplastische Symptome, da viel Potenzial haben, Innovation zu bringen und neue Wege zu öffnen. Rainer Schäfer vom Universitätsspital Basel: Und es ist wirklich stark der Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass das nicht auf einzelne spezielle Symptome beschränkt ist, sondern dass sich das verallgemeinern lässt oder dass sich das bezieht im Endeffekt praktisch auf jede Art von Körperbeschwerden.

Es ist also noch grösser. Bei jeder Erkrankung oder Verletzung – und besonders bei lang andauernden – können Lernprozesse im Gehirn eine Rolle spielen. Selbst wenn wir organisch bedingte Beschwerden haben, bei Schmerzbeschwerden zum Beispiel, sehen wir über die Länge, über die Dauer, über die Chronizität hin, sehen wir auch bei diesen Beschwerdebildern eine zentrale Sensitivierung des Gehirns für diese Beschwerden. Auch dort bilden sich entsprechende neuronale Netzwerke aus, die dann diese Beschwerden auch weiter verstärken.

Das muss nicht die alleinige Ursache sein, aber das ist dann eine Verstärkung und Verschlechterung dieser Beschwerden, die ähnlichen Mechanismen folgt. Auch wenn ein struktureller oder organischer Schaden vorliegt, entsprechen die Symptome also nicht zwingend dem messbaren Schaden. Das ist in der Medizin eigentlich ein bekanntes Phänomen. Bei Bandscheibenvorfällen beispielsweise. Im MRI kann jemand eine starke Abnutzung zeigen, aber wenig Schmerzen haben.

Oder umgekehrt. Die Symptome korrelieren also nicht unbedingt mit messbaren Parametern. Das müsste man bei der Behandlung mitdenken. Bei einem strukturellen Befund braucht es eine medizinische Versorgung auf der körperlichen Ebene. Keine Frage. Und gleichzeitig gilt es auch, den neuroplastischen Anteil entsprechend zu behandeln. Das ist ein noch nicht ausgeschöpftes Potenzial. Ein Potenzial, das noch grösser ist für all die Erkrankungen, bei denen man keine strukturellen Schäden findet.

Es ist ein Perspektivwechsel. Weg von der Idee, dass man für jedes einzelne Symptom eine eigene Lösung braucht. Hin zu einem Verständnis, dass oft ähnliche Mechanismen im Nervensystem dahinter stehen. Jann, der Physiker ist, spricht von einer kopernikanischen Wende in der Medizin: Also ja, ich sehe es ein bisschen so. Ich sehe eine Ähnlichkeit zu so einem Perspektivenwechsel, wo auf einer anderen Grundlage plötzlich alles viel mehr Sinn macht als vorher.

Kopernikus war der, der erkannte, dass Planeten nicht um die Erde, sondern um die Sonne kreisen. Mit diesem Perspektivwechsel haben die Bahnen der Planeten plötzlich Sinn gemacht. So wie auch die Symptome von chronischen Beschwerden mit dem neuroplastischen Verständnis plötzlich schlüssig erklärt werden können. Genau dann machen nachher plötzlich all die verschiedenen chronischen Krankheiten, bei denen man nicht verstanden hat, wie sie genau funktionieren, warum verhalten sie sich so? Sie haben nicht in das System gepasst.

Und mit einem neuroplastischen Verständnis machen all diese chronischen Krankheiten plötzlich viel mehr Sinn und haben quasi ihren Platz im Sonnensystem. Eine kopernikanische Wende. Ein Perspektivwechsel bringt viele verschiedene Symptome in einen logischen Zusammenhang. Also die Symptome kreisen dann um die Sonne. Genau. In schönen Bahnen, die man erklären kann, warum ... In neuronalen Bahnen. Eine kleine Revolution in der Medizin.

Das Ziel bei chronischen Erkrankungen ist bis jetzt meistens Symptomlinderung. Lernen damit zu leben. Die Erkenntnisse aus der Neurobiologie und Schmerztherapie stellen das grundsätzlich infrage. Sie gehen davon aus, dass Genesung möglich und realistisch ist. Das ist die Revolution, die schon voll im Gang ist. Am Universitätsspital Basel haben sie mit Fatigue- und Long-Covid-Patient:innen angefangen. Mittlerweile wenden sie das Wissen immer mehr auf alle möglichen chronischen Körperbeschwerden an.

So hat es auch Jann gemacht. Seit Jahren habe ich an chronischen Nackenschmerzen gelitten, wo ... wo er schon zu x-verschiedenen Physios und Osteos gegangen ist, aber es nie wirklich besser wurde. Und auch ein Restless-Legs-Syndrom. Das ist so ein ganz komisches und unangenehmes Gefühl in den Beinen, aber auch in den Armen sein kann oder quasi am ganzen Körper. Jahrelang hat Jann, der heute 33 ist, gehört, man wisse nicht, was die Ursache davon sei.

Man könne leider nichts machen. Und tendenziell werde es mit dem Alter eher immer schlimmer. Und mit den gleichen Methoden konnte ich jetzt genau auch diese Symptome bekämpfen und verlernen. Heute hat Jann nur noch ganz selten Nackenschmerzen und Symptome des Restless-Legs-Syndroms. Die Geschichte von Jann hat dann auch bei Jasna, die Jann von früher kennt, einen Gedanken ausgelöst, der im klassischen Verständnis einer chronischen Krankheit eigentlich gar kein Platz hat.

Im Gespräch mit Jann, als wir uns zum ersten Mal wieder getroffen haben und uns ausgetauscht haben, hatte ich wie eine Vision. Damals ging es mir noch nicht so gut, da war ich noch ganz am Anfang. Aber ich habe schon ein wenig das Ziel gesehen. Und dann habe ich ihm gesagt: ja, ich möchte einfach eines Tages, - und das muss nicht in einem Monat sein, vielleicht ist es auch erst in zwei Jahren, da sollte man sich ja nicht so festlegen - aber ich möchte zu meiner Hausärztin gehen gehen und ihr sagen, sie soll "Status nach" vor meine Diagnose hinschreiben.

Das macht man ja so in der Medizin, wenn etwas vorbei ist, dann schreibt man "Status nach". Und für mich ist das ein wenig ein Widerspruch. Wenn du eine Diagnose hast, post-virale ist chronische Fatigue, dann ist das eigentlich eine Lifetime-Diagnose. Und wenn man dann da "Status nach" davor schreiben kann, ist das ein Widerspruch, ein bisschen. Aber ein schöner. Jasna hat sich lange geärgert vor der Diagnose Post Covid und Chronisches Fatigue-Syndrom in ihrer Akte.

Als Ärztin wusste sie genau, was das bedeutet. Chronisch heisst lange andauernd. Häufig ohne absehbares Ende. Bis sie aufs neuroplastische Krankheitsverständnis gestossen ist. In diesem Podcast haben wir Jasna ein Stück auf dem Weg zurück ins Leben begleiten können. Von dieser Vision, die sie vor gut einem Jahr hatte, von ihrem grossen und damals illusorischen Wunsch, wieder Skitouren zu machen. Bis zum Sommer 25, als ich die Interviews mit ihr geführt habe und es ihr schon wieder viel besser ging.

Und vor ein paar Wochen, im Februar 26, habe ich dann diese Sprachnachricht bekommen: Hey Zita, ich wollte mich kurz bei dir melden. Mir geht es gut. Und ich war da gerade auf einem Gipfel. Bin 1400 Höhenmeter problemlos hochgelaufen. Ich war total fit. Und ich habe so viele positive Gedanken über meinen Körper. Und merke, dass es wirklich anders ist. und dass ich wirklich wieder Vertrauen habe. Es ist echt fantastisch. Ja, ich sehe den Gipfel noch.

Ich konnte das leider nicht auf dem Gipfel aufnehmen. Weil es ein bisschen stressig war und nicht so schönes Wetter. Aber es ist toll. Es ist toll. Vor allem für Jasna, die jetzt tatsächlich wieder Skihochtouren erleben kann.

Aber auch für mich ist so eine Nachricht emotional. Einerseits, weil ich Jasnas Weg nah mitbekommen habe und es mich so freut für sie. Und andererseits, weil es mich an die schwere Zeit erinnert, die ich mit Jann durchgemacht habe.

Und es mich einfach so glücklich macht, dass er heute wieder gesund ist. Die beiden, Marlen und Patricia, können heute wieder alles machen, was sie vor ihrer Erkrankung gemacht haben. Genesungsgeschichten wie ihre können mögliche Wege aufzeigen für andere Betroffene. Und auch, dass man diesen Symptomen nicht hilflos ausgeliefert ist. Zum Glück. Weil Betroffene sind jetzt krank. und können nicht warten, bis die Erkenntnisse angekommen sind und Politik und Medizin sich revolutioniert haben.

Es ist wirklich eine Handlungsmacht, die wiedergekommen ist. Weil ich derart ohnmächtig war. Weil ich einfach quasi nichts mehr machen konnte von all dem, was ich sonst selbstverständlich machen konnte und was mich auch ausgemacht hat. Und die Erfahrung von wirklich nicht wissen, inklusive auch der Spitzenmedizin, die auch nicht wirklich weiss, wie es weitergeht. Das war sehr schwierig. Und dann zu merken: daraus entstehen neue Handlungsmöglichkeiten über diesen extrem ungewöhnlichen Weg, den ich auch zuerst entdecken musste.

Genesungswege sind einzigartig. Und gleichzeitig haben Patricia, Jann, Jasna und Marlen ähnliche Schritte durchlaufen. Sie haben von anderen erfahren, die mit dem neuroplastischen Ansatz genesen sind. Sie haben Hoffnung geschöpft und Aha-Momente erlebt. Sie haben sich das Wissen über Online-Ressourcen und Bücher angeeignet. Und mit verfügbaren Therapieformen quasi trainiert. das Nervensystem beruhigt und die Symptome uminterpretiert.

Bodyscan, Yoga Nidra, Journaling oder auch Hypnotherapie, Physiotherapie usw. Man muss für sich herausfinden, was einem am meisten entspricht. Also das war dann auch sehr bewegend und berührend, zu merken, wie ich relativ schnell aus den schlimmsten Zuständen herausgekommen bin und wieder habe laufen können und all die Sachen zurückgekommen sind. Da habe ich einfach sehr schnell das Bedürfnis gehabt, das weiterzugeben. Genesungsgeschichten können Mut machen, aber auch Schuldgefühle und Druck auslösen.

Ich habe auch immer wieder gemerkt, dass Betroffene aus guten Gründen sagen, also erstens haben sie schon 100'000 Ratschläge bekommen und dann ist es auch nicht so einfach, wenn man schon lange damit kämpft und dann kommt jemand und sagt, mir geht es so viel besser. Also das sind alles ganz, ganz schwierige Grundlagen auch für einen Austausch. Ein neuroplastisches Syndrom ist etwas, das einem passiert – wie andere Erkrankungen auch.

Man kann nichts dafür. Es spielen ganz viele Faktoren hinein, die wir noch nicht alle verstehen. Von der persönlichen Geschichte und Lebenssituation über körperliche und genetische Voraussetzungen, Vorerkrankungen hin zu gesellschaftlichen Bedingungen. Und darum ist auch der neuroplastische Ansatz vielleicht nicht der Weg für alle. Long Covid ist eine schlimme Krankheit, unter der ganz viele Menschen leiden. Das Nicht-ernst-Nehmen der Beschwerden, eine Stigmatisierung oder zusätzliche Belastungen wie finanzielle Sorgen können alles nur noch schlimmer machen, wie wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben.

Aber die Geschichten, die wir in diesem Podcast gehört haben, zeigen: Es gibt einen möglichen Weg hinaus. Es war eine harte Zeit, die die vier und ihre Angehörigen durchgemacht haben. Aber auch eine lehrreiche. Zu merken, das ist jetzt auch eine geteilte Erfahrung, die wir alle miteinander gemacht haben. Man kann ganz schlimm krank sein, man kann wieder gesund werden. Auch hier gibt es so ein Glück, das wir im Nachhinein teilen.

Manchmal reden wir auch darüber. Und sagen: du weisst noch, du hast mich damals im Spital besucht. Und es war so traurig. Und jetzt gehen wir wieder, ich weiss auch nicht, in die Aare schwimmen. Die Radsportlerin Marlen Reusser nimmt ihre Erkenntnis auch mit aufs Rennrad. Viele haben so den Glaubenssatz oder sagen zumindest so: der Kopf ist alles. Das hört man viel im Spitzensport. Aber ich glaube nicht, viele glauben es wirklich.

Oder verstehen, dass sie der Kopf sind und es in der Hand haben. Und ich glaube, mir hat das extrem so eine Erkenntnis von Selbstwirksamkeit gegeben, die ich vorher nicht so hatte. Das Erleben gibt ein anderes Niveau von Verständnis. Ich weiss nicht, wie ich das alles verstanden oder begriffen hätte, wenn es nicht so dringend gewesen wäre und ich mich nicht einfach darauf eingelassen hätte, weil ich gedacht habe, ja ich möchte gern mein Leben zurück.

Wenn man mir gesagt hätte, hier gibt es eine Pille gegen Long Covid, oder du musst diesen ganzen Weg gehen. Ich meine, da hätte ich auch die Pille genommen. Ich kann es dir ganz ehrlich sagen. Es ist einfach einfacher. Wirst du sie jetzt auch im Nachhinein nehmen? Gute Frage. Nein. Wenn ich jetzt im Nachhinein meinen Weg anschau ... Klar, ich hätte mir Leiden ersparen können und ich habe gelitten. Ich sage es einfach so. Aber ich habe so viele Erkenntnisse gewonnen für mich.

Es ist wirklich so bereichernd. Und ich habe jetzt Tools. Ich habe Tools, wie ich mit Sachen umgehen kann, wie ich Sachen angehen kann, wie ich Emotionen spüren kann oder schauen kann, was in mir vorgeht. Es ist Wahnsinn. Und ich glaube, ich möchte das irgendwie trotzdem nicht missen. Siehst du den Stern? Oder ist das kein Stern? Ist das nicht das Licht auf dem Säntis ... Wir sind noch einmal in Gais im Appenzellerland. Jann und ich wollten den Sternenhimmel beobachten.

Du erinnerst dich. Es hat den ganzen Tag geregnet. Jetzt aber hat es aufgehört. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Wir warten einfach, bis wir ihn sehen. Arktur, den hellsten Stern am Nordhimmel. Der geflackert und gezittert hat, wie Jann ... Da konnte ich mich ein bisschen damit trösten, dass ich nicht allein bin in der Unruhe. Ehrlich gesagt ist es gar nicht so wichtig, ob wir ihn wirklich sehen, den Arktur. Wenn wir etwas gelernt haben in dieser krassen Zeit in den letzten Jahren, dann: dass Wunder in den kleinen Dingen versteckt sind.

Zum Beispiel in der Fähigkeit, auch einen Regentag geniessen zu können. Ist er das? Ich glaube nicht. Aber sie kommen wirklich hervor ... Nicht wahr? Oh, aber jetzt musst du schnell machen. Jann hat auf seinem Handy eine App, um Sterne zu bestimmen. Oh ... Es könnte ihn tatsächlich sein! Ist das Arktur? Ja, das ist er. So cool. Es ist einfach der einzige Stern, den man sieht. Ist krass. Zum Glück hast du so einen hellen ausgewählt.

Das war der Podcast «So Long Covid», "Status nach", die sechste und letzte Folge. Das war's – danke fürs Zuhören und eure Nachrichten, über die wir uns unglaublich freuen. So Long Covid ist eine unabhängige Podcast-Serie. Von Jann Zosso und mir, Zita Bauer. Wir freuen uns sehr, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Über unsere Website kannst du uns auch mit einem finanziellen Beitrag unterstützen. Alle Infos über den Podcast findest du auf solongcovid.ch.

Übrigens, Jann ist noch einmal zurück in die Reha-Klinik, nicht als Patient, sondern als Referent. So, jetzt mache ich wieder einmal eine Sprachnachricht. Das war vor drei Wochen, Ende März 2026. Ich bin jetzt gerade in Gais. Ich war gerade in der Reha-Klinik ... Oh, da ist es ein bisschen schlimm mit diesem Hahn. Ich bin gerade in Gais, war in der Reha-Klinik Jedes Mal... und habe in einer sogenannten Resilienz-Gruppe, also einer Gruppentherapie in der Reha-Klinik, wo alle Long-Covid-Betroffenen zusammenkommen, einmal oder zweimal pro Woche ...

Und in dieser Resilienzgruppe war ich jetzt dabei und habe von meinem Weg - wie ich genesen bin - erzählt. Und dann konnten sie auch Fragen stellen. Und es war irgendwie sehr schön. Sie haben dann auch noch dreimal nachgefragt, was das jetzt bedeutet, ob ich jetzt wieder alles machen kann und keine Pausen mehr machen muss. Und ob ich keine Angst mehr habe, dass es wiederkommt. Ja, voilà. Das war der kleine Bericht. Tschüss.